

La salut mental a Catalunya: entre el discurs institucional i la **pràctica real.**

*Una anàlisi des de l'experiència dels professionals
de la psicologia clínica.*

La salut mental a Catalunya: entre el discurs institucional i la pràctica real

Una anàlisi des de l'experiència dels professionals de la psicologia clínica

© 2026, de l'edició: Societat Catalana de Psicologia Clínica – ACAPIR

Barcelona, juny de 2026

COORDINACIÓ I REDACCIÓ

Jesús López Gómez

María José Miñano Valero

GRUP DE TREBALL I COAUTORS DE CONTINGUT (PER ORDRE ALFABÈTIC)

Mariona Aparicio Muñoz, Núria Batlle i Nicolau, Emma Bonamaisó Nogué, Bernat Carreras Marcos, Lorena Carrascal Granados, M^a Àfrica Cruz García, Patricia Escalona Zorita, Miguel Garriz Vera, Carla Mariscal Plaza, Jordi Mestres Carbonell, Neus Miquel Giner, Cristina Tablero Nadal, Berta Vilaseca Garcia.

Tots els autors i coautors són especialistes en Psicologia Clínica (PEPC) o residents de Psicologia Clínica (PIR), i desenvolupen la seva activitat a la xarxa pública catalana. Han signat el document com a membres del grup de treball de la SCPC-ACAPIR constituït per a aquest informe.

ISBN: 978-84-09-87424-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20686884>

Primera edició: juny de 2026

FORMA DE CITACIÓ RECOMANADA

López-Gómez, J., Miñano Valero, M. J., Aparicio-Muñoz, M., Batlle i Nicolau, N., Bonamaisó Nogué, E., Carreras Marcos, B., Carrascal Granados, L., Cruz García, M. Á., Escalona Zorita, P., Garriz, M., Mariscal Plaza, C., Mestres-Carbonell, J., Miquel Giner, N., Tablero Nadal, C., & Vilaseca, B. (2026). *La salut mental a Catalunya: entre el discurs institucional i la pràctica real*. Societat Catalana de Psicologia Clínica – ACAPIR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20686884>

DOCUMENT TÈCNIC COMPLEMENTARI

Aquest informe s'acompanya d'un document tècnic independent, titulat «Percepció professional sobre el funcionament de la xarxa pública de salut mental a Catalunya. Anàlisi de l'enquesta a professionals de psicologia clínica», on es publiquen íntegrament els resultats de l'enquesta (descriptius per bloc temàtic, anàlisi per subgrups, repositori de cites verbatim i fitxa tècnica detallada). L'informe principal incorpora únicament les xifres i respostes amb més rellevància per a l'argumentació.

LLICÈNCIA

Aquest llibre està subjecte a una llicència Creative Commons Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). En podeu consultar els termes complets a creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca

Índex

Resum executiu

1. Introducció	1
1.1. Per què aquest informe i des d'on s'escriu	1
1.2. Fonts i mètode	1
1.3. Com s'organitza el document	
2. Marc polític i institucional	3
2.1. Discurs institucional i compromís polític	3
2.2. El que es demana al sistema	4
3. Com està organitzat el sistema	6
3.1. El model català de provisió mixta	6
3.2. Els dispositius de la xarxa	6
3.3. Dotació professional	9
4. Com opera el sistema a la pràctica	11
4.1. Planificació a curt termini	11
4.2. Infradotació material i econòmica del sistema	12
4.3. L'escassetat crònica de professionals especialitzats	13
4.3.1. De què depèn la capacitat formativa de la xarxa	13
4.3.2. Qui decideix quantes places es formen cada any	13
4.3.3. Dos colls d'ampolla en l'acreditació de places	13
4.3.4. Una dècada de xifres pràcticament congelades	14
4.3.5. Latència estructural	15
4.3.6. Una planificació que es produeix per inèrcia	16
4.4. Fragmentació de la xarxa: expansió per programes	16
4.5. La contractació de professionals sense l'especialitat requerida	18
4.5.1. La contractació sense especialitat a la xarxa de salut mental	18
4.5.2. El programa RBEC	19

4.6. Càrrega assistencial, temps de consulta i burocràcia	20
4.7. Indicadors i categorització diagnòstica	22
4.8. Canalització del malestar social cap al circuit sanitari	24
5. Quins efectes produeix aquest funcionament	26
5.1. Empobriment de la intervenció clínica	26
5.2. Discontinuitat i pèrdua del pacient	28
5.3. Desgast, alienació i rotació professional	30
5.4. Individualització del patiment i afebliment de l'enfocament comunitari	32
5.5. Inequitat territorial	33
5.6. La paradoxa de l'expansió	33
6. Propostes	37
6.1. Sobre planificació sanitària i formació especialitzada	38
6.2. Sobre l'exercici professional i la cura dels equips	42
6.3. Sobre la formació dels professionals de la xarxa	44
6.4. Sobre l'organització de la xarxa	46
6.5. Sobre els indicadors i els sistemes d'informació	47
6.6. Sobre la recerca clínica	49
6.7. Sobre el model assistencial, la xarxa comunitària i l'articulació intersectorial	50
7. Tancament	52
Referències bibliogràfiques	53
Annex. Nota metodològica sobre l'enquesta	57

Resum executiu

La salut mental a Catalunya: entre el discurs institucional i la pràctica real

146

professionals de la psicologia clínica de la xarxa pública catalana enquestats (març-abril de 2026)

>80 %

declara no disposar de temps suficient per pensar els casos que atén

78 %

considera que els indicadors no reflecteixen la realitat clínica

60

dies de mitjana entre visites als centres de salut mental infantil

Aquest document analitza la distància entre el que el sistema públic de salut mental de Catalunya proposa —una atenció comunitària, integral i centrada en la persona— i el que passa en la pràctica quotidiana dels seus dispositius. El seu argument central és que aquesta distància no s'explica principalment per la voluntat ni pels errors d'actors concrets, sinó per la lògica amb què el sistema està configurat: cada agent —administració, entitats proveïdores, equips, professionals— actua de manera raonable dins de la seva posició i, tanmateix, el resultat agregat s'allunya dels objectius declarats. L'anàlisi es basa en fonts documentals i administratives i en una enquesta a 146 professionals de la psicologia clínica de la xarxa pública catalana (març-abril de 2026).

■ El problema de fons no és únicament de recursos: és de disseny

La manera com està organitzada la xarxa fa coincidir dues lògiques que es reforcen mútuament. La primera és una lògica institucional d'horitzó curt: posar en marxa un programa nou té nom, data de presentació i visibilitat pública, mentre que consolidar i reforçar el que ja existeix no té aquest atractiu. La resposta a cada nova necessitat tendeix així a ser la creació d'un dispositiu o un programa addicional, en lloc del reforç dels serveis troncal —els centres de salut mental d'adults (CSMA) i infantojuvenils (CSMIJ)— sobre els quals descansa el gruix de l'atenció.

La segona és la del mateix mapa de provisió. A Catalunya l'atenció no la presta directament l'administració, sinó 71 entitats proveïdores de naturalesa diversa —al voltant d'un 30% públiques i un 70% privades: consorcis, fundacions, empreses i entitats del tercer sector—, cadascuna amb les seves pròpies lògiques organitzatives (sostenibilitat econòmica, continuïtat dels concerts, gestió de les seves plantilles) i finançada en bona part segons el volum d'activitat que es pot comptabilitzar. La trobada de totes dues lògiques produeix una xarxa que creix per capes i es fragmenta per territoris, en la què la coordinació entre dispositius de diferents entitats depèn més d'acords locals que d'una planificació compartida, i en la què una mateixa persona pot passar per diversos serveis sense un referent clínic estable ni una història electrònica compartida entre ells.

Aquesta lògica s'observa amb especial claredat en la planificació de la formació d'especialistes, que és la que determina quants professionals tindrà la xarxa d'aquí a uns quants anys. Formar un psicòleg clínic requereix quatre anys de residència; un psiquiatre, cinc. La planificació sanitària només té sentit, per tant, si es concep a llarg termini: una decisió sobre places adoptada avui no altera la disponibilitat de professionals fins d'aquí a un lustre, i ha d'anticipar-se a les necessitats d'aquell horitzó i no a les de l'exercici pressupostari en curs. El sistema, però, planifica per legislatures i pressupostos anuals, i el nombre de places s'ajusta abans per inèrcia que per una valoració de les necessitats de la població.

PLACES FSE A CATALUNYA — DARRERES TRES CONVOCATÒRIES

Les places de formació en psicologia clínica (PIR) han crescut en una unitat —de **52 a 53**—, les de psiquiatria d'adults es mantenen congelades en **59** i les de medicina familiar i comunitària —primer nivell assistencial i peça fonamental en l'atenció a la salut mental— han retrocedit, de **371 a 367**.

Davant del dèficit que el mateix sistema genera, la sortida que s'ha consolidat és cobrir places d'especialista amb professionals que no tenen l'especialitat: gairebé nou de cada deu enquestats afirma que això succeeix al seu centre, i

prop del 80% afegeix que no se'n promou la substitució per un especialista quan aquest passa a estar disponible. Una via de provisió que era excepcional s'ha tornat ordinària.

■ El que això produeix a la pràctica

Aquesta manera de configurar la xarxa no es queda en el pla de la gestió: arriba a la pràctica quotidiana i a les persones ateses. Tres dels seus efectes resulten especialment rellevants:

Primer, les condicions de treball deixen poc marge per a la clínica. Més del 80% dels professionals declara no disposar de temps suficient per pensar els casos que atén —en una feina en què l'instrument principal és el vincle amb persones que pateixen—, gairebé el 70% no disposa de supervisió externa i una càrrega administrativa creixent competeix amb el temps assistencial. A això s'hi afegeix un sistema d'avaluació que la majoria no reconeix com a propi: el 78% considera que els indicadors no reflecteixen la realitat clínica, que mesuren sobretot el volum d'activitat i fan de la categoria diagnòstica una condició d'accés als recursos, mentre que el sistema amb prou feines disposa d'informació sobre si l'atenció que presta funciona, per a qui i en quines condicions.

Segon, la freqüència de les visites fa difícil sostenir un tractament psicològic amb continuïtat. A la xarxa ambulatoria troncal —els professionals que treballen exclusivament en CSMA o CSMIJ, on es concentra la psicoteràpia de seguiment—, la mediana entre visites és de 45 dies, i només el 8,6% pot mantenir una freqüència quinzenal, considerada el mínim recomanat per l'evidència per a gran part dels tractaments psicològics; per a set de cada deu, a més, l'agenda supera els cent pacients en seguiment simultani. A la xarxa infantojuvenil la dada és encara més exigent: el 39% dels professionals de CSMIJ atén els seus pacients amb més de dos mesos entre visites, una periodicitat incompatible amb qualsevol procés psicoterapèutic estructurat en la infància i l'adolescència. No resulta estrany, per tant, que la pressió assistencial afavoreixi intervencions breus i que dos de cada tres professionals considerin que el model actual no permet abordar la complexitat del patiment psíquic.

Tercer, vuit de cada deu reconeixen que una part rellevant de la demanda que atenen correspon a formes de patiment d'origen social o contextual —lligades a les condicions de vida, l'habitatge, la feina o l'aïllament— la resposta principal de les quals no és clínica. La seva canalització cap al circuit sanitari no només resulta poc eficaç: ocupa un espai i un temps que el sistema deixa de poder dedicar a les persones que presenten problemes de salut mental que sí que requereixen tractament clínic.

«Aquesta anàlisi no parteix de l'atribució de responsabilitats individuals: cap d'aquests resultats neix necessàriament de l'actuació d'un professional o un gestor determinat, perquè cadascun opera de manera raonable dins de la seva posició. El que el conjunt produeix, en canvi, és una forma de mala praxi estructural.»

■ Les propostes

Per aquesta raó, les propostes del document no consisteixen a continuar fent més del mateix amb més mitjans, sinó a modificar les lògiques amb què opera el sistema. S'organitzen en set línies:

- **Planificació sanitària i formació especialitzada.** Planificar els recursos humans a partir de les necessitats reals del conjunt de perfils que sostenen l'atenció, i no de les inèrcies pressupostàries i d'acreditació: un informe públic i periòdic de necessitats per perfil i nivell assistencial, una planificació de la formació especialitzada (PIR, MIR, EIR) ancorada en aquestes necessitats i projectada a llarg termini, unitats docents col·laboratives entre entitats que alliberin la capacitat formativa que avui la fragmentació desaprofita, i transparència sobre la composició real de les plantilles i les places que queden sense cobrir.
- **Exercici professional i cura dels equips.** Reconèixer que les condicions en què treballen els professionals i les condicions en què s'atén a les persones són el mateix: temps de supervisió, reunió d'equip i reflexió clínica reconegut com a feina i no com a espai residual; referències de càrrega assistencial màxima raonable per tipus de dispositiu; reducció de la càrrega burocràtica amb personal de suport; compliment dels requisits formatius en les contractacions; i espais protegits per a la psicoteràpia a la xarxa ambulatoria.

- **Formació dels professionals de la xarxa.** Una formació continuada estable i planificada amb els professionals, molt per sobre de les vint hores anuals del conveni SISCAT; una millor articulació formativa amb l'atenció primària; condicions de residència que la tractin com a formació i no com a cobertura assistencial; i independència respecte a la indústria farmacèutica.
- **Organització de la xarxa.** Reforçar primer els dispositius troncal —atenció primària, CSMA, CSMIJ— i que l'administració ordeni el sistema, en lloc que ho faci la competència entre entitats: transparència en l'assignació de recursos, un mapa actualitzat i accessible de tots els dispositius i programes, valoració prèvia de cada programa nou per la seva aportació i integració a la xarxa, canals segurs i comuns per a la comunicació clínica entre dispositius, i revisió dels programes la pràctica dels quals s'allunya del seu disseny.
- **Indicadors i sistemes d'informació.** Reorientar el sistema d'informació del control de l'activitat cap al sosteniment de l'atenció: indicadors centrats en el procés assistencial i la trajectòria de la persona més enllà del diagnòstic i el volum, una previsió explícita de quina activitat desplaçarà cada indicador nou abans d'implantar-lo, el reconeixement del treball d'equip i de les condicions de l'exercici, i la publicació oberta del conjunt d'indicadors.
- **Recerca clínica.** Incorporar a la xarxa la capacitat de saber el que es fa, per a qui i en quines condicions: una recerca basada en la pràctica i integrada en l'activitat clínica, amb temps reconegut i suport metodològic, orientada a les preguntes avui sense resposta —freqüència i intensitat del seguiment, resultats reals de cada programa, paper dels determinants socials— i amb la veu de les persones ateses.
- **Model assistencial, xarxa comunitària i articulació intersectorial.** Assumir que no tot el malestar que arriba a salut mental té una solució clínica individual: reforçar i articular de manera estable els àmbits dels quals depèn bona part d'aquest malestar —habitatge, feina, serveis socials, educació—, dotar l'atenció primària de mitjans concordants amb el seu paper central, simplificar els circuits per reduir la fragmentació, reconèixer el treball comunitari com a activitat assistencial i comunicar a la població, amb claredat, què pot i què no pot oferir el sistema públic amb els recursos de què disposa.

En conjunt, el document sosté que millorar la salut mental pública a Catalunya depèn menys d'afegir nous dispositius que de revisar la lògica que ordena els ja existents.

1. Introducció

■ 1.1. Per què aquest informe i des d'on s'escriu

La salut mental ocupa avui un lloc central en el discurs públic. Institucions, responsables polítics i mitjans coincideixen a assenyalar la centralitat social del malestar psíquic i la necessitat de donar una resposta institucional a les dificultats emocionals de la ciutadania. A Catalunya, aquest reconeixement s'ha traduït en els darrers anys en plans estratègics, programes específics i un augment d'iniciatives vinculades a la prevenció, la detecció precoç i el benestar emocional.

Aquest augment de l'atenció política i mediàtica no s'ha traslladat, però, en una millora equivalent per a qui treballa a la xarxa pública ni per a les persones que la utilitzen. Bona part de les tensions que es donen en la pràctica diària —com es distribueix el temps, què es registra i què no, quins casos es prioritzen, quins programes d'intervenció funcionen a la pràctica— apareixen poc en els informes oficials, les jornades tècniques o els debats públics. Aquest document intenta descriure aquesta distància entre els objectius declarats i el que passa, dia a dia, en els dispositius assistencials.

L'argument central de l'informe és que les dificultats del sistema no s'expliquen únicament per la insuficiència de recursos —encara que siguin insuficients i hi hagi dades públiques que ho acreditin—, sinó per la manera com el sistema està estructurat. Les regles de fi-

nançament, els criteris de contractació, els indicadors amb què es mesura l'activitat i la mateixa arquitectura de la xarxa generen incentius que orienten la pràctica clínica independentment de la voluntat dels professionals i dels gestors. D'aquí una conseqüència rellevant per a qualsevol decisió política sobre el sector: augmentar la inversió sense modificar aquestes regles pot no traduir-se en una millor atenció i, en alguns escenaris, fins i tot pot empitjorar-la.

L'informe s'escriu des de dins del sistema. L'impulsa la Societat Catalana de Psicologia Clínica – ACAPIR, una societat científic-professional formada per especialistes i residents en psicologia clínica que exerceixen a la xarxa pública. La seva aportació es basa en el contacte directe amb el funcionament quotidià dels dispositius: l'atenció amb els pacients, la coordinació amb altres companys, veure quina activitat es registra i quina queda fora, quines intervencions funcionen a la pràctica i quines no. Aquesta proximitat permet identificar dinàmiques que no solen aparèixer en el debat públic. La perspectiva de les persones ateses, de l'atenció primària, dels dispositius comunitaris i de la resta de professions de la xarxa és imprescindible i no queda recollida aquí. El document és, en aquest sentit, un punt de vista entre altres d'igualment necessaris.

■ 1.2. Fonts i mètode

L'anàlisi es basa en tres fonts:

GRUP DE TREBALL

Un grup de treball format per quinze professionals de la psicologia clínica que ha mantingut reunions de discussió orientades a identificar els aspectes crítics de la gestió i la pràctica assistencial. Aquestes sessions han funcionat com a fase exploratòria de l'anàlisi i com a base per al disseny de l'enquesta.

ENQUESTA A PROFESSIONALS

Una enquesta de percepció professional adreçada a especialistes i residents en psicologia clínica que treballen a la xarxa pública catalana, dissenyada específicament per a aquest informe. El qüestionari inclou 31 ítems en escala Likert 1-5, 2 ítems categòrics, 6 ítems quantitatius sobre la pràctica assistencial (temps de visita, freqüència de seguiment, volum de pacients en seguiment actiu) i 8 ítems oberts. Es van recollir 146 respostes vàlides durant els mesos de març i abril de 2026 (80,8% psicòlegs clínics adjunts, 17,8% residents PIR, cobertura territorial completa). L'anàlisi quantitativa i qualitativa completa es publica en un document tècnic independent; en aquest informe s'incorporen únicament les xifres amb més rellevància per a l'argumentació.

REVISIÓ DOCUMENTAL

Una revisió documental que combina informes institucionals i literatura científica. En el pla institucional s'han treballat fonamentalment fonts de l'àmbit català —Departament de Salut, CatSalut, Pla Director de Salut Mental i Addiccions (PDSMiA), Central de Resultats, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i els informes del Síndic de Greuges en matèria de salut mental—, complementades amb material d'altres sistemes i organismes internacionals que serveixen de referència. En el pla científic, la revisió s'ha centrat en els temes que l'informe aborda: organització i avaluació de serveis de salut mental, efectes dels sistemes de registre i incentius sobre l'activitat assistencial, planificació i formació de professionals, i debats actuals sobre el malestar, la medicalització i els determinants socials de la salut.

■ 1.3. Com s'organitza el document

L'informe segueix una seqüència analítica de cinc passos. El capítol 2 situa el marc polític i institucional: què declaren els plans estratègics, què diuen els responsables polítics i quines funcions, explícites i implícites, atribueix la lògica política al sistema de salut mental. El capítol 3 descriu com està organitzada la xarxa de salut mental a Catalunya: el model de provisió mixta, les entitats proveïdores i els dispositius que componen la xarxa. El capítol 4 descriu els mecanismes pels quals el sistema opera a la pràctica, explorant les dinàmiques que s'activen quan els objectius polítics i institucionals

s'implementen dins de l'estructura organitzativa de la xarxa. El capítol 5 descriu els efectes que aquests mecanismes produeixen: sobre les persones ateses, sobre els professionals, sobre la capacitat del sistema per complir el que declara. El capítol 6 formula propostes estructurades en els plans de la planificació, la formació, l'organització de la xarxa, els indicadors, les condicions de l'exercici professional i l'articulació amb l'atenció primària i l'àmbit comunitari. El capítol 7 tanca breument amb la idea central de l'informe.

2. Marc polític i institucional

Aquest capítol situa el marc polític i institucional en què opera el sistema català de salut mental. La primera secció recull el compromís polític expressat per les autoritats en els darrers anys i els objectius declarats pels

plans estratègics. La segona secció descriu el conjunt de funcions, explícites i implícites, que la lògica política assigna al sistema sanitari en matèria de salut mental.

■ 2.1. Discurs institucional i compromís polític

En els darrers anys, tant la demanda assistencial en salut mental com la seva presència en el discurs públic i polític han crescut de manera sostinguda. Diverses anàlisis dels serveis d'atenció a la salut mental en països d'ingressos alts assenyalen que els sistemes ja afrontaven pressions estructurals prèvies a la pandèmia de COVID-19, amb dificultats en la disponibilitat de recursos, llistes d'espera i escassetat de professionals, que s'han vist agreujades en els darrers anys. La pandèmia va actuar com a accelerador de la visibilitat pública dels problemes de salut mental i de les necessitats d'atenció, encara que els efectes reals sobre la prevalença poblacional són heterogenis. A més, aquesta major presència en l'agenda social no sorgeix únicament de la pandèmia: dècades de campanyes de sensibilització, iniciatives comunitàries i moviments socials han contribuït a fer que la salut mental sigui percebuda com un component central del benestar col·lectiu.

És en aquest context que cal situar la intervenció impulsada des del Pla Director de Salut Mental i Addiccions (PDSMiA) i el conjunt de documents estratègics a Catalunya. Els documents estratègics estableixen com a objectius la promoció de la salut mental, la prevenció dels trastorns mentals i les addiccions, la detecció precoç, el tractament adequat, la rehabilitació i la recuperació de les persones afectades. El PDSMiA planteja explícitament un model d'atenció biopsicosocial, comunitari i integrat, basat en drets i centrat en la persona, que transcendeixi la intervenció estrictament sanitària i incorpori la coordinació amb l'àmbit social, educatiu i comunitari (Departament de Salut, 2022).

En aquesta línia, durant l'última dècada s'han impulsat programes específics orientats a l'estandardització de la resposta urgent, l'abordatge de l'alta complexitat i l'atenció comunitària. En una primera fase, el sistema va posar en marxa el Codi Risc Suïcidi (CRS) — amb cobertura completa a Catalunya des del 2016—, com a protocol assistencial per garantir la continuïtat del seguiment després d'un episodi de conducta suïcida mitjançant una visita preferent en els 7 dies següents a

l'alta (3 dies en el cas de l'atenció infantojuvenil). A partir del 2021, es van desplegar de manera simultània diverses línies estratègiques: el Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya 2021–2025 (PLAPRESC), aprovat el setembre d'aquell any com a marc estratègic que engloba el CRS; el programa de Referents de Benestar Emocional Comunitari (RBEC), iniciat l'octubre del 2021 en els equips d'atenció primària; i els Equips Guia, en el marc del Programa d'Abordatge Integral dels Casos de Salut Mental i Addiccions d'Elevada Complexitat (PAICSAMAEC), concebuts com a equips territorials d'intervenció intensiva en l'entorn de vida d'adolescents i joves amb elevada complexitat clínica. El 2022 s'hi va afegir el Programa d'atenció a la Crisi infantil i juvenil en salut mental, desplegat progressivament en tots els Centres de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) fins a cobrir el conjunt del territori el 2023, amb l'objectiu d'oferir una resposta domiciliària i intensiva a menors d'entre 6 i 17 anys en situació de crisi psicopatològica i vulnerabilitat sociofamiliar. Més recentment, durant el període 2025–2026, el sistema ha ampliat la seva capacitat amb les UHEDI Plus, unitats d'alta especialització i mitjana estada adreçades a adolescents i adults joves amb trastorns del neurodesenvolupament, discapacitat intel·lectual o elevada complexitat clínica.

Aquest conjunt d'orientacions estratègiques ha anat acompanyat, en els darrers anys, d'un compromís polític explícit i sostingut en el temps. La salut mental ha ocupat un lloc destacat en el discurs institucional, tant des de la presidència de la Generalitat com des del Departament de Salut, amb una continuïtat que ha transcendit els canvis de govern. L'octubre del 2021, en l'acte del 25è aniversari de Salut Mental Catalunya, el president Pere Aragonès afirmava: «*Estem plenament compromesos amb la salut mental [...]. Estem treballant en el Pacte Nacional per la Salut Mental per millorar el benestar emocional de tothom*» (Presidència del Govern, 2021). Aquell mateix mes, el conseller Josep Maria Argimon presentava el programa de Referents de Benestar Emocional Comunitari (RBEC) assenyalant que «*aquest programa per-*

metrà dotar de més capacitat, més recursos, més mans, per a les actuacions de salut comunitària», i situava entre els seus objectius «reduir la medicalització per combatre el malestar emocional de la ciutadania» (Departament de Salut, 2021). Poques setmanes després, el Govern formalitzava la creació del Programa per a l'elaboració del Pacte Nacional de Salut Mental, amb la finalitat declarada «d'impulsar l'abordatge integral i coordinat entre els departaments de la Generalitat, els governs locals i les entitats socials» (Generalitat de Catalunya, 2021).

Aquesta línia de compromís s'ha mantingut en la legislatura posterior. L'octubre del 2024, el president Salvador Illa descrivia el Pacte Nacional de Salut Mental com «la primera estratègia d'Europa que inclou tots els departaments, entitats, municipis i societat civil», i subratllava que «el veritable repte que compartim és mantenir el compromís amb les persones que pateixen una malaltia mental els 365 dies de l'any» (Govern, 2024). Un any després, en el marc de la campanya institucional «Units per la salut mental», reiterava que «la salut mental ens interpel·la a tots, ens toca continuar treballant units per millorar-la» (Govern, 2025). La conselle-

ra Olga Pané, per la seva banda, ha situat aquest compromís en termes de necessitat estructural, afirmant que el sistema afronta reptes que «necessiten recursos però també reformes [...] per deixar el sistema de salut endreçat de cara a les generacions futures» (Govern, 2025). En paral·lel, l'executiu ha assumit públicament el compromís d'un increment progressiu dels recursos destinats a la salut mental, amb un augment documentat del pressupost específic de 457,5 milions d'euros el 2020 a 521,5 milions el 2023, xifra mantinguda com a referència en el pressupost prorrogat del 2024. En conjunt, el marc institucional dibuixa una imatge coherent: objectius amplis, programes específics, compromís polític transversal de diferents signes de govern i la voluntat d'augmentar els recursos. Aquesta coherència formal és el punt de partida de l'anàlisi.

Tanmateix, per comprendre què es demana realment als serveis i com es tradueixen aquestes prioritats en la pràctica, cal situar aquests objectius dins del conjunt de funcions que la lògica política assigna al sistema sanitari. La secció següent descriu aquest conjunt.

■ 2.2. El que es demana al sistema

Les polítiques públiques en salut no es dissenyen únicament des de criteris clínics o sanitaris. Estan travessades per dinàmiques pròpies de la gestió institucional: responsabilitat pressupostària, necessitat de retiment de comptes, cicles electorals, pressió mediàtica, cultura d'avaluació quantitativa i els imperatius de control i ordenació administrativa del sistema. Des d'aquesta perspectiva, el que es demana als serveis de salut mental no és només millorar l'atenció clínica, sinó complir una sèrie de funcions estratègiques dins del sistema públic.

En primer lloc, se'ls demana capacitat de fer front a problemes que han adquirit una forta centralitat social. La conducta suïcida —especialment en adolescents i joves—, l'augment sostingut del malestar emocional en la infància i la joventut —que es tradueix en xifres creixents d'ansietat, depressió, trastorns de la conducta alimentària i conductes autolesives—, el debat públic sobre l'impacte de les pantalles i les xarxes socials, la soledat no desitjada o el pes creixent del malestar psíquic en les baixes laborals, ocupen avui un lloc destacat en l'agenda pública i mediàtica. No es tracta únicament de fenòmens clínics: són qüestions d'alta sensibilitat social. El sistema ha de poder oferir respostes organitzades, reconeixibles i estructurades que transmetin capacitat d'acció.

En segon lloc, s'exigeix que l'activitat assistencial sigui visible, avaluable i comunicable. Això implica produir resultats mesurables, generar indicadors que permetin donar compte del que s'està fent i disposar de dades comparables que facilitin el seguiment i el control de resultats. La millora d'indicadors i la recollida de feedback no responen només a una lògica tècnica, sinó també a la necessitat institucional de demostrar avenç.

En tercer lloc, hi ha una tendència a dissenyar models que resultin organitzativament coherents sobre el paper: circuits definits, nivells d'atenció diferenciats, rols professionals delimitats i programes estructurats. Aquesta arquitectura formal permet representar el sistema com a ordenat, esglaonat i racional, encara que la realitat assistencial sigui molt més complexa i dinàmica.

Així mateix, hi ha una tendència a impulsar nous programes, projectes pilot i iniciatives específiques adreçades a problemàtiques concretes. La creació de dispositius diferenciats —cadascun amb el seu nom, el seu circuit i la seva línia estratègica— ofereix una imatge pública d'innovació i capacitat de resposta: cada nou programa és comunicable com a avenç. La integració posterior d'aquests dispositius en el conjunt de la xarxa assistencial és una tasca diferent i més difícil de mostrar, que no sempre acompanya el ritme de creació.

En paral·lel, s'afavoreix la reducció de la variabilitat mitjançant protocols i estandardització de processos. Això permet gestionar el sistema de manera més homogènia, comparar l'activitat entre dispositius i disposar de criteris uniformes de seguiment i control.

En aquest escenari, la xarxa de salut mental assumeix a més una funció implícita: actuar com a dispositiu institucional capaç de canalitzar i contenir un malestar

social creixent, fins i tot quan els seus determinants — socials, econòmics, educatius, legals— desborden l'àmbit estrictament sanitari.

En conjunt, la demanda política no s'adreça únicament a la qualitat clínica, sinó a la capacitat del sistema per ser estructurat, mesurat, visibilitzat i presentat com a eficaç i innovador.

3. Com està organitzat el sistema

Aquest capítol descriu l'arquitectura del sistema català de salut mental: el model de provisió (3.1) i els dispositius que componen la xarxa assistencial, des de l'atenció primària fins a la resta de nivells assistencials (3.2). Es

descriu el sistema tal com està organitzat, abans d'analitzar (capítol 4) com funciona a la pràctica i (capítol 5) quins efectes produeix aquest funcionament.

■ 3.1. El model català de provisió mixta

L'atenció a la salut mental a Catalunya s'articula a través d'un model singular de provisió mixta, la configuració actual és hereva d'una tradició consolidada d'iniciativa civil i social. Històricament, davant de l'absència d'una xarxa d'infraestructures estatals suficients, la resposta a les necessitats de salut mental va ser assumida per fundacions, ordes religiosos i consorcis locals. Amb la creació del SISCAT (Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública), l'administració va integrar aquesta diversitat de proveïdors sota un model de separació de funcions entre la compra i la provisió de serveis.

Aquest model té una conseqüència estructural que convé tenir present des del principi: en la majoria dels casos l'administració sanitària no presta directament l'atenció, sinó que la contracta a entitats proveïdores de naturalesa diversa —consorcis, fundacions, entitats del tercer sector, empreses públiques— mitjançant concerts o contractes de gestió de serveis.

Segons fonts del Pla Director de Salut Mental, l'atenció directa la realitzen un total de 71 proveïdors de salut, dels quals un 30% són institucions públiques gestionades directament per l'administració i un 70% entitats privades, que inclourien una gran diversitat de figures com ara fundacions, associacions de professionals, empreses i consorcis (Tristany, 2024).

Més enllà d'aquests 71 proveïdors amb contracte sanitari, la xarxa associativa vinculada a la salut mental és

molt més àmplia: es comptabilitzen més de 90 associacions de persones amb experiència pròpia i de famílies que col·laboren amb el sistema públic.

El finançament s'articula a través d'un sistema de contractació que combina una part fixa, destinada a garantir l'estabilitat i el funcionament estructural dels serveis, i una part variable que depèn de dos factors. El primer és el volum i el tipus d'activitat duta a terme —dies d'ingrés hospitalari, atencions urgents, nombre de primeres visites ambulatories en centres de salut mental—, ajustada segons la complexitat dels casos i el tipus de dispositiu. El segon és el compliment d'objectius, que inclou indicadors d'accessibilitat (llista d'espera de primeres visites, entre d'altres), de continuïtat assistencial (seguiment, coordinació entre dispositius) i de desenvolupament de programes específics.

Aquesta estructura ha permès assolir una notable capil·laritat territorial, garantint el desplegament de dispositius assistencials propers als nuclis de població mitjançant l'aprofitament de recursos preexistents. Al costat d'aquest avantatge organitzatiu, el model presenta efectes derivats que el capítol 4 desenvoluparà en detall: la pluralitat d'entitats amb contractes diferenciats introdueix variabilitat en criteris i procediments entre dispositius, i la dependència del finançament respecte als indicadors d'activitat orienta l'organització del treball cap a les dimensions de la pràctica que el sistema sap mesurar.

■ 3.2. Els dispositius de la xarxa: l'atenció a la salut mental a través dels nivells assistencials

L'atenció a la salut mental no comença en els centres comunitaris de salut mental, sinó en l'atenció primària. Els equips d'atenció primària de salut són el primer punt de contacte de la població amb el sistema sanitari i reben, filtren i orienten la major part del patiment psíquic que arriba als serveis públics. La magnitud d'aquesta funció és considerable: s'estima que entre el 20% i el 30% de les consultes d'atenció primària presen-

ten, directament o indirectament, una demanda relacionada amb problemes de salut mental o malestar psicològic (Ministeri de Sanitat, 2007), i un gran nombre dels problemes de salut mental són atesos de manera exclusiva pel metge o la metgessa de família, sense derivació a la xarxa de salut mental.

Gran part d'aquest malestar no respon a criteris de trastorn mental major. La Sociedad Española de Medicina

Familiar y Comunitaria (semFYC) recull en el seu document «No hacer en salud mental» que «en les consultes d'Atenció Primària cada vegada s'atenen més persones en què el motiu de consulta està relacionat amb un malestar emocional [...] que no és necessàriament símptoma d'una patologia psiquiàtrica», i defensa respostes no farmacològiques a aquestes demandes (Vázquez Canales, 2023). De la capacitat de resposta de l'atenció primària depèn, en gran mesura, què es medicalitza i què no, què es deriva i què s'acompanya, què es conté en el primer nivell i què escala. Si l'atenció primària no disposa de les condicions necessàries per complir aquesta funció en salut mental, la resta del sistema se'n ressent de manera inevitable.

En aquest model, els Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA) i els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) constitueixen el segon nivell assistencial de la xarxa de salut mental. La seva funció no és substituir l'atenció primària, sinó complementar-la. La gravetat és un dels criteris que orienten aquesta divisió de funcions, però no és l'únic ni actua de manera automàtica: la primària atén també situacions d'elevada complexitat i acompanya de manera continuada persones amb problemes greus de salut mental i assumeix, a més, bona part del seguiment de la seva salut física. Més que per un llinar, la frontera es traça pel tipus de complexitat i, sobretot, per la classe d'intervenció que cada situació requereix. L'atenció primària s'ocupa del problema encara indiferenciat, del malestar entrellaçat amb la malaltia física i amb els determinants socials, i de l'acompanyament longitudinal amb coneixement biogràfic de la persona; la xarxa de salut mental intervé quan la situació exigeix una resposta que excedeix el marc de temps i recursos del primer nivell, per la seva intensitat o freqüència o per requerir modalitats específiques —individual, grupal, familiar, farmacològica, rehabilitadora, de gestió de cas i seguiment comunitari o d'atenció a la crisi— i treball multidisciplinari. Sovint ambdós nivells atenen alhora la mateixa persona, cadascun des de la seva funció, de manera que la continuïtat assistencial és una responsabilitat compartida; els CSMA i els CSMIJ són, a més, el punt d'articulació amb la resta de dispositius de la xarxa.

Les dades de la xarxa ambulatoria permeten descriure com ha evolucionat aquesta demanda. La prevalença atesa en els centres de salut mental va créixer de manera sostinguda en els darrers anys: va passar de 294,6 persones per cada 10.000 habitants el 2018 a un màxim de 321,9 el 2023, abans de situar-se en 310,5 el 2024. En el conjunt del període 2018–2024 l'augment és del 5,4%.

Aquest creixement moderat del nombre de persones ateses conviu amb un major augment de la intensitat d'atenció per persona: la mitjana de visites per pacient atès va passar de 6,7 el 2018 a 8,0 el 2024, un increment del 18,9%. Convé precisar l'abast d'aquesta xifra. Es tracta del total de contactes anuals amb el conjunt de l'equip —psicologia clínica, psiquiatria, infermeria de salut mental i treball social— i inclou intervencions de naturalesa molt diversa: individuals, grupals i familiars, seguiment farmacològic, intervencions de rehabilitació i de seguiment comunitari. El nombre de contactes que correspon a cada professional per separat pot ser, per tant, sensiblement menor. A més, en tractar-se d'una mitjana sobre el conjunt de persones ateses, agrupa situacions molt dispars —des de contactes puntuals fins a seguiments intensius—, de manera que no reflecteix per si sola la realitat de cap cas concret. Una mitjana de vuit contactes anuals repartida entre diversos perfils al llarg d'un any deixa, a la pràctica, un marge reduït de continuïtat amb cadascun.

Segons les dades de la Central de Resultats, el creixement de la prevalença atesa no es reparteix per igual entre els grups d'edat. La població menor de 14 anys és la que presenta la prevalença atesa més alta i, a més, la que més ha crescut: va passar de 379,3 persones per cada 10.000 el 2018 a 444,4 el 2024, un augment del 17%. El grup de 15 a 44 anys va créixer un 13% en el mateix període. En canvi, en la població major de 64 anys la prevalença atesa va descendir. Aquest patró —fort augment en la infància, l'adolescència i l'edat adulta jove, i descens en la població gran— és coherent amb la creixent centralitat que el malestar emocional infantojuvenil ha adquirit en l'agenda assistencial i pública.

Aquest augment de l'activitat ha anat acompanyat d'un increment real dels recursos assignats a la xarxa ambulatoria. Entre 2018 i 2024, l'import contractat dels CSMA va créixer un 47% i el dels CSMIJ un 58%; en termes per capita sobre la població de referència, el finançament dels CSMA va passar d'11,5 € a 15,8 € per habitant i el dels CSMIJ de 23,4 € a 38,3 €. És un creixement sostingut i gens menyspreable. Situat, no obstant, en relació amb el volum de població que la xarxa atén i amb la intensitat creixent que requereix cada cas, cal preguntar-se si aquest esforç resulta suficient.

El contrast entre nivells il·lustra el paper real de l'atenció primària en salut mental. El 2024, el 74,2% de la població assignada va tenir contacte amb l'atenció primària i al voltant del 3,1% va arribar a un centre de salut mental (incloent-hi tant CSMIJ com CSMA). La comparació no és directament homògena: el primer

percentatge recull el conjunt de l'activitat de primària, amb independència del motiu de consulta. Aplicant l'estimació que entre el 20-30% de les consultes d'atenció primària presentarien una demanda relacionada amb la salut mental o el malestar psicològic, la proporció de població amb contacte de salut mental en el primer nivell se situaria al voltant del 15-22%, davant del 3,1% que arriba a la xarxa de salut mental —una diferència d'entre cinc i set vegades—. La major part de les demandes relacionades amb la salut mental es gestiona, per tant, en el primer nivell assistencial i mai no arriba al segon nivell. Quan l'atenció primària es troba desbordada, la seva capacitat de resolució es compromet i part

d'aquest patiment —sovint vinculat a problemes socials o vitals— escala cap als CSMA i els CSMIJ.

Aquesta pressió opera, a més, en totes dues direccions. La fortalesa del model comunitari depèn que tots dos nivells funcionin bé i en coordinació real. Quan la primària està sobrecarregada o no té prou suport del segon nivell, deriva en excés cap als CSMA i els CSMIJ. Quan els CSMA i els CSMIJ estan saturats, retornen casos a una primària que no té capacitat de sostenir-los. El resultat és un sistema on cada nivell acaba cobrint les mancances de l'altre, sense que cap pugui complir bé la seva funció.

Taula 1. Població atesa en salut mental i atenció primària, i indicadors d'ús (Catalunya, 2018–2024)

Indicador	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Població atesa SM (% de la població)	2,95	3,02	3,03	3,16	3,21	3,22	3,10
— població fins a 14 anys	3,79	3,83	3,77	4,10	4,18	4,31	4,44
— població 15–44 anys	2,67	2,79	2,88	3,07	3,13	3,16	3,01
— població 45–64 anys	3,46	3,54	3,51	3,56	3,60	3,59	3,42
— població 65–74 anys	2,64	2,63	2,59	2,61	2,66	2,65	2,54
— població 75–84 anys	1,96	1,99	1,95	1,93	1,95	1,87	1,71
— població 85 anys i més	0,78	0,82	0,79	0,83	0,84	0,78	0,72
Població atesa AP (% de la població)	73,5	74,1	73,0	78,5	78,5	74,1	74,2
Mitjana de visites/persona atesa i any (SM)	6,7	6,8	7,4	7,3	7,1	7,2	8,0
Mitjana de visites/persona atesa i any (AP)	5,7	5,8	6,0	7,4	7,7	6,8	6,1

Notes: totes les dades procedeixen de l'extracció de la sèrie completa de la Central de Resultats (aplicatiu de descàrregues, àmbits «Salut Mental i Addiccions» i «Atenció Primària i Comunitària», nivell Catalunya; descàrrega maig de 2026). Central de Resultats. Dades del sistema de salut de Catalunya 2017–2024 (AQuAS, novembre de 2025; DOI: 10.62727/DSalut.AQUAS/14065). La població atesa = percentatge de la població assignada amb almenys un contacte durant l'any (en salut mental, equival a la prevalença atesa expressada en percentatge). La mitjana de visites inclou tots els tipus de contacte i tots els perfils professionals de l'equip, de manera que el nombre de visites per professional individual pot ser notablement inferior.

La xarxa pública compta a més amb altres dispositius que completen la resposta per a situacions específiques. Les unitats d'aguts i els serveis d'urgències atenen les crisis que requereixen intervenció immediata. Els hospitals de dia, els serveis de subaguts i les unitats de mitjana i llarga estada donen suport als processos de recuperació. Els Serveis de Rehabilitació Comunitària (SRC) acompanyen la recuperació funcional i la integració comunitària de les persones amb problemes greus de salut mental. Els programes d'interconsulta i de psicologia clínica de la salut en els hospitals generals —incloent-hi psicooncologia, neuropsicologia i unitats d'enllaç— atenen el patiment psíquic vinculat a la malaltia física. Els Centres d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) completen la xarxa en l'àm-

bit de les addiccions. Cadascun d'aquests recursos compleix una funció específica i el seu funcionament adequat forma part d'una xarxa que, per ser eficaç, necessita estar ben articulada en el seu conjunt.

Aquest informe focalitza la seva anàlisi en major mesura en l'atenció primària i en els dispositius troncal de salut mental comunitària —CSMA i CSMIJ—, perquè és en aquest nivell on s'atén la major part de la població i on les dinàmiques estructurals que es descriuen a continuació tenen un impacte més directe i estès. Les dificultats que s'analitzen, però, no són alienes a la resta de la xarxa: la fragmentació, la sobrecàrrega i la manca de coordinació travessen el sistema en el seu conjunt.

Taula 2. Dispositius de la xarxa pública de salut mental de Catalunya (2026)

Dispositiu	Nombre (2026)
Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA)	81
Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)	71
Serveis de Rehabilitació Comunitària (SRC)	72
Hospitals de Dia de Salut Mental	65
Centres d'Hospitalització Psiquiàtrica	36

Font: CatSalut, cercador de centres sanitaris (24/05/2026). Les xifres de CSMA (81) i CSMIJ (71) inclouen les consultes perifèriques de salut mental adscrites a cada dispositiu.

3.3. Dotació professional

La xarxa de salut mental i addiccions mobilitza professionals de perfils diversos: psiquiatria, psicologia clínica, infermeria, treball social, teràpia ocupacional i altres figures tècniques. Aquest apartat es limita a la psicologia clínica, el perfil del qual disposem d'una dada oficial; la resta queda fora de l'abast del document.

El Departament de Salut no publica de manera consolidada les dades de personal de la xarxa, una informació imprescindible per planificar el sistema amb rigor. Fins ara, les úniques xifres disponibles eren parcials i de procedència dispar: un treball acadèmic situava al voltant de 9,16 per cada 100.000 habitants els professionals de psicologia clínica de la xarxa catalana amb dades de

2014 (Fernández-García, 2021), i diversos mitjans havien difós valors d'entre 9 i 12, sense explicitar-ne la metodologia (Ara, 2023; Metrópoli Abierta, 2023). Cap no constituïa un recompte oficial del conjunt de la xarxa.

En resposta a una sol·licitud d'accés a la informació pública, el Departament ha facilitat la dada del Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya: a 31 de desembre de 2025, la xarxa pública comptava amb 918 especialistes en Psicologia Clínica, equivalents a 11,3 per cada 100.000 habitants. És la primera xifra verificada del conjunt de la xarxa. La seva distribució per àmbit assistencial és la següent:

Taula 3. Especialistes en Psicologia Clínica a la xarxa pública catalana, per àmbit assistencial

Àmbit assistencial	Especialistes	% del total
Xarxa de salut mental	562	61,2%
Atenció hospitalària	234	25,5%
Atenció primària	50	5,4%
Altres àmbits*	72	7,8%
Total	918	100%

Font: Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya (DGPROFS), dades a 31/12/2025, facilitades pel Departament de Salut. * Inclou atenció sociosanitària, institucions penitenciàries i altres àmbits no classificats.

Aquest registre inclou només els especialistes en psicologia clínica. No inclou els professionals que, sense la titulació, ocupen llocs de psicologia clínica, una pràctica estesa a la xarxa (capítol 4). Si agafem la proporció entre tots dos grups que ofereix el Portal de Transparència de 2024 per als CSMA i CSMIJ —465,26 jornades completes d'especialistes davant de 170,50 de no especialistes, és a dir, un 37% addicional—, la plantilla que ocuparia llocs de psicologia clínica voltaria els 1.250 professionals, uns 15,5 per cada 100.000 habitants. La dotació real es podria situar, per tant, en una forquilla

d'entre 11,3 (especialistes titulats) i 15,5 (plantilla total estimada) per cada 100.000 habitants.

La dada oficial confirma, a més, que la xarxa amb prou feines assoleix el llindar que el Mapa Sanitari de 2008 va fixar com a mínim (~11,5 per 100.000; Departament de Salut, 2008), l'únic document de planificació que estima dotacions per recurs i sense actualització posterior. En la comparació internacional (Taula 4), Catalunya queda per damunt de la mitjana espanyola (~5,5) però per sota de l'estàndard d'uns 20 que recomanen els sistemes britànic i irlandès (British Psychological Society, 2004; Branley i Byrne, 2012) i dels països europeus amb ser-

veis més desenvolupats. Aquestes dades europees, recopilades per Civio a partir dels ministeris nacionals (Bernardo i Álvarez del Vayo, 2021), tenen una fiabilitat desigual segons el país —per les diferències de mètode i de definició entre sistemes—, per la qual cosa la comparació s'ha de llegir amb prudència.

Situata davant de les necessitats estimades, la dotació catalana s'aproxima a l'escenari que Prado-Abril et al. (2025) descriuen com a «ajustat» —el d'intensitat mínima acceptable— (Taula 4). En el millor dels casos, per tant, la xarxa catalana podria oferir una atenció de mínims. Quedaria, en canvi, molt lluny de l'escenari «intermedi» (27,4 per 100.000), que permetria oferir tractament psicològic a una proporció molt més gran de la

població que el necessita, i encara més del «protocol·litzat» (65,9).

Les dades del mateix registre informen a més d'un problema de sostenibilitat: el 22% dels contractes són temporals i gairebé una quarta part dels especialistes (el 23%) té 60 anys o més. La renovació de la plantilla depèn de les places PIR, pràcticament congelades des de fa anys (capítol 4): les convocatòries ja publicades garanteixen al voltant de 50 incorporacions anuals fins al 2030, just les necessàries per cobrir les jubilacions previstes. El sistema forma, així, el just per no decreïxer, sense marge per créixer ni per substituir per especialistes els llocs avui coberts sense l'especialitat.

Taula 4. Psicòlegs a la sanitat pública: Catalunya, Espanya i països europeus

País / territori	Psicòlegs/100.000 hab.	Any de la dada	Font
Suècia	58,3	2018	Socialstyrelsen
Dinamarca	54,3	2018	Sundhedsdatastyrelsen
Regne Unit	24,6	2020	NHS Workforce Stats.
Eslovènia	22,0	2020	Ministeri de Sanitat
Irlanda	21,2	2020	HSE - Dept. de Salut
Lituània	18,7	2019	Institute of Hygiene
Eslovàquia	18,3	2020	NHIC
Polònia	16,9	2019	National Health Fund
Catalunya	11,3 – 15,5	2025	RPSC + est. pròpia
Estònia	13,9	2019	NIHD
Portugal	9,6	2019	Conselho Nacional Saúde
Itàlia	8,6	2017	Ministero della Salute
Croàcia	8,5	2019	CIPH
Grècia	7,5	2019	Ministeri de Sanitat
Espanya — mitjana estatal	5,1 – 5,58	2018 / 2025	Min. Sanitat / Prado et al.
<i>Necessitats estimades per al SNS espanyol</i>			
Escenari ajustat — intensitat mínima acceptable	11,5	2025	Prado-Abril et al. (2025)
Escenari intermedi — ús òptim-mitjà de recursos	27,4	2025	Prado-Abril et al. (2025)
Escenari protocol·litzat — segons guies de pràctica clínica	65,9	2025	Prado-Abril et al. (2025)

Font: elaboració pròpia a partir de Civio (Bernardo i Álvarez del Vayo, 2021); Prado-Abril et al. (2025) per a la mitjana estatal i els escenaris de necessitat; RPSC i estimació pròpia per a Catalunya (11,3 = especialistes titulats; 15,5 = plantilla total estimada). La fiabilitat de les dades varia segons el país. Xifres del sistema sanitari públic; no s'hi inclou el sector privat.

4. Com opera el sistema a la pràctica

Els objectius descrits en el capítol 2 s'implementen dins del model de provisió descrit en el capítol 3, en un context d'elevada demanda, recursos limitats i cicles polítics curts. En aquestes condicions s'activen una sèrie de dinàmiques de funcionament que reorienten, sense proposar-s'ho, l'assistència. Aquestes dinàmiques no són excepcions ni errors puntuals: són respostes lògiques del sistema a les condicions en què opera. Cada actor —l'administració, les entitats proveïdores, les direccions de servei, els professionals— actua de manera raonable dins de la seva posició; el sistema funciona, en aquest sentit, amb una lògica pròpia que no coincideix

amb la suma de les voluntats individuals (Bourdieu i Wacquant, 2005).

Aquest capítol descriu com es desplega el sistema a la pràctica; el capítol següent analitza els efectes que es produeixen sobre les persones ateses, els professionals i la xarxa en el seu conjunt. Mantenir separats tots dos plans —com opera el sistema i quines conseqüències genera— facilita una lectura més clara de l'argument central: que els efectes descrits no responen a disfuncions puntuals, sinó a la lògica pròpia del sistema, a com està configurat.

4.1. Planificació a curt termini

La primera dinàmica és estructural: la planificació política es desenvolupa amb cicles curts —legislatures de quatre anys en el Govern de la Generalitat, períodes pressupostaris anuals, rotació freqüent de les persones responsables de la cartera de Salut—, mentre que la

transformació d'un sistema sanitari i, especialment, la formació dels professionals que el sostenen requereixen horitzons temporals que superen àmpliament aquests cicles.

Consellers/es de Salut de Catalunya en els darrers deu anys



La determinació del nombre de places de formació sanitària especialitzada (PIR per a psicologia clínica, MIR per a psiquiatria, EIR per a infermeria de salut mental) s'estableix any rere any en el marc de l'oferta estatal de Formació Sanitària Especialitzada (FSE), sense que a Catalunya existeixi un pla plurianual de necessitats vinculat a la demanda assistencial, la previsió de jubilacions, la complexitat clínica atesa o els objectius dels plans estratègics. Les places que es convoquen no són el resultat d'una anàlisi sistemàtica de necessitats, sinó del marge pressupostari disponible i de la iniciativa particular de les unitats docents existents.

La manca de coordinació interdepartamental influeix a més sobre la planificació. Qui decideix el nombre de places de Formació Sanitària Especialitzada convocades és la Subdirecció d'Ordenació Professional, que es regeix amb dades —entre elles la taxa de reposició— que no sempre contemplen les necessitats futures del De-

partament de Salut. La formació de professionals sanitaris requereix un mínim de cinc anys de planificació prèvia, mentre que les necessitats que generen els nous programes del Departament de Salut acostumen a exigir aplicació immediata o a curt termini.

L'execució pressupostària també respon a un horitzó curt. Els marcs pressupostaris amb terminis d'execució anual o biennal obliguen a assignar i justificar les dotacions dins d'un període concret, la qual cosa condiciona el tipus de respostes que el sistema pot donar: crear un programa nou és compatible amb un cicle pressupostari curt; reforçar de manera estructural i sostinguda la xarxa troncal ho és molt menys.

El resultat és un sistema que creix per capes successives —nous plans, nous programes, nous circuits— sobre una base estructural que no es modifica al mateix ritme.

ENQUESTA A PROFESSIONALS — PERCEPCIÓ SOBRE LA PLANIFICACIÓ

El **78,6%** dels professionals no percep coherència entre els objectius del Departament de Salut i els recursos humans disponibles en el seu dispositiu (Pregunta 2; mitjana 1,83/5). El **58,9%** discrepa que existeixi una planificació estable a mitjà o llarg termini (Pregunta 3; mitjana 2,47/5). El **49,0%** considera que el perfil de les noves incorporacions no s'ajusta a les necessitats clíniques del dispositiu (Pregunta 5).

4.2. Infradotació material i econòmica del sistema

Sobre la base d'aquesta planificació de cicle curt, els recursos assignats a la salut mental se situen per sota dels estàndards recomanats internacionalment. La Comissió Lancet sobre Salut Mental Global i els marcs de referència internacionals situen la inversió recomanada per a països de renda alta al voltant del 10% del pressupost sanitari (McKinsey Health Institute, 2022). Les dades disponibles situen la despesa pública en salut mental del conjunt del sistema sanitari espanyol al voltant del 5%, en el límit inferior del rang europeu (4–15%) (Organització Mundial de la Salut, 2022). A Catalunya, la documentació pressupostària del Departament de Salut per al 2023 situava el pressupost de salut mental en 521,5 milions d'euros, equivalent al 6,1% de la provisió de serveis sanitaris. Encara que aquesta xifra se situa per damunt del 5% descrit per al conjunt del sistema sanitari espanyol, roman clarament per sota del lílndar del 10% recomanat internacionalment. El projecte de pressupost de 2024 preveia elevar aquesta partida a 559,7 milions d'euros, encara que aquest pressupost no es va arribar a aprovar i l'exercici va funcionar amb el pressupost de 2023 prorrogat. No obstant això, no s'ha localitzat una sèrie pública consolidada i comparable que permeti seguir de manera homogènia l'evolució anual del percentatge específic destinat a salut mental a

Catalunya durant tot el període 2021–2025 (Departament de Salut, 2023).

La distribució interna dels recursos també és desigual. La major part dels països reporten gastar menys del 20% del seu pressupost de salut mental en serveis comunitaris (Organització Mundial de la Salut, 2022); en els països de renda alta, al voltant del 35% del pressupost continua concentrant-se en dispositius hospitalaris, malgrat que l'atenció basada en la comunitat ha mostrat millors resultats en termes de cost-efectivitat (Organització Mundial de la Salut & Nacions Unides, 2023).

Els documents de planificació de Catalunya admeten que, encara que hi ha hagut increments, la resposta actual no és prou eficaç ni eficient, en part per una orientació excessivament medicalitzada i per la manca d'inversió en mesures de promoció i prevenció (Casamitjana i Aguilà, 2023). Es destaca la necessitat d'augmentar el finançament i la inversió en tots els àmbits —salut, educació, social, habitatge— per garantir l'equitat.

A les limitacions econòmiques s'hi afegeixen limitacions físiques. La insuficiència d'espai en molts centres —manca de despatxos, reorganitzacions forçades per la disponibilitat— condiciona la capacitat d'ampliar equips encara que hi hagi finançament.

ENQUESTA A PROFESSIONALS — ESPAI I RECURSOS MATERIALS

El **73,3%** dels professionals identifica limitacions estructurals d'espai que dificulten ampliar la plantilla (Pregunta 8; mitjana 3,91/5). El **54,8%** considera que el seu dispositiu no tindria capacitat per acollir més residents en les condicions actuals (Pregunta 10).

«No hi ha espai per poder treballar adequadament; no hi ha despatxos per als psicòlegs clínics ni sales habituals per fer teràpia grupal.»

Enquesta a professionals — resposta oberta

■ 4.3. L'escassetat crònica de professionals especialitzats

4.3.1. De què depèn la capacitat formativa de la xarxa

La cobertura assistencial en salut mental no descansa sobre una sola disciplina. La xarxa catalana se sosté sobre quatre especialitats sanitàries —Psicologia Clínica, Psiquiatria (adults i infantojuvenil) i Infermeria de Salut Mental—, totes obtingudes per la via de la FSE, i s'articula sobre un primer nivell assistencial, l'atenció primària, sense la qual les altres peces del sistema no funcionen. La capacitat de la xarxa per atendre la població depèn de quants professionals es formen en el conjunt d'aquestes especialitats, any rere any, i a quin ritme s'incorporen a la xarxa. Aquest apartat examina les xifres agregades de FSE a Catalunya durant l'última dècada i identifica els mecanismes que n'han determinat l'evolució.

Per la funció que l'atenció primària compleix en l'atenció a la salut mental, descrita en el capítol sobre l'organització del sistema, l'anàlisi de la capacitat formativa de la xarxa no es pot cenyir a les quatre especialitats de salut mental. Aquest apartat incorpora també les xifres de Medicina Familiar i Comunitària (MIR MFyC) i d'Infermeria Familiar i Comunitària (EIR EFyC): les decisions que es prenen sobre unes i altres condicionen, conjuntament, la viabilitat del model d'atenció a la salut mental.

4.3.2. Qui decideix quantes places es formen cada any

El nombre de places de FSE convocades anualment no el fixa de manera unilateral cap administració. L'article 22.5 de la Llei 44/2003, d'ordenació de les professions sanitàries, i el Reial decret 183/2008 articulen un procediment de doble clau que convé descriure amb precisió, perquè defineix on recau la responsabilitat efectiva de la planificació:

- **Acreditació.** Les unitats docents (UD) dels centres sanitaris sol·liciten al Ministeri, a través de l'aplicació AcreFSE, l'acreditació inicial o l'increment de places per a cadascuna de les especialitats. La sol·licitud requereix un informe previ de la Comissió de Docència i la conformitat de l'administració sanitària territorial.
- **Proposta del territori.** A Catalunya, la Subdirecció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional del Departament de Salut recull les sol·licituds acreditades i eleva a la Comissió de

Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut la seva proposta d'oferta per a l'any següent.

- **Aprovació interterritorial.** La Comissió de Recursos Humans, integrada pel Ministeri de Sanitat i els territoris de l'Estat, acorda l'oferta global de FSE en el si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS). El Ministeri publica posteriorment la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Aquest procediment implica que el Ministeri pot retallar les places proposades, però no pot convocar-ne més de les acreditades, i que el sostre efectiu de places per a cada territori el fixen, en primer terme, les mateixes unitats docents i, en segon, l'administració sanitària catalana, que decideix quines sol·licituds avala i quines places acreditades eleva finalment a la convocatòria. La distinció operativa entre places acreditades i places ofertes és rellevant: una unitat docent pot tenir acreditades més places de les que s'ofereixen en una convocatòria concreta. En el cas de Catalunya, les dades suggereixen que el límit no prové principalment d'una retallada externa, sinó d'un nivell de sol·licituds d'acreditació discret, sostingut durant anys. Una part del creixement aparent que mostren les xifres en algunes especialitats —singularment en MIR de Psiquiatria— s'explica pel desplegament normatiu de la subespecialitat de Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència, no per un augment orgànic del nombre de places sol·licitades.

4.3.3. Dos colls d'ampolla en l'acreditació de places

Més enllà del procediment general, dos elements —un de comú al conjunt de l'Estat, un altre de singular del model català— condicionen la capacitat formativa real del sistema:

- a) **Model d'Unitat Docent Multiprofessional centrat en l'hospital.** La normativa estatal (Ordre PCM/205/2023, annex III) estableix que tota Unitat Docent Multiprofessional (UDM) de salut mental ha de disposar, entre altres dispositius, d'una unitat d'hospitalització psiquiàtrica d'adults, dispositius d'hospitalització psiquiàtrica infantil i juvenil, i una unitat d'interconsulta i enllaç. Aquests requisits són raonables des del punt de vista formatiu, però tenen un efecte estructural sobre qui es pot acreditar com a UDM: a la pràctica, l'entitat titular sol ser un hospital. Quan els dispositius comunitaris —CSMA, CSMIJ, CAS, rehabilitació— pertanyen a entitats proveïdores diferents en un mateix territori, la via prevista és el conveni de col·laboració docent entre

entitats. Aquesta via existeix, està normativament emparada i permetria, en teoria, capacitats formatives territorials molt superiors a les actuals; a la pràctica, s'utilitza amb una freqüència molt inferior a la que seria tècnicament possible. La fragmentació entre entitats proveïdores —descrita més endavant en aquest capítol— es tradueix així en una pèrdua de capacitat formativa agregada que no respon a la manca de plantilla ni de massa crítica clínica, sinó a la dispersió organitzativa de la xarxa.

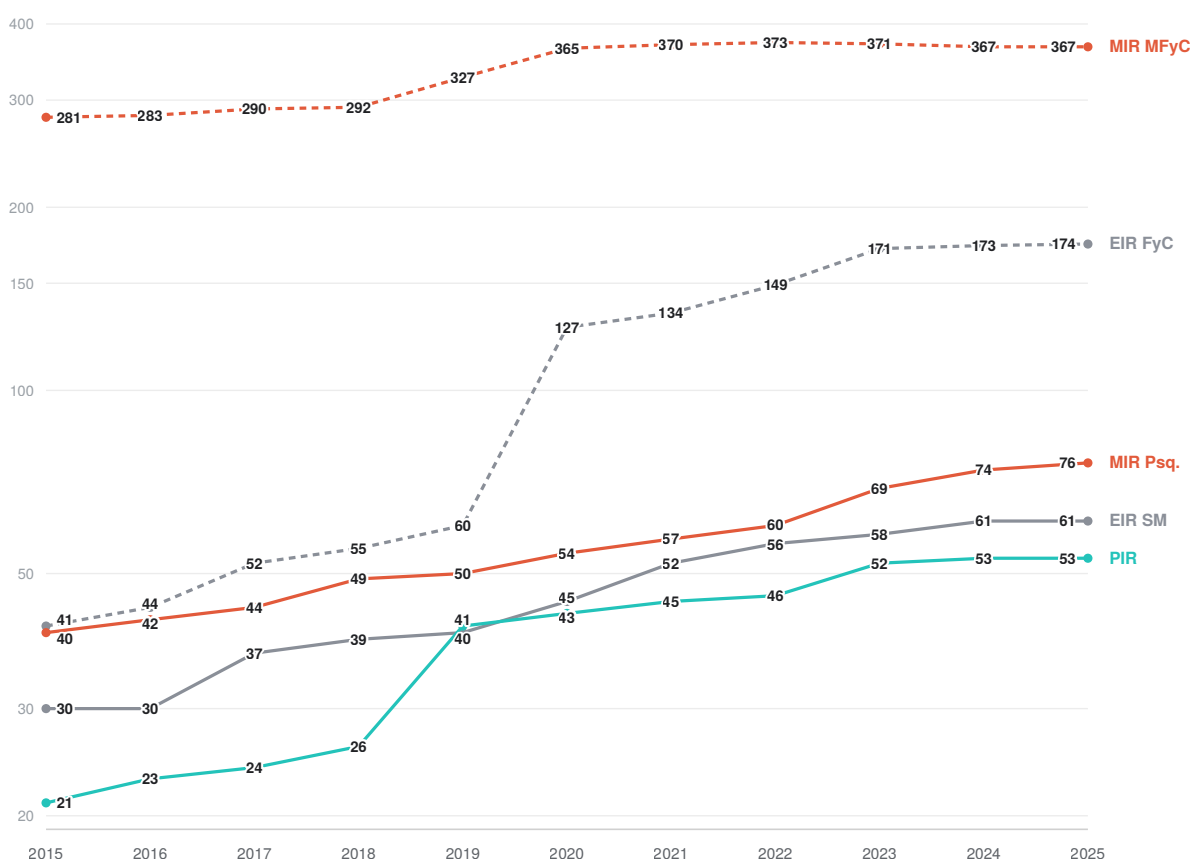
b) Càlcul de tutors per entitat titular. La ràtio resident-adjunt que determina el nombre màxim de residents per unitat només té en compte els professionals adscrits a l'entitat titular de la UDM. Un exemple concret n'aclareix l'efecte: si una UDM titular disposa de sis psicòlegs clínics especialistes en plantilla i els residents roten per CSMA, CSMIJ i CAS d'una altra entitat proveïdora del mateix territori en què treballen divuit psicòlegs clínics especialistes més, el càlcul a

efectes de ràtio continua sent de sis, no de vint-i-quatre. La capacitat formativa real del territori queda així infrautilitzada. Aquest criteri s'aplica des de l'òrgan català de docència i no respon a una exigència explícita del Ministeri de Sanitat, que en la seva normativa preveu expressament la fórmula del conveni entre entitats. És, per tant, un marge de millora que el Departament de Salut podria modular sense necessitat de canvis normatius estatals.

4.3.4. Una dècada de xifres pràcticament congelades

L'examen de l'evolució de les places FSE a Catalunya durant l'última dècada posa de manifest una distància entre el lloc que la salut mental i l'atenció primària ocupen en l'agenda política i el reflex pressupostari plasmat al BOE. L'oferta de places s'ha mogut durant anys en xifres de pràctica congelació.

Plazas FSE convocadas en Catalunya, 2015–2025



Font: elaboració pròpia a partir de les dades agregades de les convocatòries anuals de FSE publicades al BOE per als exercicis 2015 a 2025.

L'oferta de places de formació sanitària especialitzada vinculades a la salut mental i a l'atenció primària ha entrat, en conjunt, en una fase de pràctica aturada. En

les convocatòries més recents l'increment net és marginal —si no negatiu— i queda lluny de la transformació estructural anunciada en els plans estratègics autonòmics.

mics. El patró és transversal a les cinc vies formatives examinades en aquest apartat:

- **Psicologia Clínica (PIR).** Després d'un increment substancial l'any 2019, l'oferta s'ha estabilitzat: 52 places en la convocatòria de 2023 i 53 el 2024 i 2025. L'increment net ha estat d'una única plaça en tres anys.
- **Les especialitats de Psiquiatria (MIR Psiq).** La psiquiatria d'adults s'ha mantingut plana en 59 places anuals entre 2023 i 2025. La xifra global que apareix al gràfic (76 places el 2025) creix únicament pel desplegament de la nova especialitat de Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència, que va passar de tres places en la seva estrena (2022) a disset el 2025.
- **Medicina Familiar i Comunitària (MIR MFyC).** Després d'assolir un màxim de 373 places l'any 2022, l'oferta es va reduir i s'ha mantingut en 367 els anys

2024 i 2025, amb saldo net negatiu respecte al pic previ.

- **Infermeria de Salut Mental (EIR).** L'oferta s'ha mantingut en 61 places els anys 2024 i 2025.
- **Infermeria Familiar i Comunitària (EIR EFyC).** Després d'un creixement sostingut entre 2019 i 2022, l'oferta s'ha estabilitzat en 173-174 places en els dos últims exercicis.

En conjunt, les cinc vies comparteixen un mateix comportament: després dels augments registrats en anys anteriors, els dos o tres últims exercicis mostren xifres planes o en lleuger retrocés. Una evolució que no assoleix el ritme necessari per revertir el desajust entre l'oferta formativa i les necessitats de la xarxa comunitària catalana.

4.3.5. Latència estructural: el que es decideix avui no arriba fins d'aquí a anys

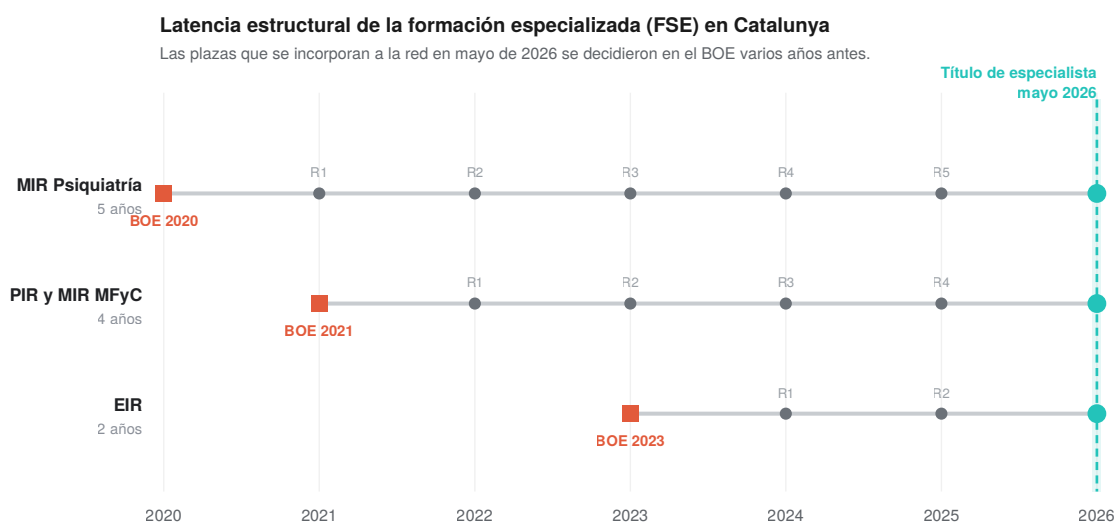


Figura 2. Latència estructural: del BOE a la incorporació efectiva de l'especialista a la xarxa.

Les xifres anteriors descriuen el flux d'entrada al sistema formatiu. Per calibrar-ne l'impacte sobre la xarxa assistencial és indispensable introduir un segon element: la latència estructural, és a dir, el període que hi ha entre la publicació d'una convocatòria al BOE i la incorporació efectiva de l'especialista al mercat laboral. Cada residència té la seva pròpia durada: quatre anys per a Psicologia Clínica i Medicina Familiar i Comunitària, cinc per a Psiquiatria i Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència (Ordre PCM/205/2023), i dos per a les especialitats EIR. Això implica que la disponibilitat de nous especialistes en un any concret està predeterminada per convocatòries publicades diversos exercicis

abans, i que cap decisió adoptada avui modifica l'horitzó dels propers quatre o cinc anys.

La lògica es pot llegir des del present cap enrere. Els especialistes que s'incorporen a la xarxa catalana el maig de 2026 són el resultat de places publicades al BOE el 2021 i el 2023: les 45 places PIR de la convocatòria de 2021 produeixen ara els psicòlegs clínics disponibles; les 57 places de psiquiatria d'adults generen l'última promoció formada sota el pla de quatre anys; les 370 places MIR MFyC incorporen ara els seus especialistes al primer nivell; i les 58 places EIR de Salut Mental de la convocatòria de 2023 —residència de dos anys— completen també la seva formació el maig de 2026.

La mateixa lògica, projectada des del present, mostra que els relleus dels propers anys ja estan en gran mesura fixats. El maig de 2027 s'incorporaran a la xarxa els titulats de les convocatòries de 2022: 46 psicòlegs clínics, 373 especialistes en MFyC i 61 infermers de salut mental. No hi haurà, en canvi, cap nova incorporació de psiquiatres: l'Ordre PCM/205/2023 va ampliar la residència de Psiquiatria de quatre a cinc anys amb aplicació a les places publicades a partir de la convocatòria de

2022, de manera que la primera promoció sota aquest pla no finalitzarà fins al maig de 2028. El buit de 2027 era previsible des del moment mateix en què es va aprovar l'ampliació, però no es va acompanyar de mesures compensatòries en la planificació de places ni en la dotació de les xarxes assistencials. Durant la pròxima mitja dècada, la disponibilitat d'especialistes a la xarxa catalana estarà determinada, en el que és essencial, per decisions ja preses.

Taula 5. Especialistes en Psicologia Clínica de la xarxa pública, per tram d'edat (31/12/2025)

Tram d'edat	Especialistes	% del total
Menys de 30 anys	23	2,5%
30 – 39 anys	217	23,6%
40 – 49 anys	232	25,3%
50 – 59 anys	232	25,3%
60 – 65 anys	143	15,6%
Més de 65 anys	71	7,7%
Total	918	100%

Font: Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya (DGPROFS), dades a 31/12/2025. El grup de 60 anys o més reuneix 214 professionals, el 23,3% del total.

Es pot quantificar l'efecte d'aquesta congelació sobre la xarxa. La piràmide d'edat dels especialistes en psicologia clínica (taula anterior) mostra que 214 —el 23% de la plantilla— tenen ja 60 anys o més: 71 superen els 65 i 143 els assoliran en el proper quinquenni. Sumades altres sortides (excedències, mobilitat), la xarxa necessita incorporar de l'ordre de 52 especialistes l'any només per mantenir la seva mida actual. Les convocatòries ja publicades aporten una mitjana de 50 incorporacions anuals fins al 2030: el sistema forma, en el millor dels casos, el just per no decreïxer. Créixer fins que cada lloc de psicologia clínica l'ocupi un especialista exigiria unes 76 places anuals, i acostar-se a l'estàndard europeu de 20 per 100.000, unes 112 —davant de les 53 convocades el 2025—. I com que cada plaça triga cinc anys a traduir-se en un especialista incorporat, cap decisió adoptada avui modifica la disponibilitat abans de 2031.

4.3.6. Una planificació que es produeix per inèrcia

El quadre descrit en aquest apartat permet caracteritzar la manera com es prenen, de fet, les decisions sobre formació de professionals especialitzats a Catalunya. El nombre de places convocades cada any no és el resultat d'un estudi sistemàtic de necessitats poblacionals, ni es deriva d'un càlcul del dèficit acumulat, ni respon a un calendari públic d'objectius quantitatius. És, fonamentalment, el resultat agregat de tres elements: les places que les unitats docents aconsegueixen acreditar dins de les restriccions del model, la decisió del Departament de Salut sobre quines places elevar finalment a la convocatòria, i l'ajust interterritorial en el si de la Comissió de Recursos Humans del SNS. La planificació formativa, en aquest esquema, es produeix abans per inèrcia que per disseny.

4.4. Fragmentació de la xarxa: expansió per programes i competència entre entitats

L'organització de la resposta assistencial presenta dos plans de fragmentació que operen de manera simultània i es reforcen mútuament: l'expansió per programes i la diferenciació entre entitats proveïdores dins d'un mateix territori.

En el primer pla, en lloc de reforçar estructuralment els dispositius troncal —CSMA i CSMIJ—, el sistema respon a noves demandes mitjançant la creació de programes específics o dispositius addicionals. Un exemple d'aquesta dinàmica és el programa de Referents de Benestar Emocional i Salut Comunitària (RBEC, descrit

amb detall a 4.5), que crea un circuit nou en atenció primària funcionant en paral·lel als CSMA i als CSMIJ, sense substituir-los ni reforçar-los directament. Iniciatives municipals, programes de fundacions i dispositius del tercer sector hi afegeixen capes addicionals. Cada programa té la seva pròpia lògica d'accés, la seva població diana, els seus indicadors i el seu equip.

Aquest mateix mecanisme es reproduïx quan els nous programes no es creen com a dispositius externs, sinó que s'implanten dins dels mateixos equips existents (CSMA, CSMIJ, unitats hospitalàries) i són assumits pels mateixos professionals. En un context de recursos limitats i d'execució pressupostària anual, la posada en marxa de nous programes no sol anar acompanyada d'una ampliació proporcional de plantilla, sinó d'una redistribució interna del temps. Un mateix professional sovint forma part simultàniament de diversos programes, amb agendes fragmentades, objectius diferenciats i exigències de registre específiques per a cadascun.

La lògica institucional que sosté aquest mecanisme és identificable: crear un nou programa té nom, data de llançament, acte de presentació als mitjans de comunicació i indicadors propis. Consolidar el que ja existeix no produeix el mateix tipus de visibilitat pública.

En el segon pla, en un sistema amb múltiples entitats proveïdores, cada organització presta un servei assistencial i alhora necessita justificar la seva existència, el seu finançament i la seva especificitat dins del territori.

Cada entitat tendeix a definir el seu programa com a singular, a delimitar un perfil propi i a subratllar la seva aportació diferencial, fins i tot quan els perfils atesos se solapen amb els d'altres dispositius de la mateixa zona. Aquesta diferenciació respon a condicionants estructurals —requisits de finançament, retiment de comptes, continuïtat de concerts econòmics, accés a recursos públics.

Una vegada creat un programa o dispositiu, aquest genera estructura: llocs de treball, equips consolidats, pressupostos, indicadors i dinàmiques pròpies. Integrar, fusionar o redefinir un recurs implica reorganitzar estructures, redistribuir personal, modificar pressupostos i assumir costos administratius i polítics. El sistema tendeix, per inèrcia organitzativa, a mantenir la diferenciació existent.

La coordinació entre dispositius de diferents entitats depèn en gran manera d'acords locals, relacions interpersonals i ajustos pragmàtics, més que d'una planificació sistèmica unificada. Una persona amb un problema de salut mental greu, problemes de consum i precarietat social, i el fill menor de la qual també està en seguiment per la xarxa de salut mental, pot estar en contacte simultàniament amb un CSMA, un CSMIJ, un servei de drogodependències, un programa d'inserció laboral i un servei d'habitatge, cadascun gestionat per una entitat diferent, amb sistemes de registre diferents i sense un espai formal de coordinació clínica conjunta.

ENQUESTA A PROFESSIONALS — COORDINACIÓ ENTRE DISPOSITIUS I ENTITATS

Només el **17,1%** dels professionals considera que la xarxa permet mantenir un referent clínic estable quan la persona travessa diferents dispositius (Pregunta 13; mitjana 2,23/5). El **47,2%** està d'acord que l'organització prioritza la continuïtat de programes per damunt de la indicació clínica individual (Pregunta 15). La valoració sobre la creació de nous programes és ambivalent: el **31,5%** considera que ha millorat la resposta assistencial; el **31,5%** hi discrepa i el **37,0%** se situa en posició neutra (Pregunta 11). La diferència s'accentua per àmbit: 2,59/5 entre els professionals de la xarxa comunitària exclusiva davant de 3,30/5 entre els de l'àmbit hospitalari+enllaç.

«Es van creant programes i unitats de SM (UHEDI+, Equip Guia, Crisi, PSI, etc.) però després no es cobreixen amb professionals especialitzats o es treuen professionals d'altres recursos bàsics com els CSMIJ per cobrir aquestes noves unitats, amb la qual cosa entrem en un dèficit permanent de professionals.»

«Un mateix professional participa en fins a 3 i 4 programes d'atenció alhora per cobrir les hores, sense possibilitat d'especialitzar-se en res ni en les condicions necessàries.»

«Garantir una bona cobertura dels centres d'atenció bàsics (no descuidar els CSMIJ, CSMA, PCP) i, a partir d'aquí, desenvolupar dispositius més específics o intensius. No construir la casa per la teulada.»

■ 4.5. La contractació de professionals sense l'especialitat requerida

La creació de nous programes i dispositius activa processos de contractació orientats a cobrir necessitats immediates. Quan el ritme de creació de programes avança per davant del ritme al qual el sistema forma especialistes —i quan els marcs pressupostaris obliguen a executar les dotacions en terminis anuals—, les places que cal cobrir no troben disponibilitat de professionals acreditats. Davant d'aquest desajust, adequar la creació de programes a la formació d'especialistes o ampliar les places formatives corresponents són respostes que operen en terminis llargs i no resolen la cobertura de l'exercici en curs. La via que preval és la immediata: mantenir el ritme previst i cobrir la plaça dins del termini, encara que això impliqui incorporar professionals sense la titulació especialitzada que la normativa reserva a aquestes places i eludir així un requisit legal la funció del qual és garantir uns estàndards mínims de qualificació i de seguretat en atenció.

Aquesta dinàmica afecta diverses especialitats sanitàries a la xarxa catalana —medicina familiar i comunitària, psiquiatria, infermeria de salut mental, psicologia clínica, entre altres— i s'observa tant a la xarxa pública directa com a les entitats proveïdores concertades. El que inicialment es presenta com a mesura temporal motivada per la insuficiència de professionals disponibles es prolonga en el temps sense que aquesta insuficiència s'incorpori com a prioritat en els cicles de planificació següents. La planificació es manté en el cicle curt i el dèficit estructural roman invisible en les dades que la sustenten. El sindicat Metges de Catalunya ha vingut denunciant aquest patró en diverses especialitats sanitàries i instava ja l'agost de 2021 el Departament de Salut a complir la Llei d'ordenació de les professions

sanitàries i a evitar la incorporació de personal sense la formació especialitzada corresponent, assenyalant que «la necessitat d'incorporar professionals no pot fer saltar les regles del joc» (Metges de Catalunya, 2021).

Els dos apartats següents descriuen les dues vies per les quals aquesta dinàmica opera en l'àmbit de la psicologia, on es disposa de dades directes procedents de l'enquesta a professionals.

4.5.1. La contractació sense especialitat a la xarxa de salut mental i als serveis hospitalaris

En els dispositius de la xarxa especialitzada (CSMA, CSMIJ, hospitalització, hospitals de dia, serveis de rehabilitació comunitària, programes específics) i en els serveis hospitalaris fora de la xarxa de salut mental en què l'activitat psicològica forma part de la cartera assistencial (psicooncologia, neuropsicologia, entre altres) s'ha estès la pràctica de cobrir places que corresponen a l'Especialista en Psicologia Clínica amb professionals que no disposen d'aquesta especialitat, habitualment amb el màster en Psicologia General Sanitària. L'atribució d'aquestes funcions a l'Especialista ve establerta per la Llei 44/2003, d'ordenació de les professions sanitàries, i per la disposició addicional setena de la Llei 33/2011, general de salut pública, configurant-se com un requisit mínim i de compliment obligat per a l'exercici d'aquestes funcions. Aquesta exigència es vincula a la qualificació clínica, al coneixement del sistema públic de salut i a la capacitat de treball en xarxa —competències que s'adquireixen a través de la Formació Sanitària Especialitzada (PIR)— i de les quals depenen la seguretat del pacient, la continuïtat assistencial i la qualitat de l'atenció.

ENQUESTA A PROFESSIONALS — PLACES SENSE ESPECIALITAT A LA XARXA DE SALUT MENTAL

El **89,0%** dels psicòlegs clínics enquestats afirma que al seu centre existeixen places de psicologia clínica cobertes per professionals sense l'especialitat: el **59,6%** la descriu com a pràctica habitual i el **29,5%** com a puntual (Pregunta 6). El **79,7%** assenyalava que la seva entitat no promou activament la substitució per un especialista quan aquest passa a estar disponible (Pregunta 7). El **49,0%** considera que el perfil de les noves incorporacions no s'ajusta a les necessitats clíniques del dispositiu (Pregunta 5; mitjana 2,63/5).

El que s'argumenta com a excepció temporal opera ja com a via habitual de provisió de places. La paradoxa resulta especialment visible en els hospitals amb places PIR formadores, en què conviuen la formació anual de nous especialistes i la cobertura estable amb personal no especialitzat sense que el sistema ho corregeixi:

El que s'argumenta com a excepció temporal opera ja com a via habitual de provisió de places.

«Al meu hospital es formen 4 residents PIR cada any i hi ha places cobertes per no especialistes; en acabar, les residents no obtenen continuïtat laboral.»

L'argumentació habitual amb què se sosté aquesta pràctica —no es troben especialistes disponibles— omet que la disponibilitat d'especialistes és, en gran mesura, un producte del mateix sistema. La xifra de psicòlegs clínics especialistes que s'incorporen cada any a la xarxa catalana depèn directament del nombre de places PIR convocades i de les condicions laborals amb què es reté els professionals formats. L'oferta catalana se situa, any rere any, molt per sota de la xifra necessària, com es documenta a 4.3.

A aquesta lògica de l'oferta formativa s'hi afegeix una segona, situada del costat de la visibilitat de les places. Una plaça coberta per un professional sense l'especialitat —encara que sigui de manera temporal i no com a dotació estable— passa a comptar, a efectes pràctics, com a plaça ocupada: deixa de figurar com a vacant i no es fa pública. Els especialistes que reuneixen el perfil no arriben a tenir constància de la plaça ni, per tant, l'ocasió de presentar-s'hi. L'absència de candidatures que en resulta tendeix a llegir-se després com a confirmació que no hi ha especialistes disponibles, quan el que no ha existit és la possibilitat de conèixer la plaça i optar-hi. Cada cobertura d'aquest tipus sostreu així una vacant del circuit visible i rebaixa la demanda aparent d'especialistes; i en no quedar registrada en cap punt com a necessitat no atesa, tampoc no se suma al còmput del dèficit que justificaria sol·licitar més places de formació especialitzada.

4.5.2. El programa RBEC: una categoria professional construïda fora del marc

El cas de l'atenció primària mostra de manera llegible com el sistema resol la tensió entre una demanda assistencial a l'alça, la disponibilitat de fons per reforçar-la i una insuficiència d'Especialistes en Psicologia Clínica que el mateix sistema ha generat en no ampliar les places PIR (descriu en l'apartat anterior). La via organitzativament coherent era ampliar el Programa de Col·laboració amb l'Atenció Primària (PCP), establert i implementat en els territoris com a línia prioritària pel Pla

Director de Salut Mental i Addiccions des de l'any 2006. Però es va trobar de nou amb l'obstacle que el volum de professionals requerit excedia el disponible. Atès que l'atenció psicològica al SNS correspon per marc normatiu a l'Especialista en Psicologia Clínica, l'opció finalment adoptada, l'octubre de 2021 sota la cartera del conseller Josep Maria Argimon, va ser la creació d'una categoria professional nova —els Referents de Benestar Emocional i Salut Comunitària (RBEC)— dissenyada amb elements que permetien que el lloc no quedés subjecte a l'exigència d'especialitat. La cronologia del requadre adjunt recull com s'articula aquesta construcció.

La magnitud del desplegament per aquesta via permet calibrar el desajust amb el ritme formatiu: en els primers set mesos del programa, el sistema va contractar 343 RBEC —en la seva pràctica totalitat psicòlegs sense l'especialitat—, una xifra que duplica el total de places de Formació Sanitària Especialitzada en salut mental que Catalunya va convocar aquell any (45 places PIR, 59 MIR de psiquiatria i 61 EIR; 165 places en total) i s'aproxima al nombre total de places MIR de Medicina Familiar i Comunitària (370). La mateixa agilitat financera i organitzativa que va permetre incorporar aquests professionals en un termini tan curt no s'ha traduït en una revisió paral·lela del ritme formatiu: les places PIR convocades anualment s'han mantingut pràcticament estancades (de 45 el 2021 a 53 el 2025). El que s'argumenta com a resposta a una manca d'especialistes externa al sistema conviu amb la decisió del mateix sistema de no ampliar les places amb què aquests especialistes es generen.

La qüestió que il·lustra el cas del RBEC no és si convé reforçar el primer nivell assistencial en matèria de salut mental —la necessitat existeix i és real—, sinó mitjançant quina arquitectura es fa. Els efectes de l'arquitectura efectivament triada —la coexistència de dos circuits psicològics amb criteris diferents en el mateix centre, l'opacitat per a la persona atesa sobre la titulació del professional que l'atén, el desplaçament de la lògica comunitària a l'interior del mateix CAP i la pressió afegida sobre els CSMA quan les derivacions desborden l'àmbit previst— es desenvolupen en el capítol següent.

CRONOLOGIA DEL PROGRAMA RBEC

1. La demanda. L'atenció primària rebia un volum creixent de consultes vinculades al patiment psíquic: malestar associat a determinants socials —precarietat laboral, habitatge, conflictes familiars i de cures, soledat, dol—; major visibilitat social dels problemes de salut mental i menor distància per consultar; quadres que requereixen atenció especialitzada i entren al sistema per la porta del CAP; i pressió afegida quan CSMA i CSMIJ operen al límit. La conjuntura pressupostària postpandèmia ofería marge real per reforçar la dotació.

2. L'obstacle. La via organitzativament coherent era ampliar el PCP, programa que ja desplegava Especialistes en Psicologia Clínica als CAP. Aquesta ampliació requeria un nombre d'especialistes del qual el sistema no disposava. La manca d'especialistes no era una dada externa: era el resultat acumulat de la mateixa planificació formativa, ja que les places PIR convocades anualment a Catalunya s'han mantingut durant anys per sota de la xifra necessària.

3. El marc normatiu aplicable. La Llei 44/2003 i la disposició addicional setena de la Llei 33/2011 atribueixen a l'Especialista en Psicologia Clínica les funcions assistencials psicològiques del SNS. L'exigència opera de la mateixa manera per a la resta de professions sanitàries —Medicina Familiar i Comunitària, Psiquiatria, Infermeria de Salut Mental—: l'atenció als problemes de salut mental requereix les mateixes garanties de qualificació, coneixement del sistema i treball en xarxa que l'atenció a qualsevol altra dimensió de la salut.

4. La construcció de la figura (octubre de 2021). Sota la cartera del conseller Josep Maria Argimon, el Departament de Salut presenta una nova categoria professional, els RBEC, articulada sobre quatre elements que actuen conjuntament:

- Una denominació que no conté el terme «psicòleg»: referent de benestar emocional i salut comunitària.
- Una dependència administrativa en la Direcció Estratègica d'Atenció Primària i Comunitària, fora de la xarxa de salut mental.
- Una descripció funcional com a promoció de la salut i prevenció del malestar emocional, intervenció grupal i comunitària, presentada com a diferenciada de la intervenció clínica individual. Declaracions públiques del mateix conseller subratllaven que els RBEC «no tractarien pacients» i que el programa serviria per «reduir la medicalització».
- El format grupal com a criteri diferenciador respecte a la intervenció clínica individual.

5. L'obertura nominal del lloc. El pla funcional preveu diverses titulacions de l'àmbit sociosanitari —psicologia general sanitària, infermeria, treball social, educació social, teràpia ocupacional— com a vies d'accés. Aquesta pluralitat nominal sosté la presentació del RBEC com a categoria professional pròpia, diferent de la de l'Especialista en Psicologia Clínica.

6. La contractació efectiva. El maig de 2022 el COPC informava de 343 RBEC implantats, en la seva pràctica totalitat psicòlegs amb el màster en Psicologia General Sanitària. La xifra duplica el total de places de Formació Sanitària Especialitzada en salut mental que Catalunya va convocar aquell any.

7. L'activitat realment desplegada. Una vegada integrats en els equips, la presentació pública a la ciutadania utilitza directament la figura del «psicòleg o psicòloga del CAP» (ICS, 2023; Consorci Sanitari del Maresme, 2023); en l'aplicatiu assistencial ECAP els professionals apareixen referits com a psicòlegs.

8. La impugnació. El juliol de 2022, SEPC-ANPIR presenta un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per entendre que les funcions efectivament realitzades excedeixen les declarades i corresponen a l'àmbit de l'Especialista. L'administració catalana defensa en el procediment que les funcions són de promoció i prevenció. Procediment pendent de sentència en el moment de tancar aquest informe.

■ 4.6. Càrrega assistencial, temps de consulta i burocràcia

Aquest apartat descriu una de les dinàmiques centrals del funcionament quotidià del sistema: la manera com es distribueix el temps del professional entre atenció directa, activitats de coordinació, reflexió clínica i tasques administratives. Les dades de l'enquesta —temps de visita, freqüències de seguiment, volum de pacients en cartera i càrrega burocràtica— ofereixen el material empíric que permet dimensionar aquest apartat.

La pràctica assistencial quotidiana de la xarxa de salut mental opera amb temps de visita i freqüències de seguiment que convé situar davant dels estàndards que l'evidència recomana per als tractaments psicoterapèutics. La taula següent recull els principals descriptius per al conjunt de la mostra i per als dos dispositius que concentren el tractament ambulatori de continuïtat: els centres de salut mental d'adults (CSMA) i infantojuvenil (CSMIJ).

Temps de visita i freqüència de seguiment

Taula 6. Temps de visita i agenda assistencial. Indicadors quantitatius de l'enquesta.

Indicador	Grup	n	Mitjana	DT	Mediana	P25–P75
Temps primera visita (min)	Conjunt	134	55,4	24,2	60	45–60
	CSMA	39	51,9	9,3	60	45–60
	CSMIJ	34	61,6	43,2	60	45–60
Temps visita successiva (min)	Conjunt	141	39,6	24,7	30	30–45
	CSMA	41	31,8	5,0	30	30–30
	CSMIJ	34	47,8	45,3	40	31–45
Visites / dia	Conjunt	135	7,3	2,3	7	6–9
	CSMA	41	8,4	1,6	8	8–9
	CSMIJ	31	7,4	1,5	7	7–8
Freqüència de seguiment (dies)	Conjunt	131	36,7	33,1	30	14,5–57,5
	CSMA	37	47,1	21,1	45	30–60
	CSMIJ	28	60,6	45,8	46	30–90

Font: enquesta a professionals de psicologia clínica (SCPC-ACAPIR, 2026). La freqüència de seguiment presenta la n més baixa (37 i 28) per un filtre adicional: s'exclouen les respostes inferiors a 5 dies. En CSMIJ, les mitjanes dels temps de visita estan influïdes per valors extrems aïllats; la mediana és l'estadístic de referència.

Taula 7. Distribució de la freqüència de seguiment per trams.

Interval entre seguiments	Conjunt (n=131)	CSMA (n=37)	CSMIJ (n=28)
≤ 21 dies (setmanal / quinzenal)	56 (42,7%)	6 (16,2%)	5 (17,9%)
22–30 dies (mensual)	17 (13,0%)	5 (13,5%)	4 (14,3%)
31–60 dies (bimensual)	37 (28,2%)	19 (51,4%)	8 (28,6%)
61–90 dies (trimestral)	18 (13,7%)	6 (16,2%)	9 (32,1%)
> 90 dies	3 (2,3%)	1 (2,7%)	2 (7,1%)
Total	131 (100%)	37 (100%)	28 (100%)

Font: enquesta a professionals de psicologia clínica (SCPC-ACAPIR, 2026). L'enquadrament d'un tractament psicològic depèn en bona part de la seva regularitat: és una freqüència sostinguda el que permet que les sessions constitueixin un procés i no una successió de controls espaiats. En aquesta dimensió, les dades del conjunt de la mostra ensenyen que una part dels tractaments de la xarxa pú-

blica es desenvolupa en condicions de freqüència compatibles amb un procés terapèutic: una mica més de quatre de cada deu professionals (42,7%) citen a intervals iguals o inferiors a tres setmanes. Aquesta xifra del conjunt, però, agrega contextos molt diferents. Inclou dispositius en què el contacte freqüent

forma part del seu propi funcionament —hospital de dia, hospitalització—, que desplacen el repartiment cap als intervals curts. Per això resulta més informatiu aïllar els dos dispositius que sostenen el tractament ambulatori de continuïtat: en CSMA la major part dels seguiments es concentra entre els 31 i els 60 dies (51%) i en CSMIJ el tram més freqüent és el de 61 a 90 dies (32%), amb gairebé quatre de cada deu professionals (39%) citant a intervals superiors als dos mesos.

Aquest espaïament no respon a criteris clínics ni a decisions individuals dels professionals, sinó a com està configurada l'agenda. La freqüència de seguiment no expressa la intensitat que cada procés requeriria, sinó el marge que l'organització del treball deixa disponible una vegada ateses les primeres visites.

ENQUESTA A PROFESSIONALS — QUOTA DE PACIENTS EN SEGUIMENT

El **70,4%** dels professionals de consulta ambulatoria porta més de 100 pacients en seguiment actiu simultani; el **33,9%**, entre 101 i 150, i el **20,9%**, més de 200. A la xarxa ambulatoria troncal (CSMA i CSMIJ, N=70), la mediana de freqüència de seguiment és de **45 dies** entre visites (P25–P75: 27–67 dies) i només el **8,6%** pot mantenir seguiments de 14 dies o menys. En CSMIJ, el **39%** opera amb intervals superiors a 60 dies entre visites (N=28).

CÀRREGA BUROCRÀTICA I TEMPS PER PENSAR

El **62,5%** dels professionals considera que la càrrega burocràtica interfereix en la seva pràctica clínica (Pregunta 17; mitjana 3,71/5). El **79,9%** dedica almenys un 10% del seu temps setmanal a tasques burocràtiques; el **21,5%** dedica entre el 25% i el 50% de la jornada. El **80,6%** discrepa de disposar de temps suficient per a la reflexió clínica sobre els casos (Pregunta 21; mitjana 1,74/5). Només el **16,0%** considera que els sistemes d'informació actuals (ECAP, SAP, etc.) faciliten la seva feina (Pregunta 18; mitjana 2,57/5).

Nota: les xifres corresponen a estimacions declarades pels mateixos professionals; el recompte exacte de la cartera activa rarament està disponible en els sistemes d'informació. La categoria superior de resposta és oberta (>200), i la lectura conjunta amb altres indicadors suggereix que el volum real probablement se situï entre 150 i 250.

Càrrega burocràtica

A la sobrecàrrega de visites s'hi afegeix una càrrega creixent de treball no assistencial. Sota aquesta denominació s'agrupen tasques heterogènies que comparteixen una característica: consumeixen temps professional sense constituir, per si mateixes, intervenció clínica. Entre elles, el registre del curs clínic, el registre en els

diferents aplicatius, l'emplenament de fulls de càlcul per al buidatge manual de dades, l'elaboració de plans individuals de tractament entesos com a procediment administratiu més que com a instrument clínic, la redacció d'informes i l'elaboració de memòries d'activitat.

Aquesta càrrega no és només percebuda: la mateixa Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas (2026), ha denunciat que els professionals dels serveis públics dediquen aproximadament un 30% de la seva jornada laboral a tasques de tramitació.

■ 4.7. Indicadors i categorització diagnòstica com a organitzadors de l'activitat

A la pressió sobre el temps s'hi suma un segon pla de mediació administrativa: el dels indicadors i les classificacions diagnòstiques categorials en l'organització de l'atenció. L'ús del CIM-10/11 o del DSM-5 no és només un requisit formal de registre: condiona a quins pacients s'atén, a quins no i quin tipus d'intervenció es considera apropiada per a cada cas.

Perquè un usuari sigui visible per al sistema —perquè se li assignin recursos, es comptabilitzi com a activitat i se li apliqui un circuit— necessita encaixar en una categoria diagnòstica. El diagnòstic categorial és funcional

al disseny organitzatiu: permet codificar, facturar, produir indicadors, assignar circuits i retre comptes. Per aquesta funcionalitat operativa, el seu ús es manté com a element estructural del sistema. La formulació clínica —entesa com a comprensió integrada del que li passa a la persona, de la seva història, el seu context i els factors que sostenen el seu patiment— queda subordinada en termes institucionals a la categoria diagnòstica.

L'activitat assistencial es gestiona, paral·lelament, mitjançant un sistema d'indicadors i compromisos ins-

titucionals que defineix què és visible, què s'avalua i què condiona la renovació dels concerts. Cada entitat proveïdora necessita acreditar el compliment dels indicadors fixats per justificar el seu finançament, i els equips directius traslladen aquesta exigència als equips

professionals. Els indicadors no operen, per tant, com a eina neutral de mesurament: una vegada incorporats al sistema de gestió, condicionen la pràctica. El que es mesura es prioritza; el que no es mesura tendeix a quedar fora del focus.

ENQUESTA A PROFESSIONALS — INDICADORS I DIAGNÒSTIC

El **78,3%** considera que els indicadors institucionals no reflecteixen la complexitat de la pràctica clínica (Pregunta 19; mitjana 1,77/5). El **63,8%** assenyalava pressió per ajustar-se als indicadors (Pregunta 20; mitjana 3,72/5). El **77,6%** percep que el diagnòstic condiona excessivament l'accés a recursos (Pregunta 25; mitjana 4,10/5). El **68,3%** s'ha vist obligat a assignar un diagnòstic sense tenir-lo clar o sense coneixement suficient del cas per requeriments del sistema informàtic (Pregunta 24; mitjana 3,83/5). El **72,0%** constata un augment de la protocolització en els darrers anys (Pregunta 26; mitjana 3,99/5).

En el sistema català, la categorització diagnòstica funciona com a condició de visibilitat: el que no es codifica sota una etiqueta CIM o DSM tendeix a no comptar com a acte clínic, i la pràctica es reorganitza entorn del diagnòstic abans que entorn del procés terapèutic. Les dimensions nuclears del treball en salut mental que difícilment poden capturar-se mitjançant indicadors quantitatius —els efectes terapèutics de la trobada clínica, els processos d'elaboració durant l'entrevista, el temps necessari per a la comprensió del cas— queden fora del registre institucional.

La interacció entre indicadors produeix efectes que el sistema actualment no monitoritza. Quan s'introdueixen noves tasques —registre en aplicatius, emplenament de protocols, activació de circuits, producció d'in-

dicadors— sense ampliar proporcionalment els recursos humans, el temps professional es redistribueix internament: el que és institucionalment obligatori o avaluable es prioritza, i altres activitats —coordinació amb la xarxa assistencial, treball comunitari, supervisió clínica, reflexió sobre els casos i fins i tot la mateixa psicoteràpia— es comprimeixen. L'indicador de «primeres visites en un termini inferior a X dies» il·lustra aquesta lògica. Quan un servei és avaluat per aquest indicador, la resposta organitzativa raonable és prioritzar les primeres visites; amb els mateixos recursos, el temps dedicat a absorbir-les se sostreu del seguiment de les persones que ja estan en tractament. La xifra de compliment de l'indicador millora; la freqüència amb què una persona pot ser visitada pel seu referent descendeix.

ENQUESTA A PROFESSIONALS — FREQUÈNCIA I CÀRREGA DE SEGUIMENT (XARXA AMBULATORIA TRONCAL)

Dades de la xarxa ambulatoria troncal (CSMA i CSMIJ, N=70): mediana de freqüència de seguiment de **45 dies** entre visites; mediana de durada de la visita successiva de **30 minuts**. Només el **8,6%** dels professionals pot mantenir seguiments cada catorze dies o menys. En CSMIJ, el **35,3%** opera amb seguiments superiors a 60 dies entre visites.

El CRS il·lustra un efecte d'ordre diferent. Un protocol concebut per a una situació clínica específica pot operar també com a via d'accés: s'utilitza de vegades des dels serveis d'urgències per garantir una primera visita preferent al CSMA quan el circuit ordinari està saturat, de manera que funciona a la pràctica també com a via administrativa d'accés al recurs.

Els aplicatius de registre, diferents per a cada proveïdor (ECAP, SAP, EKON, HCIS, entre altres), condicionen quina intervenció és visible per a la institució. Quan el sistema no permet codificar una intervenció familiar com a tal, o no reconeix el treball de coordinació amb

serveis socials com a activitat assistencial, el professional codifica l'activitat com una altra cosa o la realitza sense que quedi registrada. El que no es registra deixa d'existir des del punt de vista institucional.

A les dinàmiques descrites s'hi afegeix un tret del mateix sistema d'informació: el que es registra és, en la seva major part, activitat —visites fetes, episodis codificats, indicadors emplenats—, no resultats clínics. L'avaluació de l'efectivitat real de les intervencions en la pràctica habitual no forma part rutinària de l'aparell d'informació de la xarxa. Aquesta asimetria —molta informació sobre activitat, poca sobre resultats clínics en

la pràctica real— condiona el que el sistema pot i no pot aprendre sobre si mateix.

■ 4.8. Canalització del malestar social cap al circuit sanitari

Una part significativa de la demanda que arriba avui als serveis públics de salut mental no respon a un trastorn mental en sentit estricte, sinó a situacions de patiment lligades al context vital i social de la persona: pèrdua de feina o d'habitatge, conflictes laborals, processos d'incapacitat, violències, soledat, dols no acompanyats, dificultats de criança, malestars vinculats a l'adolescència o a etapes vitals de transició. Aquests malestars són, en molts casos, respostes comprensibles a circumstàncies adverses més que manifestacions d'un trastorn, però acaben sent atesos dins del circuit sanitari.

Aquest desplaçament no s'explica per una sola causa, sinó per la confluència de diversos processos:

Pèrdua de resposta col·lectiva al malestar. En les últimes dècades, les formes habituals de sosteniment davant del patiment quotidià —xarxes familiars estables, vincles veïnals, espais laborals menys precaritzats, associacionisme de base, teixit cultural local, espais públics de trobada— s'han debilitat de manera desigual però generalitzada. A mesura que aquests espais es contrauen, el malestar que abans trobava acompanyament en la mateixa vida quotidiana queda sense lloc i acaba buscant-lo en els serveis professionalitzats (Davies, 2021; Kirkbride et al., 2024).

Major visibilització social de la salut mental. En paral·lel, la salut mental ha guanyat presència en l'espai públic: campanyes institucionals, presència mediàtica creixent, programes escolars de benestar emocional i, sobretot, una conversa digital molt intensa a les xarxes socials. Aquesta visibilització ha tingut efectes positius —reducció de l'estigma, major disposició a demanar ajuda— i, alhora, ha contribuït que un conjunt creixent d'experiències vitals passi a llegir-se en clau psicològica o clínica. En franges de població jove, l'autodiagnòstic a partir de continguts a les xarxes socials s'ha convertit en una via habitual d'arribada al sistema, sovint amb una categoria diagnòstica ja preconstruïda (Weigle, 2023; Yeung et al., 2022).

Inflació diagnòstica i desplaçament del llindar. Les successives revisions del DSM i la CIM han ampliat el perímetre del que és classificable com a trastorn mental, incorporant variacions de l'estat d'ànim, del comportament o de la resposta a l'estrès que en marcs anteriors s'entenien com a reaccions esperables. Aquesta ampliació té conseqüències assistencials directes: am-

plia la població elegible per a atenció clínica i desplaça el llindar del que socialment es considera un problema que requereix intervenció sanitària (Timimi, 2014; Frances, 2013).

Afebliment de les xarxes no sanitàries de protecció. Serveis socials, habitatge, ocupació, prestacions per incapacitat o ajudes per a situacions de vulnerabilitat operen en molts territoris amb plantilles insuficients, criteris d'accés restrictius i terminis administratius prolongats. Quan aquestes xarxes no arriben o es demoren, el patiment derivat de les situacions que haurien d'atendre s'acumula i acaba expressant-se on sí que hi ha un circuit d'entrada formalment disponible.

Funció certificadora del sistema sanitari. Als processos anteriors s'hi suma una via administrativa específica: l'accés a determinades prestacions —incapacitat laboral, grau de discapacitat, ajudes, exempcions, reconeixements— requereix informes mèdics o psicològics. Això desplaça al sistema sanitari una tasca certificadora que no és estrictament assistencial i que ocupa una part no menor del temps de consulta (Buffel, Beckfield & Bracke, 2017; Reibling & Ariaans, 2023). Aquesta funció s'articula a més amb un circuit avaluador i pericial extern a l'àmbit assistencial les decisions del qual incideixen directament sobre la situació de les persones ateses sense que el sistema sanitari pugui modular-les (vegeu el requadre).

Accessibilitat de l'atenció primària. Per a una part important de la població, l'atenció primària és un punt d'entrada relativament accessible: és un recurs sanitari proper i ben distribuït en el territori, i el seu accés no es condiona a la situació administrativa regularitzada de la persona ni a una derivació prèvia. Quan la demanda no troba resposta en altres instàncies, una part tendeix a arribar al circuit sanitari i, en primer terme, a l'atenció primària.

El resultat conjunt és que en atenció primària, en urgències hospitalàries i en els CSMA i CSMIJ s'atén, juntament amb els problemes de salut mental pròpiament dits, un volum creixent de patiment psíquic l'origen del qual és contextual, vital o social. La consulta de salut mental es converteix així en el lloc on es disposa un patiment que el sistema institucional en conjunt no sap on ubicar.

EL CIRCUIT AVALUADOR I PERICIAL A CATALUNYA

La funció certificadora del sistema sanitari s'entrellaça amb un conjunt d'actors externs al circuit assistencial. A Catalunya hi intervenen quatre organismes amb competències diferenciades: l'**ICAM** (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, Generalitat de Catalunya), que valora mèdicament la incapacitat temporal i emet l'informe per a la resolució d'incapacitat permanent; l'**INSS** (Institut Nacional de la Seguretat Social), que dicta la resolució administrativa final sobre incapacitat permanent; les **Mútues** col·laboradores, que gestionen la incapacitat temporal per contingència comuna a partir del dia 16 i poden proposar altes a l'INSS; i el **CAD** (Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat, Generalitat de Catalunya), que reconeix el grau de discapacitat.

El professional assistencial documenta la situació clínica, però la resolució es pren fora del circuit assistencial, per un avaluador que no ha establert relació clínica amb la persona i que opera amb criteris, temps i finalitats diferents. Quan la resolució no s'ajusta a la situació clínica, la persona retorna al circuit assistencial sense que aquest pugui incidir en la decisió. La gestió dels casos d'incapacitat temporal de més de 15 dies a Catalunya difereix significativament segons el gestor: la durada mediana és menor en els casos gestionats per mútues que en els gestionats per l'INSS, diferència que els autors atribueixen, entre altres explicacions, a la concessió d'altes anticipades (Benavides et al., 2010).

ENQUESTA A PROFESSIONALS — PATIMENT SOCIAL I RESPOSTA SANITÀRIA

El **80,7%** dels professionals està d'acord que una part rellevant de la demanda atesa correspon a malestars socials o contextuals la resposta principal dels quals no depèn de la intervenció clínica (Pregunta 31; mitjana 4,17/5). El **62,8%** considera que els factors socials no s'aborden de manera integrada a la xarxa (Pregunta 33; mitjana 2,30/5). El **53,8%** observa que el sistema sanitari ha destinat recursos significatius a atendre malestar emocional lleu en els darrers anys (Pregunta 32). La pressió és més gran en la xarxa ambulatoria troncal: mitjana 4,39/5 en professionals de xarxa comunitària exclusiva davant de 3,81/5 en hospitalària+enllaç.

5. Quins efectes produeix aquest funcionament

Els capítols anteriors han descrit com està organitzat el sistema i com funciona a la pràctica. Els apartats següents descriuen què produeix aquest funcionament en la vida concreta de les persones ateses, en el treball dels

professionals i en la capacitat del sistema per complir el que declara. Aquestes conseqüències no són efectes col·laterals imprevistos: són resultats previsibles de la manera com el sistema està configurat.

■ 5.1. Empobriment de la intervenció clínica

La reorganització del treball entorn d'indicadors, la mediació administrativa de les decisions i la protocol·lització creixent produeixen un resultat conjunt: la intervenció clínica s'empobreix. No perquè els professionals no sàpiguen fer una altra cosa, sinó perquè el sistema no permet una altra cosa.

La pressió per l'eficiència numèrica produeix un desplaçament del criteri clínic. El professional es veu forçat a prioritzar l'«activitat» sobre el «procés»: s'incentiven les primeres visites, que computen com a accessibilitat, però no es valora la freqüència del seguiment posterior, la qual cosa condueix a processos terapèutics extremadament dilatats en el temps en què la persona atesa pot ser vista una vegada cada dos o tres mesos.

El que es perd no és només temps de consulta: es perd la possibilitat de fer avaluacions clíniques longitudinals, de treballar amb famílies, de fer intervencions grupals amb sentit clínic, d'integrar el context social en la formulació del cas. Intervencions breus i molt espaiades s'ofereixen a persones amb patiments complexos que requeririen una atenció sostinguda i intensiva. Quan l'única opció que el sistema ofereix a una persona amb un quadre greu és una visita cada dos mesos de trenta minuts, no estem davant d'una decisió clínica: estem davant d'una limitació del sistema que el professional no pot superar des de la seva posició.

A aquest empobriment s'hi afegeix una distància que no se sol explicitar. Les intervencions l'eficàcia de les quals s'exposa per justificar l'oferta assistencial es van demostrar en condicions —de temps de sessió, freqüència, continuïtat i dedicació— que la xarxa habitualment no pot reproduir. Quan una intervenció conserva el seu nom, però s'ofereix amb la meitat del temps, el doble d'espaiament entre visites i sense continuïtat assegurada, el que arriba a la persona atesa ja no és aquesta intervenció, sinó una versió l'efecte de la qual no es pot donar per descomptat. El sistema pot així declarar que

ofereix prestacions basades en l'evidència i, alhora, aplicar-les en unes condicions que l'evidència no va contemplar: l'etiqueta de la intervenció es manté, però no garanteix el que promet. Això val tant per a la psicoteràpia com per a les intervencions grupals, familiars, de rehabilitació o de seguiment comunitari, cadascuna amb les seves pròpies condicions mínimes d'aplicació.

«No es compleixen els temps ni la freqüència que requeriria la psicoteràpia. És com si donéssim fàrmacs sense la dosi correcta.»

A aquesta limitació s'hi suma la subordinació de la formulació clínica al sistema categorial. El requisit de codificar tot cas sota una etiqueta CIM/DSM no és només una exigència administrativa: condiona què es veu, què es registra i quin tipus de resposta es prescriu. Les limitacions dels sistemes categorials han estat objecte de revisions institucionals sistemàtiques. El Conseil Supérieur de la Santé de Bèlgica (2019), després d'una revisió exhaustiva de l'evidència, conclou que les categories del DSM i la CIM presenten problemes rellevants de fiabilitat, validesa i capacitat predictiva, que les seves fronteres són més dimensionals que categorials, i que afavoreixen una lectura cosificada dels problemes de salut mental, en què l'etiqueta diagnòstica acaba presentant-se com a causa dels símptomes que en realitat només descriu. D'aquí la seva recomanació: atès que l'evidència per delimitar trastorns nítidament definits és limitada, convé classificar treballant amb les grans categories —enteses com a espectres amplis o síndromes, i no com a malalties subjacents—, mantenir els diagnòstics com a hipòtesis de treball revisables i no situar les categories en el centre de la planificació de l'atenció, sinó al servei d'una formulació clínica del cas que integri la trajectòria biogràfica, el context relacional i social i el sentit del patiment. El sistema català, en exigir la categoria com a condició de visibilitat i de registre, pressiona en la direcció contrària: cap al diag-

nòstic precís i estable que l'aplicatiu pot codificar, justament el que aquesta revisió desaconsella.

Aquesta tensió s'aguditza en la clínica infantil i juvenil. La presentació dels problemes de salut mental en la infància és marcadament evolutiva: el que s'observa canvia amb l'edat i el moment del desenvolupament. La investigació longitudinal sobre la continuïtat i discontinuïtat de la psicopatologia al llarg de la vida (Rutter, Kim-Cohen & Maughan, 2006) mostra que les trajectòries evolutives són sovint heterotípiques —un quadre en la infància s'expressa de manera diferent en etapes posteriors—, de manera que un mateix menor pot rebre etiquetes diagnòstiques successives durant el seu desenvolupament. Exigir una categoria precisa i estable com a condició de registre encaixa especialment malament amb una simptomatologia canviant, i reforça també aquí l'argument a favor d'una caracterització àmplia i revisable abans que una etiqueta fixa.

Marc alternatiu com el Power Threat Meaning Framework (Johnstone & Boyle, 2018) mostren que és possible organitzar l'atenció a partir de la trajectòria vital, el context i el sentit del patiment, en lloc de fer-ho a partir de categories diagnòstiques. L'adopció de models d'aquest tipus, però, requereix transformar els sistemes de registre, avaluació i finançament que avui reconeixen únicament la categoria diagnòstica.

L'orientació categorial i la dificultat per incorporar marcs alternatius no són exclusives del sistema català. Smit (2023), en analitzar críticament la doctrina del «mesurar és saber» en el sistema sanitari neerlandès, adverteix que les polítiques institucionals tradicionals se sostenien sobre una visió lineal de causa i efecte aplicada a l'àmbit de la salut mental, i que com més es pensa i s'actua en compartiments, més probable és que s'exclouï les persones per no complir els criteris del compartiment. La proliferació de programes específics i indicadors quantitatius sense reforçar la base ambulatoria pot reproduir a Catalunya una fragmentació amb conseqüències similars.

Un exemple de simplificació induïda és la generalització de la psicoeducació grupal com a resposta estàndard. Convé distingir aquí entre dos formats grupals que el sistema tendeix a tractar com a intercanviables. La psicoteràpia de grup és una intervenció clínica amb la seva pròpia base d'evidència i les seves pròpies exi-

gències tècniques: formació específica del professional que la condueix, supervisió, continuïtat estable de la cohort, espai físic adequat, temps de preparació i d'elaboració entre sessions, i un enquadrament que permet treballar els processos relacionals que la mateixa dinàmica grupal posa en joc. La psicoeducació grupal, en canvi, és un format més estandarditzat, centrat en la transmissió d'informació i d'habilitats, que pot ser útil com a complement d'un tractament però que funciona de manera diferent. Les seves indicacions, els seus requisits i els seus resultats no són equivalents, encara que els sistemes de registre tendeixin a agrupar-les sota la categoria única d'«intervenció grupal».

En molts centres la psicoeducació grupal s'ha convertit en la resposta per defecte davant de la impossibilitat de sostenir psicoteràpia individual o grupal amb la continuïtat que l'evidència recomana. La raó no és que l'evidència la recomani com a intervenció principal per a aquests perfils, sinó que és la que permet atendre més persones amb menys recursos. Les mateixes condicions que limiten la psicoteràpia individual —agendes saturades, manca d'espais físics adequats, rotació de professionals, sistemes de registre que no capten la naturalesa longitudinal del procés— fan també difícil sostenir processos de psicoteràpia de grup, que requereixen cohorts estables i continuïtat en el temps. La lògica és organitzativa, no clínica.

Una dinàmica similar s'observa amb la medicació. Quan el sistema no pot oferir tractament psicològic amb la freqüència que l'evidència recomana, la resposta que queda disponible és la farmacològica. No perquè el professional la consideri necessàriament la millor opció clínica per a aquest cas, sinó perquè és l'única que es pot sostenir amb visites espaciades cada mes o cada dos mesos: en trenta minuts es pot ajustar una pauta farmacològica, però difícilment es pot fer psicoteràpia. El resultat és que una part de les persones ateses rep medicació no com a primera elecció clínica sinó com a conseqüència de les limitacions organitzatives del sistema. La sobremedicalització del patiment psíquic, objecte d'un debat social creixent, no s'explica només per les pràctiques de prescripció individuals: té arrels en un disseny assistencial que fa de la medicació la intervenció més compatible amb els seus propis temps.

ENQUESTA A PROFESSIONALS — EMPOBRIMENT DE LA INTERVENCIÓ

El **73,8%** afirma que la pressió assistencial afavoreix intervencions breus amb independència de la complexitat dels casos (Pregunta 29; mitjana 3,94/5). El **68,5%** considera que el model actual no permet abordar la complexitat del patiment psíquic (Pregunta 28). El **56,6%** considera que l'organització no permet una atenció ajustada a la gravetat clínica (Pregunta 16). Les diferències més àmplies s'observen entre l'àmbit comunitari (1,90/5 en la Pregunta 28) i l'hospitalari+enllaç (2,49/5): la dificultat per abordar la complexitat es concentra en la xarxa ambulatoria troncal.

5.2. Discontinuitat i pèrdua del pacient

La qualitat de l'atenció en salut mental no depèn únicament del que passa en cada consulta. Depèn també de la capacitat del sistema per sostenir la continuïtat del seguiment al llarg del temps: registrar on és cada persona, en quin estat, amb quin professional, en quin moment del procés. Les dinàmiques descrites en el capítol anterior produeixen un efecte que es fa visible només quan s'examinen les trajectòries completes: el sistema perd persones en diferents punts del seu recorregut — abans d'entrar, mentre són dins i en els passos entre dispositius — i rarament registra que les ha perdut.

Aquesta pèrdua té una característica que convé anomenar d'entrada. La persona que es perd gairebé mai no ho fa de manera identificable per al sistema. No sempre hi ha una queixa, una reclamació, un episodi que activi el circuit. Qui deixa d'acudir desapareix del llistat de seguiments sense que el sistema deixi constància de la seva sortida; qui roman en l'espera no figura més que com un número en una cua. I aquesta dinàmica té un biaix de gravetat: els pacients amb quadres més complexos —els que tenen menys xarxa social, menys recursos econòmics, menys capacitat de gestionar les seves pròpies cites, menys marge per interpell·lar el sistema quan alguna cosa falla— són habitualment els qui menys protesten quan se'ls perd. La formulació que Tudor Hart va fer fa més de mig segle per al conjunt del sistema sanitari —la disponibilitat de bona atenció varia inversament a la necessitat de la població— troba en aquest punt una expressió específica (Tudor Hart, 1971; Mercer i Watt, 2007): el sistema manté la vinculació amb qui té capacitat de fer-se present i la perd més sovint amb qui més sostinguda la necessitaria.

Els pacients amb quadres més complexos són habitualment els qui menys protesten quan se'ls perd.

Abans d'entrar: l'espera sense seguiment

Una persona ha estat derivada al centre de salut mental i espera primera cita amb setmanes o mesos d'espera.

Durant aquest temps, el que passa amb ella escapa del sistema. Es poden donar tres trajectòries.

En algunes, el patiment s'agreuja: s'instal·len patrons d'evitació o aïllament, la situació laboral o familiar es deteriora, apareix una crisi que porta a urgències abans d'hora. Quan finalment arriba la primera visita, el professional es troba amb un quadre més complex que el que va motivar la derivació inicial.

En altres passa el contrari: la persona millora pels seus propis recursos, per canvis en la seva situació o per suport informal. Quan arriba la cita ja no hi acudeix, o ja no necessita la intervenció prevista.

I hi ha les persones que desisteixen: abandonen l'espera, busquen alternatives privades si s'ho poden permetre, o simplement deixen de demanar ajuda. El que tenen en comú aquestes tres trajectòries és que el sistema no disposa d'informació sobre quina d'elles ha seguit cada persona. Durant l'espera, el sistema actua a cegues: no hi ha valoració de l'estat clínic, ni mecanisme per reordenar la prioritat de les agendes segons com evoluciona cada cas, ni manera de detectar qui ha abandonat el circuit abans de la primera cita. La conseqüència operativa és doble: el sistema no pot prioritzar qui empitjora i no registra qui no torna.

Dins del circuit: l'atenció intermitent

Una vegada feta la primera visita i assignat el tractament, la freqüència del seguiment posterior queda condicionada per la pressió sobre l'agenda: la càrrega de pacients actius, l'obligació d'absorbir noves primeres visites, les activacions de circuits prioritaris. El resultat és que les visites s'espaïen a intervals que sovint ronden els dos o tres mesos, i de vegades més.

Cada visita és per si mateixa un acte clínic, però la successió de visites amb aquests intervals no arriba a constituir un procés. El que entre dos contactes així separats es pot sostenir és, en el millor dels casos, una revisió d'estat i un ajust simptomàtic; els processos

terapèutics que l'evidència recomana per als quadres prevalents operen en escales temporals diferents.

Amb els recursos actuals, les dues formes disponibles d'alleujar aquest desajust —atendre més persones amb menor freqüència o menys persones amb la freqüència adequada— es tradueixen en formes diferents de problema: una atenció diluïda sobre el conjunt o una restricció de l'accés per a una part de la població. El sistema ha optat de fet per la primera, sense que aquesta elecció quedi formulada explícitament.

En aquests intervals llargs també es perd el pacient, encara que d'una altra manera. Es perd el que ha passat entre una visita i la següent, es perd el seguiment d'un canvi terapèutic, es perd la possibilitat de detectar a temps un empitjorament. Qui no acudeix a una cita queda anotat a l'agenda com a absent i, llevat dels circuits protocol·litzats, no sempre se sap si el que ha passat és que ha millorat, que s'ha mudat, que ha passat al sistema privat o que està pitjor.

Entre dispositius i entitats: discontinuïtat del procés clínic

La discontinuïtat més severa es produeix en els passos entre recursos. Una persona en seguiment en un CSMA o CSMIJ pot ser derivada a un programa específic, hospitalitzada, vinculada a un equip d'intervenció intensiva o incorporada al circuit d'un dispositiu d'addiccions. Cadascun d'aquests passos suposa, en intensitat creixent, una ocasió de pèrdua.

El primer nivell és el canvi de professional dins del mateix dispositiu: el pacient passa a un altre referent del mateix centre de salut mental perquè l'anterior rota, canvia de servei o se'n va. Es mantenen l'equip, l'aplicatiu i la cultura clínica; el que es perd és el vincle i el coneixement acumulat del cas, que rarament es transfeix íntegre en el traspàs formal.

El segon nivell és el pas entre dispositius del mateix proveïdor: de CSMIJ a CSMA, de CSMA a hospitalització, d'un programa específic a un altre. Encara que comparteixen estructura administrativa i, en general, sistemes d'informació, els criteris i els temps del dispositiu de destinació són diferents, i la coordinació efectiva depèn del contacte directe entre professionals més que d'un circuit formal.

El tercer nivell és el més sever: el pas entre dispositius d'entitats diferents. En el sistema català de provisió mixta no és infreqüent que una persona transiti al llarg d'un mateix procés per dispositius gestionats per dues o tres entitats proveïdores diferents. Cada entitat té el seu propi aplicatiu de registre —ECAP, SAP, EKON, entre altres—, els seus propis criteris de derivació, els seus propis circuits interns, els seus propis protocols. No hi ha un equip conjunt on discutir sobre el que li passa al pacient, ni una història clínica compartida en termes pràctics. La continuïtat assistencial, en aquestes condicions, no és un atribut del sistema: és el resultat de l'esforç individual dels professionals per sostenir-la, mitjançant trucades, correus i coordinacions informals que depenen de la seva disposició personal.

El que queda fora del registre

El conjunt de pèrdues descrites comparteix una propietat: cap no genera per si sola una resposta del sistema. Qui queda en aquesta espera no apareix com a problema fins que empitjora i torna per urgències. Qui acudeix a visites espaiades figura com a cas en seguiment encara que entre una i altra ningú no sàpiga exactament com està. Qui passa d'una entitat a una altra i es despenja en el trànsit desapareix de la cartera de la primera sense aparèixer encara en la de la segona. El sistema només torna a tenir constància d'ells quan reapareixen en els seus punts més intensius: la urgència psiquiàtrica, l'ingrés, l'atenció per temptativa de suïcidi. Llavors, el que amb un procés clínic continuat podia haver estat un tram terapèutic s'ha convertit en alguna cosa més greu, més costosa i, sobretot, més dolorosa per a la persona.

Alguns d'aquests recorreguts acaben en formes de prolongació sense progressió a les quals tradicionalment s'ha anomenat cronicació. Convé matisar el terme: no es tracta aquí de la cronicitat inherent a determinats quadres, sinó de processos que perden continuïtat i, amb ella, perden la possibilitat d'avançar. La diferència importa per a les decisions que es deriven d'aquest informe: el que el sistema produeix no és necessàriament un curs clínic persistent, sinó trajectòries assistencials sense sosteniment.

ENQUESTA A PROFESSIONALS — DISCONTINUÏTAT I SEGUIMENT

Dades de la xarxa ambulatoria troncal (CSMA i CSMIJ, N=70): mediana de freqüència de seguiment de **45 dies** entre visites (P25–P75: 27–67 dies). Només el **8,6%** dels professionals pot mantenir seguiments de 14 dies o menys. En CSMIJ, el **39%** opera amb intervals superiors a 60 dies entre visites. El **70,4%** porta més de 100 persones en seguiment actiu simultani; el **20,9%** en declara més de 200.

■ 5.3. Desgast, alienació i rotació professional

Els apartats anteriors han seguit els efectes d'aquest funcionament sobre la intervenció clínica i sobre la continuïtat dels processos assistencials. Aquesta mateixa lògica recau també sobre els qui sostenen l'atenció: produeix conseqüències directes sobre els professionals, sobre els equips en què treballen i, amb el temps, sobre l'estabilitat de la mateixa xarxa. Convé recórrer aquests tres plans per separat, perquè les respostes que requereix cadascun són diferents.

Dues formes de desgast

En el pla del professional se solapen dues formes de desgast que sovint es confonen, però que tenen causes diferents i requereixen respostes diferents.

La primera és la sobrecàrrega assistencial: massa persones ateses, massa primeres visites, agendes que no deixen marge. A aquest volum clínic s'hi suma una càrrega creixent de treball no assistencial —registre en aplicatius, emplenament de protocols, resposta a requeriments institucionals, coordinacions formals— que consumeix una part substancial de la jornada sense traduir-se en una millor atenció. Els professionals no només estan sobrecarregats de treball clínic: ho estan d'un treball que no és clínic i que perceben com a aliè al sentit de la seva funció.

La segona forma de desgast és més específica i més difícil d'abordar: l'alienació professional, la sensació d'executar tasques el sentit de les quals no es comparteix i sobre les quals no es té capacitat d'influència. Té dues cares. D'una banda, quan els objectius vénen definits des d'instàncies que es regeixen per paràmetres diferents dels de la clínica, els professionals perceben que el seu criteri no compta i que el que saben fer no és el que se'ls demana fer. De l'altra, la formació i els estàndards defineixen com s'hauria de fer cada intervenció —amb quin temps, quina freqüència, quina continuïtat—, però les condicions de la xarxa obliguen a aplicar-la de manera retallada: el professional sap què requeria el cas i no ho pot oferir. No es tracta ja de fer més amb menys, sinó de sostenir la responsabilitat clínica sobre una atenció que un mateix reconeix insuficient. Aques-

ta contradicció permanent entre el judici clínic i l'exigència organitzativa no es resol amb abordatges individuals del desgast —formació en autocura, tallers de gestió emocional—, perquè les seves causes no són individuals.

L'equip com a espai que es buida

Aquestes dinàmiques no recauen només sobre la pràctica individual de cada professional: transformen el funcionament de l'equip com a unitat de treball. En salut mental, l'equip no és una suma de professionals que treballen en paral·lel; és l'espai on es pensa conjuntament sobre els casos, es prenen decisions clíniques compartides, se supervisa la pràctica i se sosté emocionalment un treball que implica contacte continu amb el patiment humà.

La pressió acumulada dels objectius organitzatius, la burocràcia i l'estandardització té un efecte específic sobre els equips: els espais de reunió clínica, supervisió, discussió de casos i reflexió compartida es comprimeixen o desapareixen. En una agenda saturada, el que té suport institucional —un programa que cal implementar, un indicador que cal complir, un protocol que cal activar— desplaça el que no en té; la supervisió clínica no es contempla com a necessària llevat d'una minoria de serveis, i la discussió d'un cas complex no computa com a activitat. A aquesta pèrdua de la funció reflexiva s'hi afegeix la de la funció deliberativa: els criteris que organitzen el treball —quins programes s'implementen, com es distribueixen les agendes, quins indicadors es prioritzen— es defineixen en bona mesura des de les instàncies de direcció i gestió, de manera que l'equip rep els objectius sense intervenir gairebé en la seva definició ni en les condicions de la seva implementació. Es reuneix, així, cada vegada més per gestionar i cada vegada menys per pensar i decidir.

La cobertura de places amb perfils diferents del previst modifica a més el repartiment intern del treball. La formació sanitària especialitzada es cursa durant diversos anys dins de la mateixa xarxa, en règim de supervisió, i genera competències que només es construeixen

allà: el coneixement pràctic de com funciona cada dispositiu en les seves condicions reals i amb quins criteris efectius es deriva o s'accepta una derivació; la capacitat de coordinar-se amb altres recursos de la resta de la xarxa entenent el marc de treball de cada interlocutor; el sosteniment del treball clínic en els casos complexos que escapen de les vies estàndard; el judici clínic sobre la gravetat allà on un protocol no resol; o l'acompanyament formatiu dels qui estan fent la residència. Quan una plaça es cobreix amb un perfil diferent del previst, el lloc queda ocupat però aquesta capacitat funcional es concentra en una part cada vegada menor de l'equip.

Rotació, fuga i pèrdua de coneixement clínic

Totes dues formes de desgast conflueixen en un fenomen que s'ha intensificat en els darrers anys: una rotació elevada en els equips de la xarxa pública. Els professionals se'n van. No necessàriament a la pràctica privada ni per un únic motiu, però se'n van. Les raons són diverses —esgotament, manca de reconeixement, millors condicions en altres àmbits, la percepció que l'especialització no es valora quan es contracta per a les mateixes funcions professionals sense la formació prevista, o senzillament l'acumulació d'anys treballant en condicions que no permeten fer bé la feina—, però el resultat, amb independència dels motius individuals, és una inestabilitat creixent en els equips que afecta directament la qualitat de l'atenció.

Cada sortida té a més un efecte immediat sobre els qui es queden. En equips que ja funcionen al límit de la seva capacitat, la marxa d'un professional obliga a redistribuir la seva càrrega assistencial entre els altres: reassignar casos, absorbir seguiments, cobrir urgències, reorganitzar agendes. Aquesta sobrecàrrega afegida es manté durant tot el temps que la plaça triga a cobrir-se

—que pot ser de mesos— i no desapareix quan arriba algú nou, perquè qui s'incorpora necessita un període d'adaptació al centre, al territori, als circuits i a les persones ateses. Si la rotació és freqüent, el cicle es repeteix i l'equip no arriba mai a establitzar-se.

Cada professional que se'n va s'emporta, a més, anys de coneixement del territori, de les xarxes de coordinació i de les particularitats de la població atesa. Aquest coneixement és inseparable del context en què es genera: no es transfereix en un traspàs de casos ni se substitueix amb una nova incorporació, per competent que sigui, perquè necessita temps i relacions per constituir-se. Quan la rotació és freqüent, els equips perden densitat clínica de manera acumulativa.

Hi ha, finalment, una conseqüència d'ordre diferent que tanca el cercle. Quan les places es cobreixen de manera sostinguda amb perfils diferents del previst, la insuficiència d'especialistes deixa d'aparèixer com un problema de planificació: la cobertura existeix, les agendes s'omplen i el dèficit formatiu es torna invisible justament en el pla on podria corregir-se. El cicle es reproduïx, així, en el període següent.

En un treball on l'instrument principal és la relació humana amb persones que pateixen, l'estat dels professionals i dels equips no és una variable secundària: és una condició fonamental de la qualitat de l'atenció. La Relatora Especial de Nacions Unides sobre el dret a la salut ha documentat aquesta dependència: el desgast professional s'associa amb un augment de la rotació, amb un distanciament creixent respecte a les persones ateses i amb un descens en la seva satisfacció declarada (Mofokeng, 2025b). Un sistema que no cuida els qui cuiden compromet necessàriament el que pot oferir als qui atén.

ENQUESTA A PROFESSIONALS — DESGAST, TEMPS I SUPERVISIÓ

El **80,6%** no disposa de temps suficient per a la reflexió clínica sobre els casos (Pregunta 21; mitjana 1,74/5). Aquesta manca de temps no es reparteix per igual: en la xarxa comunitària exclusiva la valoració cau a **1,35/5**, davant de 2,46/5 en l'hospitalària i d'enllaç, la diferència més gran per àmbit de tota l'enquesta. El **69,7%** no té accés a supervisió externa en el seu dispositiu (Pregunta 27; mitjana 2,10/5). El **62,5%** afirma que la càrrega burocràtica interfereix en la seva pràctica clínica (Pregunta 17). En les respostes obertes, 22 mencions identifiquen la pressió assistencial, els indicadors i les altes forçades com els factors que han empitjorat en els darrers anys; 15 mencions assenyalen la desespecialització com un deteriorament estructural; 11 mencions descriuen l'augment de demanda sense acompanyament de recursos.

«Anar a treballar s'ha convertit en una important font d'estrès i patiment, que acaba repercutint en com acompanyo els meus pacients.»

«Ritme de treball frenètic, moltes derivacions, molt volum de casos, sovint demanda no treballada. Afecten amb burnout, sensació de sobrecàrrega i d'haver de donar respostes ràpides per poder fer entrar altres casos.»

■ 5.4. Individualització del patiment i afebliment de l'enfocament comunitari

La canalització del patiment social cap al circuit sanitari (descrita a 4.8) produeix dues conseqüències encadenades.

La primera és la individualització del patiment: la precarietat laboral es converteix en diagnòstic d'ansietat, la manca d'habitatge en depressió, el conflicte laboral en baixa per trastorn adaptatiu. Problemes les causes dels quals són col·lectives i estructurals reben una resposta clínica individual que no els pot resoldre. Com han assenyalat Johnstone i Boyle (2018), aquest desplaçament obliga a patologitzar experiències que sovint constitueixen respostes comprensibles davant de circumstàncies adverses —pobresa, desocupació, violència, dol—, desposseint el subjecte de la seva narrativa personal i reduint el seu patiment a una disfunció individual.

Bentall (2009) i Johnstone i Boyle (2018) han descrit la medicalització del malestar social com una resposta defensiva d'un sistema que no té temps ni recursos per a l'abordatge psicoterapèutic i comunitari. En la mateixa línia, Pūras (2017), en el seu informe com a Relator Especial de Nacions Unides sobre el dret a la salut, ha vinculat la medicalització del patiment quotidià amb la manca de transparència i amb la influència d'interessos comercials en la investigació i la formació mèdica.

La segona conseqüència és l'afebliment progressiu de l'enfocament comunitari. Si la resposta s'organitza exclusivament com a atenció clínica, el treball amb la comunitat, amb els serveis socials, amb la xarxa de suport de la persona, perd espai i legitimitat institucional. Els professionals no tenen temps per coordinar-se amb serveis socials, amb educació, amb atenció primària més enllà dels circuits formals. El treball de carrer, el contacte amb el teixit associatiu, les intervencions de prevenció no programada, la supervisió a altres dispositius —activitats centrals en un model comunitari— queden relegades perquè no són avaluables, no generen indicadors i no es reconeixen com a activitat assistencial. El model comunitari es proclama en els documents estratègics però es buida a la pràctica.

El programa RBEC il·lustra aquesta dinàmica amb especial nitidesa. La incorporació de professionals etique-

tats com a «comunitaris» s'ha traduït, a la pràctica, en una intensificació de la resposta clínica dins del mateix centre de salut: les intervencions grupals es desenvolupen habitualment als locals del CAP, sobre persones derivades per circuits sanitaris i amb criteris de selecció clínica. L'etiqueta «comunitària» no es trasllada al territori, al teixit associatiu ni als recursos socials de l'entorn; s'aplica a una activitat que continua sent assistencial i que es desenvolupa dins del dispositiu sanitari. Un reforç efectiu del treball comunitari hauria suposat una altra cosa. No només coordinar-se amb serveis socials, habitatge, ocupació o educació, sinó treballar conjuntament amb els recursos del territori —oficines d'ocupació, dispositius d'orientació laboral, centres cívics, entitats del tercer sector, associacions de barri— perquè la resposta al malestar es pugui construir fora del circuit clínic quan el seu origen és fora d'ell. La figura prevista podria haver operat com a agent activador d'aquesta xarxa: un professional amb sensibilitat als determinants socials, capaç d'ajudar la persona a reconnectar amb el teixit social i de mobilitzar els recursos disponibles en el seu entorn, en lloc d'absorbir la demanda dins del CAP. Això hauria requerit, a més, dotar els àmbits no sanitaris —serveis socials, educació social— dels perfils professionals que la mateixa categoria RBEC contemplava sobre el paper i que a la pràctica han quedat al marge del desplegament. Aquesta lectura és coherent amb la literatura sobre determinants socials de la salut mental, que sosté que la prevenció efectiva no s'assoleix afegint programes individuals dins del circuit sanitari, sinó transformant els entorns socials i enfortint els sistemes universals i accessibles que sostenen la vida quotidiana de les persones (Kirkbride et al., 2024).

Aquesta mateixa lògica de canalització al circuit sanitari d'un patiment l'origen i la resolució del qual se situen fora d'ell es reproduïx en un terreny específic: l'articulació entre el sistema assistencial i el sistema avaluador i pericial descrit en el capítol anterior. Les decisions que es prenen en aquest circuit tenen efectes clínics directes. La incertesa prolongada durant mesos d'espera de resolució, les denegacions d'incapacitat o de grau

de discapacitat en persones la situació clínica de les quals no permet la reincorporació laboral o la limitació funcional de les quals resulta efectivament acreditable, i les altes no acordades amb el referent assistencial actuen, en alguns casos, com a factors d'empitjorament del quadre clínic, fins a precipitar episodis de descompensació o conducta autolítica. El contingut del procés terapèutic queda parcialment desplaçat durant setmanes o mesos per la gestió emocional de la incertesa o d'una resolució viscuda com a injusta, i una proporció del temps assistencial es redirigeix a l'elaboració d'informes destinats a procediments d'impugnació administrativa o judicial que poden prolongar-se durant més d'un any, una demora que el Defensor del Poble, en la

seva supervisió de l'Administració General de l'Estat, ha documentat en matèria d'incapacitat permanent (Defensor del Poble, 2019).

Aquesta articulació defineix una forma específica de dany l'origen del qual no se situa en la intervenció clínica sinó en la relació entre sistemes institucionals. Convé anomenar-la com a tal, distingint-la de la cronicació induïda descrita en altres apartats i de la individualització del patiment social en sentit estricte: aquí el patiment que es canalitza al circuit sanitari no prové de l'entorn social genèric sinó del mateix entramat d'avaluació, prestació i certificació, i el sistema assistencial ni l'origina ni el pot resoldre.

ENQUESTA A PROFESSIONALS — INDIVIDUALITZACIÓ I ENFOCAMENT COMUNITARI

El **62,8%** considera que els factors socials no s'aborden de manera integrada a la xarxa (Pregunta 33; mitjana 2,30/5). El **55,5%** discrepa que la pràctica clínica permeti una distinció clara entre malestar vital i trastorn mental (Pregunta 30). El **53,8%** observa que el sistema sanitari ha destinat una part significativa dels recursos a atendre malestar emocional lleu en els darrers anys (Pregunta 32).

«Hiperatenció dels malestars lleus que no són trastorns, sinó conseqüències d'un malestar social. Augment de professionals sense formació per fer front als problemes lleus amb el risc de cronificar o patològitzar el malestar.»

5.5. Inequitat territorial

La configuració del sistema es tradueix en una variabilitat territorial en la resposta assistencial: en funció del lloc de residència, els temps d'espera poden ser diferents i l'accés a determinats programes, dispositius o intervencions específiques no és homogeni. D'aquesta

manera, l'atenció rebuda no depèn únicament de les necessitats clíniques, sinó també de l'organització i disponibilitat de recursos en cada territori, la qual cosa planteja dificultats per garantir plenament els principis d'equitat i justícia social en el conjunt del sistema.

5.6. La paradoxa de l'expansió

Una de les qüestions que qualsevol política pública hauria de poder respondre és si l'augment sostingut dels recursos assignats s'acompanya de millora en els indicadors que aquests recursos pretenen millorar. En el cas de la salut mental a Catalunya, les dades disponibles per a la darrera dècada permeten una primera lectura: el sistema creix —en recursos assignats, en programes implementats i en visibilitat institucional— sense que aquest creixement es tradueixi en una millora equivalent dels indicadors que aquests recursos i programes es proposen millorar.

La paradoxa opera en dos plans que convé examinar separatament. El primer, agregat, és el de la relació entre la despesa pública destinada a salut mental i els indicadors poblacionals que el sistema declara voler millorar. El segon, organitzatiu, és el de l'expansió de programes

i dispositius específics sobre una base troncal que no es reforça al mateix ritme. Tots dos plans comparteixen una mateixa lògica de fons i, al capdavant, una mateixa conseqüència: el que el sistema produeix, avaluat en els seus propis termes, no es correspon amb el que diu voler produir.

El pressupost del Departament de Salut va créixer de 9.789 milions d'euros el 2020 a 13.502 milions en el projecte del 2026, un increment nominal del 38% en sis exercicis. La partida específica de salut mental va passar de 457,5 milions d'euros el 2020 a 589,3 milions en el projecte del 2026 —la xifra de 521,5 milions del 2023, ja recollida en descriure el marc institucional, se situa en el tram intermedi d'aquesta sèrie—, un creixement nominal del 28,8% que es redueix a aproximadament un 6% en termes reals una vegada descomptada la

inflació acumulada del període (Departament de Salut, 2020, 2025). El pes relatiu de la salut mental sobre el conjunt del pressupost del Departament s'ha mantingut, no obstant això, estable entorn del 4,4–4,6% durant tota la dècada, sense acostar-se a la referència del 10% que organismes internacionals situen com a orientativa per a països de renda alta i que ja s'ha comentat en descriure la infradotació material i econòmica del sistema. Hi ha hagut, per tant, un creixement real del pressupost específic, sense que aquest creixement hagi modificat la posició relativa de la salut mental en el conjunt de la despesa sanitària.

Els indicadors poblacionals registrats durant el mateix període no mostren una millora equivalent. La mortalitat per suïcidi a Catalunya va passar d'aproximadament 7,0 defuncions per cada 100.000 habitants en el trienni 2015–2017 a 9,1 el 2023 —màxim de la dècada—, amb un descens provisional a 8,1 el 2024 que continua situant-se per damunt del nivell previ a la pandèmia (Institut d'Estadística de Catalunya, 2024; Institut Nacional d'Estadística, 2025). Els episodis registrats pel Codi Risc Suïcidi van assolir 8.123 el 2023: encara que part de l'increment històric respon a la millora del registre fins al 2018, el creixement sostingut des del 2020 ja no s'explica per aquesta variable. La prevalença de probable problema de salut mental en població infantojuvenil de 4 a 14 anys, mesurada per l'Enquesta de Salut de Catalunya, es va duplicar entre els biennis 2014–2015 (4,2%) i 2020–2021 (11,4%); l'onada del 2023–2024 descendeix al 5,7%, però el canvi metodològic que acompanya aquesta darrera mesura recomana prudència en la interpretació de la inflexió.

El consum farmacològic ofereix una dimensió addicional del mateix fenomen. Les dosis diàries definides d'antidepressius per cada 1.000 habitants i dia a Catalunya van passar de 83,2 el 2019 a 101,2 el 2023, un increment del 21,6% en quatre anys (Ministeri de Sanitat, 2024). El 2023, més d'1,2 milions de persones ateses en la xarxa pública catalana van rebre almenys una dis-

pensació d'antidepressius, i les dades de les farmàcies comunitàries indiquen un creixement addicional del 24% en la demanda acumulada durant el 2025, amb Catalunya concentrant el 18% de la demanda estatal —segona comunitat per volum absolut, per darrere de Madrid— (Cofares, 2025). En perspectiva comparada, Espanya és el tercer país de la Unió Europea en consum d'antidepressius per habitant, només per darrere de Portugal i Suècia, i se situa entre els primers consumidors de l'OCDE, amb una mitjana estatal de 98,8 dosis diàries definides davant de 70,3 en el conjunt de la Unió Europea (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, 2023). En el consum de benzodiazepines, Espanya ocupa de manera sostinguda la primera posició de l'OCDE durant tota la darrera dècada. Catalunya se situa lleugerament per damunt de la mitjana estatal en consum d'antidepressius per habitant, en posició intermèdia entre les comunitats autònomes: lluny dels valors més alts —Galícia (152,2 DHD), Astúries (150,0), Extremadura (141,1)— i també dels més baixos —País Basc (80,9), Madrid (83,5), Navarra (93,7)— (Ministeri de Sanitat, 2024).

La lectura conjunta d'aquestes sèries no permet concloure que l'augment de recursos sigui innecessari; el que mostra és una cosa diferent. L'augment de la inversió, mantingut durant diversos exercicis consecutius i acompanyat de plans estratègics successius, no s'ha traduït en una millora del conjunt d'indicadors que aquests mateixos plans es proposen millorar. Aquesta dissociació entre creixement de la despesa i evolució dels resultats suggereix que la qüestió central no és exclusivament de quantitat de recursos, sinó de la manera en què els recursos disponibles estan organitzats, distribuïts i orientats. El mateix Govern va formular aquesta constatació amb claredat el desembre del 2023, en el marc de la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental, en reconèixer que el sistema actual «no és prou eficaç ni eficient» (Casamitjana i Aguilà, 2023b).

PRESSUPOST I INDICADORS POBLACIONALS 2015–2026

Pressupost del Departament de Salut: 9.789 M€ (2020) → 13.502 M€ (2026); +37,9% nominal.

Pressupost específic de salut mental: 457,5 M€ (2020) → 589,3 M€ (2026); +28,8% nominal (~6% real una vegada descomptada la inflació acumulada).

Pes de la salut mental sobre el pressupost del Departament: estable en 4,4–4,6% durant tota la dècada (referència OMS per a països de renda alta: 10%).

Mortalitat per suïcidi a Catalunya: 7,0 / 100.000 (2015–2017) → 9,1 (2023, màxim de la dècada) → 8,1 (2024, provisional).

Episodis registrats en el Codi Risc Suïcidi: 465 (2014) → 8.123 (2023).

Probable problema de salut mental en població infantojuvenil 4–14 anys (ESCA): 4,2% (2014–15) → 11,4% (2020–21) → 5,7% (2023–24, amb canvi metodològic).

Consum d'antidepressius a Catalunya: 83,2 DHD (2019) → 101,2 DHD (2023); +21,6% en quatre anys.

Espanya en perspectiva internacional: tercer país de la Unió Europea en consum d'antidepressius per habitant; primer país de l'OCDE en consum de benzodiazepines durant tota la darrera dècada.

Catalunya a l'Estat: lleugerament per damunt de la mitjana estatal per habitant; segona comunitat per volum absolut de demanda en farmàcia comunitària (2025).

En el pla organitzatiu, aquest mateix patró es reproduïx a una altra escala. Cada nou programa afegeix coordinacions, derivacions creuades, circuits addicionals i demandes de seguiment que recauen sobre els dispositius troncal. Si la base no es reforça, l'efecte net pot ser

negatiu: més fragmentació, més burocràcia de coordinació, més pressió sobre els CSMA i CSMIJ, i una percepció de millora formal que emmascara un deteriorament real.

ENQUESTA A PROFESSIONALS — L'EXPANSIÓ, VISTA DES DELS PROFESSIONALS

Només el **31,5%** considera que la creació i expansió de nous programes hagi suposat una millora significativa de la resposta assistencial (Pregunta 11; mitjana 2,92/5), i la valoració és encara més crítica entre els qui acumulen més de vint anys d'exercici (mitjana 2,41/5). En paral·lel, el **47,2%** percep que l'organització assistencial prioritza la continuïtat de certs programes per damunt de la indicació clínica de cada cas (Pregunta 15; mitjana 3,46/5).

«Cada vegada més exigències en els temps d'espera, i més desplegament de programes que fragmenten les agendes dels professionals.»

Aquest efecte interpel·la directament la lògica predominant en la política de salut mental: la idea que «fer més» equival a «millorar». En les condicions actuals del sistema, fer més sense canviar el funcionament no millora l'atenció i la pot empitjorar. La creació de programes específics pot ser útil com a estratègia de comunicació política per mostrar innovació i capacitat de resposta

ràpida, però la salut de la xarxa depèn de la robustesa dels seus dispositius troncal. En un sistema organitzat d'aquesta manera, l'expansió —tant la de la despesa agregada com la dels programes— pot ser una forma de deteriorament.

Fer més sense canviar el funcionament no millora l'atenció i la pot empitjorar.

A tall il·lustratiu, diversos programes i iniciatives vigents a Catalunya mostren aquest patró:

Taula 8. Exemples de programes amb risc de fragmentació si no es reforça la base troncal

Programa / Iniciativa	Objectiu declarat	Risc identificat
Codi Risc de Suïcidi (CRS), dins del PLAPRESC 2021–2025	Prevenió del suïcidi mitjançant detecció precoç, atenció i seguiment clínic continuat.	Saturació d'agendes amb activacions que desplacen el seguiment ordinari.
Equips Guia (alta complexitat)	Atenció intensiva en l'entorn per a població jove amb problemes greus de salut mental.	Desconnexió amb els serveis comunitaris de base del territori durant la intervenció.
Referents de Benestar Emocional (RBEC)	Promoure la salut mental i el benestar emocional en atenció primària.	Risc de psicologització de problemes socials. Creació d'un circuit paral·lel al PCP.

Font: elaboració pròpia.

Arribats a aquest punt, convé anomenar el que el conjunt de fenòmens descrits fins ara configura. Al llarg de l'anàlisi s'han descrit situacions recurrents en què l'actuació que el sistema produeix és formalment correcta dins del marc organitzatiu en què té lloc: se segueixen els protocols, s'activen els circuits, es compleixen els indicadors, s'apliquen les instruccions rebudes. I, tanmateix, el resultat, avaluat des de la continuïtat del procés clínic i des de l'adequació a la necessitat de cada persona, és sovint subòptim. La intervenció fa el que el sistema li demana que faci; el problema és que el que el sistema li demana que faci no sempre coincideix amb el que la persona atesa necessita.

Aquest desajust no es pot imputar a la competència individual dels professionals ni a la qualitat aïllada de cada decisió. Procedeix de la coexistència, dins del mateix sistema, de dues lògiques parcialment incompatibles. Una lògica clínic, basada en l'avaluació longitudinal, la individualització i la continuïtat terapèutica. I una lògica institucional, orientada a l'activació de circuits, la traçabilitat de l'activitat i la resposta visible davant de problemes complexos. Quan totes dues no estan prou integrades, el sistema produeix intervencions coherents des del punt de vista procedimental però no des del punt de vista clínic, sense que cap actor concret pugui identificar-se com a responsable.

Smit (2023) ha argumentat que en sistemes sanitaris complexos i fragmentats «fer el que el sistema demana» i «proporcionar bona atenció» deixen de ser la mateixa cosa: el seguiment estricte de procediments no equival necessàriament a una atenció clínicament adequada, i el compliment dels processos administratius pot funcionar com a substitut formal de la responsabilitat clínic. La Relatora Especial de Nacions Unides sobre el dret a la salut ha assenyalat en termes pròxims que els reptes als quals s'enfronta el personal sanitari són estructurals i es tradueixen en condicions de treball —càrregues inassumibles, marcs organitzatius que subordinen el criteri clínic a l'activitat mesurada— que incrementen de manera documentada el risc d'error clínic i de pràctiques inadequades (Mofokeng, 2025).

Es pot anomenar mala praxi estructural aquest fenomen: situacions clínicament subòptimes que no deriven de la decisió d'un professional concret, sinó de les condicions que el sistema imposa sobre l'exercici professional. Anomenar el fenomen permet situar el problema on és: no en la voluntat ni en la competència dels qui treballen a la xarxa, sinó en les condicions sota les quals se'ls demana treballar. És aquesta mala praxi estructural —i no la suma de decisions individuals— la que explica que un sistema amb pressupost creixent i programes en expansió pugui produir, alhora, els indicadors poblacionals descrits a l'inici d'aquest apartat.

ENQUESTA A PROFESSIONALS — CRITERI CLÍNIC I CAPACITAT D'ADAPTACIÓ

El **46,7%** de les respostes obertes sobre l'equilibri entre criteri clínic i directrius organitzatives identifica que les directrius primen sobre el criteri clínic (Pregunta 43; sobre 60 respostes vàlides). El **47,3%** de les respostes obertes sobre la capacitat del model d'adaptar-se a la singularitat i complexitat dels casos afirma que el model no permet aquesta adaptació o ho fa de manera molt escassa (Pregunta 47; sobre 74 respostes vàlides).

«Augment de pressió assistencial i de càrrega burocràtica; algunes DPO* el compliment de les quals suposa una mala praxi i aspectes sobre els quals no tenim control directe.»

* DPO (Direcció per Objectius): sistema de retribució variable vinculada al compliment d'objectius assignats a cada professional o equip.

6. Propostes

Les propostes que segueixen no són una llista de mesures puntuals ni una petició genèrica de més recursos. S'adrecen a les condicions estructurals que l'anàlisi ha identificat com a generadores de les dinàmiques i efectes descrits. No es tracta de fer més del mateix amb més mitjans, sinó de modificar les lògiques que orienten el seu funcionament.

En conjunt remeten a les dinàmiques i els efectes descrits en els capítols anteriors i dibuixen un canvi d'orientació, no un catàleg de mesures independents. El quadre següent les sintetitza en set blocs, que els apartats posteriors desenvolupen un a un.

LES PROPOSTES, EN SÍNTESI

6.1 · Sobre planificació sanitària i formació especialitzada. Planificar els recursos humans segons les necessitats reals d'atenció, no segons les inèrcies pressupostàries i d'acreditació. Un informe públic i periòdic de necessitats de professionals, per perfil i nivell assistencial. Una planificació de la formació especialitzada (PIR, MIR, EIR) ancorada en aquest informe: primer què necessita el sistema, després quantes places. Un model d'unitats docents col·laboratives entre entitats.

6.2 · Sobre l'exercici professional i la cura dels equips. Les condicions en què treballen els professionals i les condicions en què s'atén les persones són la mateixa cosa. Espais de supervisió, reunió d'equip i reflexió clínica reconeguts com a temps de treball, no com a espai residual que competeix amb els indicadors. Reducció de la càrrega burocràtica. Garantir el compliment dels requisits formatius en les contractacions. Espais protegits per a la psicoteràpia en la xarxa ambulatoria.

6.3 · Sobre la formació dels professionals de la xarxa. La formació, abans i durant l'exercici, és alhora cura del professional i responsabilitat tècnica envers les persones ateses. Formació continuada planificada i finançada de manera estable, preferentment presencial, elevant substancialment les vint hores anuals del conveni SISCAT. La residència com a període de formació, no com a cobertura assistencial: supervisió amb temps protegit i millors condicions de la rotació per la xarxa de salut mental.

6.4 · Sobre l'organització de la xarxa. Reforçar primer els dispositius troncal i ordenar el sistema des de l'administració, no respondre a cada demanda amb programes paral·lels. Transparència en l'assignació de recursos. Prioritzar el reforç estructural dels dispositius clau (atenció primària, CSMA, CSMIJ). Supeditar qualsevol programa nou a una valoració prèvia de la seva aportació, el seu impacte sobre els dispositius troncal i la seva integració a la xarxa.

6.5 · Sobre els indicadors i els sistemes d'informació. Reorientar el sistema d'informació del control de l'activitat cap al sosteniment de l'atenció i la trajectòria de la persona. Reorientar els indicadors cap al procés assistencial i la trajectòria de la persona, més enllà de la categoria diagnòstica i el volum d'activitat. Acompanyar cada indicador nou d'una previsió explícita de quina activitat desplaçarà i de si aquest desplaçament resulta clínicament acceptable. Integrar indicadors sobre l'activitat de l'equip i sobre les condicions de l'exercici professional.

6.6 · Sobre la recerca clínica. Incorporar a la xarxa la capacitat de saber si el que fa funciona, per a qui i en quines condicions. Integrar la recerca basada en la pràctica en l'activitat clínica habitual, vinculant dispositius assistencials i grups de recerca. Orientar-la a les preguntes avui sense resposta: quines intervencions funcionen, per a quins perfils i en quines condicions, i el paper dels determinants socials.

6.7 · Sobre el model assistencial, la xarxa comunitària i l'articulació intersectorial. No tot el malestar té solució clínica individual: articular la resposta amb primària, l'àmbit comunitari i la resta de xarxes de benestar. Reforçar els mateixos àmbits dels quals depèn bona part del malestar —habitatge, treball, serveis socials, educació—, assumint que el seu origen i la seva resolució són en gran mesura fora del circuit sanitari. Dotar l'atenció primària de recursos, temps i suport d'acord amb el seu paper central, reforçant la seva orientació comunitària. Comunicar a la població, amb claredat i sense paternalisme, què pot i què no pot oferir el sistema públic de salut mental amb els recursos de què disposa.

■ 6.1. Sobre planificació sanitària i formació especialitzada

La planificació dels recursos humans de la xarxa de salut mental ha de partir d'una valoració del conjunt dels professionals que sostenen l'atenció. Els equips assistencials es componen de psiquiatres, psicòlegs clínics, infermers especialistes en salut mental, treballadors socials, terapeutes ocupacionals, educadors socials, personal administratiu i altres perfils que, en conjunt, fan possible el funcionament quotidià dels dispositius. Una planificació que només contempli alguns d'aquests col·lectius perd de vista que la qualitat de l'atenció depèn de l'equip en el seu conjunt.

6.1.1. Un informe públic i periòdic de necessitats de professionals

La primera proposta és elaborar un informe públic i periòdic sobre les necessitats de professionals de cadascun dels perfils que sostenen la xarxa, per als diferents nivells assistencials —atenció primària, dispositius comunitaris, hospitalaris i rehabilitadors—, amb metodologia transparent i partint de la demanda real, la complexitat atesa i els objectius assistencials declarats.

Perquè aquest exercici sigui útil ha d'incorporar de manera estable la veu dels professionals que coneixen el funcionament quotidià dels dispositius i la de les persones usuàries. L'important és que els qui treballen en el sistema puguin expressar-se —mitjançant enquestes, consultes periòdiques, espais de diàleg en els territoris o qualsevol altre mecanisme que garanteixi una participació real— i que les seves aportacions siguin efectivament recollides i tingudes en compte. El mateix val per a les persones ateses. No es tracta tant de canalitzar la participació únicament a través d'estructures representatives formals com d'assegurar que les dades sobre el funcionament real del sistema arribin als qui prenen les decisions de planificació.

L'elaboració i publicació d'aquest informe correspon al Departament de Salut, en coordinació amb CatSalut i amb el Pla Director de Salut Mental i Addiccions. És la base sobre la qual s'assenten la resta de propostes d'aquest apartat: sense una valoració pública i periòdica de les necessitats reals, les decisions posteriors sobre formació, contractació i dotació queden sense un referent compartit.

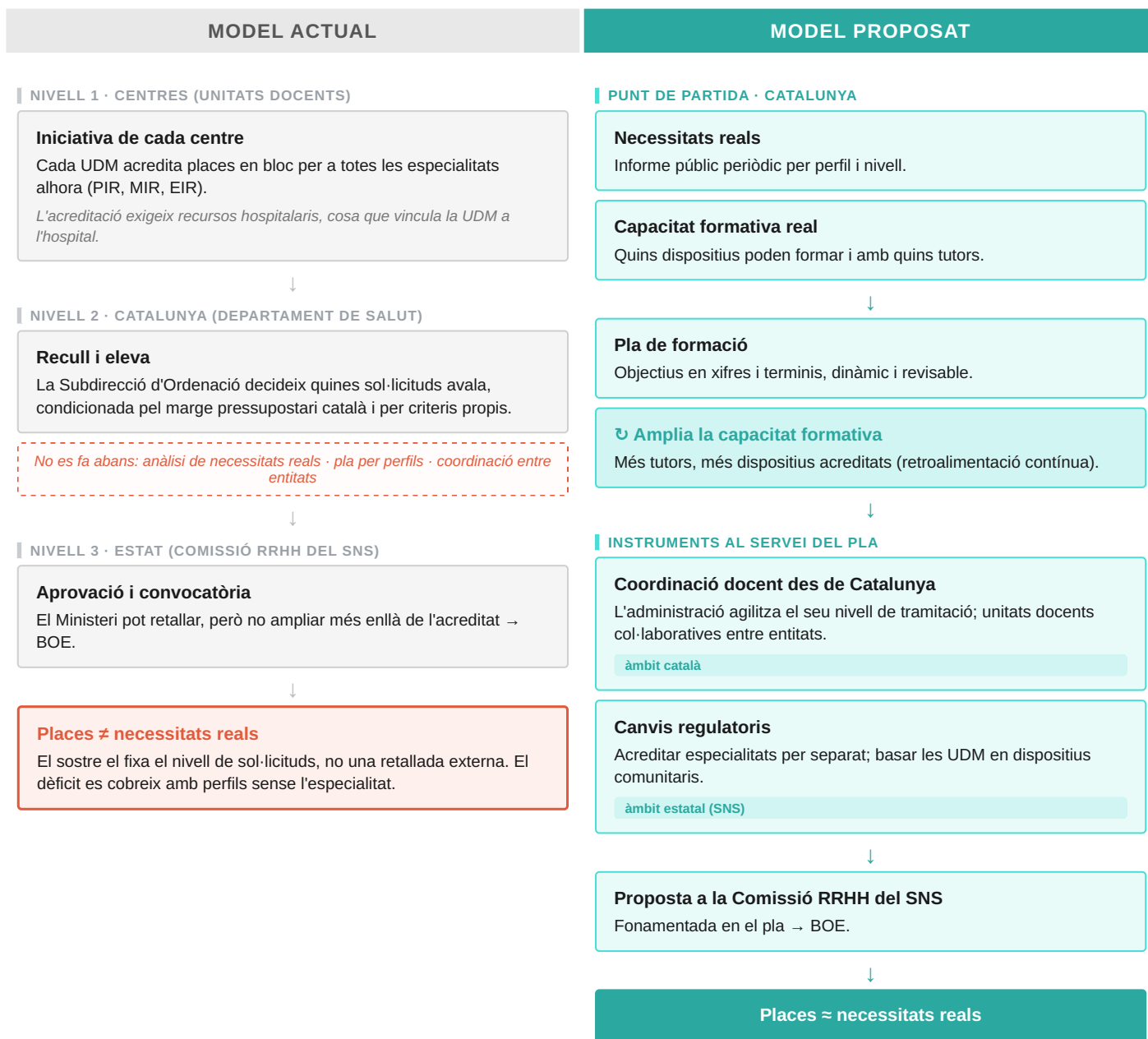
6.1.2. Una planificació de la formació especialitzada ancorada en la realitat

A partir de la valoració general descrita en l'apartat anterior, la planificació específica de places de formació sanitària especialitzada (PIR, MIR de psiquiatria d'adults i de psiquiatria infantil i de l'adolescència, EIR de salut mental, MIR de medicina familiar i comunitària, EIR d'infermeria familiar i comunitària) ha de respondre a les necessitats de cada perfil identificades en aquest informe.

En el model actual, descrit en el capítol de mecanismes, l'oferta anual de places sorgeix de l'agregació de dos elements: el marge pressupostari que en cada exercici resulta disponible i les sol·licituds d'acreditació que les unitats docents aconsegueixen tramitar dins de les restriccions del model. Les places es convoquen, en gran mesura, perquè algunes unitats docents han pogut acreditar-les i perquè el pressupost de l'exercici ho permet, no perquè una anàlisi prèvia hagi establert quantes en necessita el sistema. La planificació que es proposa aquí inverteix aquest ordre: primer es defineix què necessita el sistema —en xifres i en terminis—, i a partir d'aquí es construeix la resta. La previsió pressupostària, l'ampliació de la capacitat acreditada de les unitats docents existents i l'acreditació de noves unitats deixen de ser el punt de partida per convertir-se en instruments al servei d'un pla prèviament fonamentat en necessitats.

Dos models de planificació de la formació especialitzada

El procés té tres nivells de decisió: els centres, l'administració catalana i la Comissió interterritorial. El finançament de cada plaça (salari del resident) el sosté Catalunya; el Ministeri n'aprova i publica l'oferta, però no pot convocar més places de les acreditades.



Aquesta planificació ha d'estar ancorada en la realitat de la xarxa. No pot operar com una declaració d'intencions desconnectada de les capacitats efectives del sistema, ni proposar xifres que cap itinerari formatiu concret pugui absorbir en els terminis previstos. Les xifres de places s'han de sustentar en una anàlisi de quins dispositius poden formar, amb quins tutors, en quins territoris i sota quines condicions materials. Una planificació que ignori aquestes restriccions produeix compromisos que el sistema no pot complir; una planificació que es limiti a ratificar les capacitats existents es queda

curta. L'equilibri entre ambició i viabilitat és el que distingeix un pla d'una expectativa.

La planificació no es pot limitar a la xarxa especialitzada en salut mental: els professionals d'atenció primària són el primer nivell de contacte per a la majoria dels problemes de salut mental de la població, i la seva capacitat per identificar, intervenir i derivar de manera adequada condiona directament la pressió que suporta la xarxa especialitzada. Ignorar les places de formació en atenció primària en planificar els recursos de

salut mental produeix un sistema amb punts cecs estructurals.

El pla ha de ser, a més, dinàmic, amb revisió molt freqüent i capacitat d'ajust continu. Un horitzó temporal clar és útil per fixar objectius, però la planificació no es pot convertir en un compromís tancat per un període de diversos anys: les condicions del sistema canvien amb rapidesa —jubilacions, baixes prolongades, sortides cap a altres àmbits, variacions en la demanda assistencial— i els recursos formatius s'han d'ajustar en conseqüència. La planificació ha de contemplar també un marge raonable per a situacions imprevistes: baixes per malaltia, permisos, substitucions. Assumir que la plantilla teòrica equival a la plantilla efectiva en cada moment condueix a equips que treballen en condicions permanentment tensionades, en què qualsevol absència imprevista es trasllada en sobrecàrrega a la resta de l'equip. La planificació ha de contemplar a més les dificultats específiques de Catalunya: pluralitat de proveïdors, fragmentació de la xarxa i coordinació entre unitats docents.

La responsabilitat sobre aquest pla correspon al Departament de Salut, que articula la planificació de la formació sanitària especialitzada i eleva les propostes a la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut.

6.1.3. Contractació ajustada al marc legal i visibilització dels dèficits

Les contractacions en la xarxa pública s'han d'ajustar al marc legal vigent, que estableix criteris mínims de qualificació per a cada categoria professional, sense excepcions per contenció de costos o urgència de cobertura.

Quan no sigui possible cobrir una plaça amb el perfil requerit per insuficiència de professionals disponibles, la resposta no pot ser contractar algú amb un perfil diferent del previst. El mateix sistema disposa de vies de resposta que es mantenen dins del marc normatiu: ampliar la difusió de les convocatòries per arribar al conjunt d'especialistes potencialment disponibles; redistribuir temporalment la càrrega entre els professionals especialistes del mateix dispositiu o d'altres dispositius del proveïdor o del territori, condicionant aquesta redistribució a la suspensió o reducció simultània d'alguna activitat que es consideri menys prioritària; mantenir la plaça vacant mentre es convoca de nou amb condicions més atractives; i, quan la insuficiència es produeix en crear o ampliar un programa, ajustar el calendari de desplegament al ritme al qual el sistema forma especialistes. Cap d'aquestes vies no és ideal,

però totes són preferibles a una contractació que redueix la qualitat assistencial, altera el marc normatiu i consolida la insuficiència com a solució.

Alhora, aquesta dificultat s'ha de comunicar al Pla Director de Salut Mental i Addiccions i al Departament de Salut, de manera que la necessitat quedi registrada com a evidència d'insuficiència formativa en aquella especialitat i integrada en els cicles de planificació següents. Mentre aquesta comunicació no sigui sistemàtica, el dèficit romandrà invisible per als qui tenen capacitat de corregir-lo, i la contractació fora de perfil continuarà presentant-se com una solució en lloc de com un símptoma.

El compliment d'aquests criteris correspon a l'administració sanitària. Al Departament de Salut, en la seva funció d'ordenació professional, inspecció i control. A CatSalut, en la seva funció de contractació de serveis amb les entitats proveïdores del SISCAT, on disposa d'instruments directes —contractes-programa, clàusules de seguiment, indicadors lligats a la contractació— per exigir el compliment del marc normatiu de qualificació. Les entitats proveïdores funcionen, legítimament, amb lògiques organitzatives pròpies —sostenibilitat econòmica, continuïtat dels concerts, gestió de plantilles—, però aquestes dinàmiques no poden prevaler sobre l'obligació pública de garantir una atenció de qualitat a les persones. Quan les dues lògiques entren en tensió, correspon a l'administració sanitària intervenir perquè l'interès ciutadà es mantingui com a criteri rector.

6.1.4. Transparència de plantilles i mecanismes per reforçar la captació

A les propostes anteriors s'hi afegeix una condició de transparència que afecta directament la planificació. En l'actualitat no existeix informació pública sistemàtica sobre la composició efectiva de les plantilles de cada dispositiu de la xarxa, distingint perfils formatius i categories professionals contractades. Aquesta opacitat dificulta dimensionar el dèficit real d'especialistes i limita la possibilitat d'avaluar si les decisions de contractació s'ajusten al marc normatiu aplicable. Establir mecanismes de transparència pública sobre la composició de les plantilles —per dispositiu, perfil professional i categoria— és una condició necessària perquè les decisions de planificació es recolzin en dades verificables i no en estimacions agregades.

En aquest mateix sentit, seria útil crear una plataforma pública unificada d'ofertes de feina en la xarxa de salut mental catalana, gestionada per l'administració sanitària.

ria, en què les entitats proveïdores del SISCAT publiquin de manera centralitzada les places vacants i els professionals interessats puguin registrar-se com a candidats. Aquesta plataforma seria un instrument de visibilitat i de centralització de la informació, no un mecanisme de regulació del règim de contractació de les entitats. Avui les ofertes es distribueixen per canals propis de cada entitat, la qual cosa dificulta tant que els professionals tinguin visió de conjunt del mercat públic de treball com que l'administració pugui identificar quines places queden sistemàticament sense cobrir, en quins territoris i amb quins perfils. Un instrument d'aquest tipus milloraria la capacitat del sistema per detectar dèficits reals en temps útil.

Al costat de la plataforma, hi ha altres vies complementàries per millorar la captació de professionals especialistes, especialment en territoris i perfils on la cobertura resulta més difícil. La revisió de les condicions ofertes en les convocatòries n'és una: el sector privat i altres sistemes autonòmics competeixen pel mateix conjunt limitat d'especialistes, i mantenir condicions poc competitives es tradueix de manera directa en places que no es cobreixen. En segon lloc, la possibilitat de retribuir formalment hores extra als professionals especialistes ja integrats en els dispositius, en condicions regulades i voluntàries, pot oferir una resposta legal a situacions de cobertura temporal. En tercer lloc, la difusió de les convocatòries s'ha d'estendre més enllà dels canals propis de cada entitat: a les associacions professionals de les especialitats implicades dins i fora de Catalunya, als col·legis professionals, a les unitats docents de l'Estat, a les xarxes en què es mouen els professionals acabats d'especialitzar. Una plaça que no arriba a oïdes dels potencials candidats no es pot considerar, en rigor, una plaça no coberta per manca de professionals.

6.1.5. Articulació amb la planificació dels espais físics

La planificació de recursos humans s'ha de considerar de manera articulada amb la planificació dels espais físics en què aquests professionals treballen. L'ampliació de plantilles requereix disposar de despatxos, sales de consulta, espais per a entrevistes familiars, sales per a intervencions grupals i zones adequades per al treball d'equip. Les dades de l'enquesta situen en el 73,3% la proporció de professionals que identifiquen limitacions estructurals d'espai que dificulten ampliar la plantilla, la qual cosa indica que aquesta condició material és, en molts territoris, el primer coll d'ampolla.

CatSalut, en la seva funció de contractació de serveis i de finançament de les entitats proveïdores, ha de conèixer la situació de cada dispositiu en aquest aspecte, dotar les entitats dels recursos necessaris per garantir espais suficients i adequats, i fer seguiment d'aquesta dotació. Contractar professionals sense disposar d'espais on puguin exercir la seva tasca, o forçar diversos professionals a compartir un mateix despatx de manera estructural, són situacions que comprometen directament la qualitat de l'atenció.

6.1.6. Millores en la regulació de les Unitats Docents Multiprofessionals

Els colls d'ampolla descrits en el capítol de mecanismes —el model d'UDM centrat en l'hospital d'aguts i el còmput de la ràtio resident-adjunt limitat a l'entitat titular— condicionen estructuralment la capacitat formativa del sistema. La seva correcció requereix actuar en dos plans: l'estatal, mitjançant modificacions regulatòries que s'han de promoure en el marc del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut; i el català, mitjançant un model d'unitats docents col·laboratives entre entitats proveïdores coordinat per l'administració sanitària. El detall tècnic de totes dues propostes es desenvolupa en els requadres que segueixen.

MODIFICACIONS REGULATÒRIES EN EL MARC ESTATAL

Es proposen dues modificacions en el funcionament de les Unitats Docents Multiprofessionals (UDM) de Salut Mental, a promoure en el marc del Consell Interterritorial del SNS.

Primera. Acreditació i ampliació de places per especialitat. En el model actual, l'acreditació o ampliació de places es gestiona a escala de la unitat en el seu conjunt, la qual cosa significa que qualsevol modificació de la capacitat docent d'una especialitat —encara que els seus requisits siguin independents i els seus tutors i programa formatiu siguin propis— s'ha de tramitar dins d'un procediment que involucra totes les especialitats de la unitat simultàniament. La modificació proposada permetria tramitar l'acreditació o l'ampliació de places de manera independent per a cada especialitat, avaluant els seus requisits específics de manera autònoma. Això agilitaria la resposta del sistema davant de dèficits diferenciats: el de psicòlegs clínics no coincideix amb el de psiquiatres o infermers de salut mental.

Segona. Flexibilització dels criteris d'acreditació. Els requisits vigents (Ordre PCM/205/2023, annex III) exigeixen que la unitat compti amb un conjunt definit de dispositius que inclou unitat d'hospitalització breu d'adults i, per a la formació en psiquiatria infantil i de l'adolescència, unitat d'hospitalització infantojuvenil. A la pràctica, aquesta exigència vincula l'acreditació a la disponibilitat d'un hospital d'aguts com a centre coordinador, tot i que la major part de la formació especialitzada en psicologia clínica i en psiquiatria es desenvolupa en dispositius ambulatoris i comunitaris. La proposta consisteix a habilitar que aquests dispositius puguin constituir-se en base principal de la unitat docent i que l'accés als recursos hospitalaris necessaris s'articuli a través de convenis entre entitats. Existeix ja un precedent directe: les UDM d'Atenció Familiar i Comunitària (Ordre PRE/861/2013) es construeixen sobre xarxes de dispositius d'atenció primària, amb l'hospital com a recurs complementari de rotació, i permeten convenis de col·laboració entre entitats de diferent titularitat.

UN MODEL D'UNITATS DOCENTS COL·LABORATIVES COORDINAT PER L'ADMINISTRACIÓ

Més enllà de les modificacions en el marc estatal, Catalunya pot avançar en l'àmbit propi promovent un model d'unitats docents col·laboratives entre entitats proveïdores diferents.

En el sistema actual, la formació sanitària especialitzada tendeix a organitzar-se dins dels límits de cada entitat: cada organització articula les seves pròpies rotacions amb els seus propis recursos, la qual cosa fa que les possibilitats formatives quedin condicionades al que cada entitat pot oferir de manera autònoma. Això és especialment limitant en els casos en què una entitat té dispositius comunitaris sòlids però no disposa d'unitat d'hospitalització d'aguts, o a la inversa. La resposta no hauria de ser que cada entitat construeixi per separat el que li falta, sinó que es promoguin acords de rotació entre entitats —mitjançant convenis o marcs de col·laboració coordinats per l'administració— que permetin que els residents d'una organització accedeixin als recursos específics d'una altra quan el programa formatiu ho requereixi. Avançar en aquest model requereix que l'administració sanitària assumeixi un paper actiu de coordinació: les entitats proveïdores competeixen entre si en la lògica del sistema, i és poc probable que aquest tipus de col·laboració es consolidi de manera espontània sense un marc que la incentivi i la reguli. L'objectiu és que les necessitats de places de formació especialitzada no quedin bloquejades pels interessos o limitacions de cada entitat per separat, sinó que es puguin resoldre a través d'una xarxa docent que és, en última instància, de titularitat pública.

■ 6.2. Sobre l'exercici professional i la cura dels equips

Els funcionaments descrits en l'apartat que tracta sobre la càrrega assistencial, temps de consulta i burocràcia, així com les conseqüències documentades en l'apartat sobre desgast, alienació i rotació professional produeixen un resultat que té implicacions directes sobre la qualitat de l'atenció: en salut mental, les condicions en què treballen els professionals no són un assumpte separat de les condicions en què són ateses les persones. Són la mateixa cosa. Les propostes d'aquest apartat parteixen d'aquesta premissa i s'ordenen en sis plans.

En salut mental, les condicions en què treballen els professionals no són un assumpte separat de les condicions en què són ateses les persones. Són la mateixa cosa.

Espais de supervisió, reflexió i sosteniment

Garantir espais de supervisió clínica, reunió d'equip i reflexió compartida com a part del temps de treball reconegut i planificat, amb la mateixa condició que qualsevol altra activitat assistencial: no com a espai residual que competeix amb els indicadors. Les dades de l'en-

questa situen aquesta dimensió com una de les més compromeses del treball quotidià: el 80,6% dels professionals declara no disposar de temps suficient per a la reflexió clínica sobre els casos i el 69,7% no té accés a supervisió externa en el seu dispositiu. Una majoria àmplia de la xarxa opera, per tant, sense les condicions mínimes que el mateix treball clínic requereix per sostenir-se.

Càrrega assistencial

Definir referències públiques de càrrega assistencial màxima raonable en funció del tipus de dispositiu, la complexitat atesa i el temps de visita necessari per a cada perfil. Les dades de l'enquesta situen el 70,4% dels professionals de consulta externa amb més de cent persones en seguiment actiu simultani, i el 20,9% amb més de dues-centes. Aquestes xifres haurien de constituir el punt de partida per a una negociació pública sobre ràtios màximes ajustades per perfil de dispositiu i característiques de la població. L'absència de referències públiques transfereix la decisió a la gestió de cada dispositiu, sense criteris compartits ni possibilitat de rendició de comptes. Aquest replantejament és a més la condició material perquè es pugui dur a terme en la xarxa ambulatoria una pràctica que avui resulta estructuralment impossible en la major part dels dispositius comunitaris: el seguiment psicoterapèutic amb un enquadrament suficient.

Reducció de la càrrega burocràtica

Reduir la càrrega burocràtica mitjançant personal de suport amb formació específica per gestionar la interfície entre l'activitat clínica i el registre institucional. No es tracta d'incorporar personal administratiu genèric, sinó de perfils capaços d'assumir la gestió de cites, tramitació de derivacions, redacció d'informes administratius i seguiment d'incidències en els sistemes informàtics, alliberant temps assistencial sense deteriorar la qualitat del registre. És una intervenció de cost limitat amb impacte directe sobre el temps disponible per a l'atenció directa.

Adequació dels perfils a les necessitats assistencials

Garantir el compliment dels requisits formatius en les contractacions, evitant que la cobertura amb perfils diferents del previst s'utilitzi com a mecanisme de contenció de costos o de cobertura ràpida. Quan es contracta per a funcions especialitzades professionals sense l'especialitat requerida, no només es deteriora la qualitat de l'atenció: també se situa el professional en una posició d'exercici que supera la seva competència

acreditada, amb les conseqüències sobre el seu benestar i sobre la seguretat de les persones ateses que això implica.

Condicions laborals i desenvolupament professional

Dissenyar condicions laborals que reconguin la càrrega real del treball en salut mental, incloent-hi la seva dimensió emocional, i incorporar la participació efectiva dels equips en les decisions que afecten l'organització del seu treball. Crear estructures de desenvolupament professional que incentivin la permanència dels professionals especialitzats en el sistema públic i que reconguin l'aportació dels professionals amb més experiència al funcionament dels equips i a la formació dels més joves.

Espais protegits per a la psicoteràpia en la xarxa ambulatoria

S'ha assenyalat que les condicions de temps i freqüència amb què opera la xarxa comunitària fan impossible sostenir un procés psicoterapèutic estructurat. Aquesta impossibilitat no és marginal: en els dispositius ambulatoris troncats —CSMA, CSMIJ i CAS— es concentra la major part del tractament de continuïtat de la xarxa pública.

La sortida que es proposa aquí no consisteix a pretendre que totes les persones ateses en aquests dispositius rebin psicoteràpia. La indicació psicoterapèutica és una indicació clínica específica: requereix capacitat de reflexionar sobre el propi malestar, motivació per al treball terapèutic, possibilitat de construir una formulació compartida del problema i possibilitat de sostenir un enquadrament regular. No totes les persones ateses estan en aquest moment clínic, i per a una part important de la població la resposta adequada és d'una altra naturalesa. La psicoteràpia, quan està indicada, és una de les eines del dispositiu, no l'única.

El que es proposa és reconèixer institucionalment aquesta indicació quan existeix i reservar dins de l'agenda dels dispositius els espais necessaris per sostenir-la. A la pràctica, això implica que un percentatge del temps assistencial de cada professional de psicologia clínica —dimensionat en funció de la població atesa, la complexitat del dispositiu i el perfil de la demanda— s'assigni formalment a enquadraments psicoterapèutics, amb condicions de freqüència, durada de la sessió i continuïtat d'acord amb la indicació clínica. Aquests espais han de ser indicats clínicament, avaluats i diferenciats del seguiment general en el sistema d'informació.

Aquesta diferenciació no introdueix una jerarquia entre formes d'atenció. El seguiment de suport, la intervenció breu i el control simptomàtic són intervencions vàlides per als qui les requereixen. El que la proposta corregeix

és la situació actual, en què tota l'activitat ambulatoria opera sota un mateix format —el seguiment successiu de durada curta i freqüència espaiada— al marge del tipus d'intervenció que cada cas requeriria.

CRITERIS TÈCNICS D'UN ENQUADRAMENT PSICOTERAPÈUTIC

Indicació clínica. La inclusió en un enquadrament psicoterapèutic requereix una valoració prèvia que confirmi la indicació. Són criteris rellevants: la capacitat de reflexionar sobre el propi malestar i d'establir connexions entre vivències actuals i patrons de funcionament; la possibilitat de construir una formulació compartida del problema; la motivació per al treball terapèutic; la capacitat de col·laborar en la definició d'objectius terapèutics concrets; i la capacitat per sostenir el vincle terapèutic. Aquesta valoració correspon al professional de psicologia clínica que conduirà la intervenció: qui indica és qui elabora la formulació del cas i qui la sosté al llarg del treball terapèutic. La indicació es recolza en una formulació psicològica del cas més que en una categoria diagnòstica (Division of Clinical Psychology, 2011).

Situacions que requereixen una altra forma d'atenció. Determinades situacions clíniques requereixen intervencions de més intensitat o de naturalesa diferent: situacions agudes i de crisi (risc suïcida imminent, episodi psicòtic no estabilitzat), deteriorament cognitiu o quadres que limiten greument la capacitat d'elaboració, situacions d'alta desorganització vital o social que impedeixen sostenir un enquadrament regular, i demandes centrades exclusivament en la gestió de recursos.

Condicions de l'enquadrament. Durada de sessió orientativa: 45 minuts. Freqüència mínima quinzenal en fase activa del tractament, amb possibilitat d'espaiament progressiu en fase de tancament. Nombre de sessions flexible, vinculat al model terapèutic i a la complexitat del cas, no fixat per defecte institucional. Acord explícit sobre les condicions de l'enquadrament en el moment de la indicació.

Diferenciació en el sistema de registre. L'enquadrament psicoterapèutic s'ha de diferenciar del seguiment general en el sistema d'informació, de manera que l'activitat psicoterapèutica sigui identificable com a tal, amb els seus propis indicadors de procés —freqüència efectiva, durada mitjana, continuïtat del referent— i de resultat.

6.3. Sobre la formació dels professionals de la xarxa

Si el principal instrument de la pràctica clínica en salut mental és el mateix professional, les condicions en què aquesta persona es forma —abans d'incorporar-se a la xarxa i durant tot l'exercici— condicionen directament el que pot oferir. La formació és, en aquest sentit, una doble qüestió. És una forma de cura del professional, al mateix nivell que les descrites en l'apartat anterior. I és, alhora, una responsabilitat tècnica del sistema envers les persones ateses, que tenen dret a rebre una atenció prestada per professionals amb la competència necessària per sostenir-la.

Formació continuada

Planificar i finançar de manera estable la formació continuada dels professionals de la xarxa de salut mental, a partir d'una avaluació sistemàtica de les necessitats formatives dels equips. Aquesta formació ha de ser preferentment presencial, ajustada al perfil professional i al nivell assistencial, i dissenyada amb participació directa dels professionals, prioritzant els continguts que aquests identifiquen com a insuficients en la seva pràctica: abordatge de la complexitat, treball intersectorial, coordinació entre dispositius, maneig de situacions de crisi.

El punt de partida convencional no convida a l'optimisme: el conveni SISCAT, que regula les condicions laborals de bona part dels professionals de la xarxa, estableix vint hores anuals de formació continuada. Elevar substancialment aquest llindar és una condició prèvia a qualsevol planificació formativa amb vocació d'impacte real.

Una condició pràctica que sovint es passa per alt és l'antelació amb què les activitats formatives es convoquen. Els professionals de la xarxa treballen amb agendas assistencials molt ajustades, en què reservar temps per a una formació requereix reorganitzar visites i coordinar-se amb companys. Les convocatòries publicades amb poques setmanes de marge queden, a la pràctica, accessibles només per als qui disposen de més disponibilitat, la qual cosa esbiaixa l'accés a la formació i deixa fora precisament els professionals amb més sobrecàrrega assistencial. Una planificació amb diversos mesos d'antelació, amb calendaris anuals públics i estables, permetria que la formació arribés al conjunt del col·lectiu.

Una estratègia formativa conjunta amb l'atenció primària

Com s'ha exposat en els capítols sobre l'organització del sistema i sobre l'escassetat de professionals especialitzats, l'atenció primària és, a la pràctica, el lloc on s'atén la major part del malestar emocional que arriba al sistema sanitari públic. Les dades del Baròmetre Sanitari reforcen aquesta lectura: entre els qui manifesten haver necessitat atenció per un problema de salut mental dins de la sanitat pública, el 41,2% va ser atès en primera instància pel seu metge o metgessa de família, davant del 33,3% atès per un psiquiatre (Ministeri de Sanitat i CIS, 2023). Reforçar les competències i els recursos del primer nivell en aquest àmbit no és una proposta menor adreçada a alleugerir la xarxa de salut mental: és una condició perquè la població rebi una resposta adequada en el lloc on efectivament planteja la majoria dels seus problemes de salut mental.

L'atenció primària disposa d'eines pròpies per acollir i intervenir sobre el malestar emocional —l'escolta activa, el vincle longitudinal, l'entrevista clínica, la contenció, la medicina narrativa, la prescripció social, la indicació de no-tractament i diverses formes estructurades de suport psicològic—, i existeixen marcs elaborats des de la mateixa primària que les sistematitzen (Castelló et al., 2016). La qüestió no és desplaçar els professionals de primària del treball amb la salut mental, sinó reconèixer i reforçar l'espai clínic propi en què ja intervenen, dotar-los de les condicions de temps i formació necessàries, i articular aquesta intervenció amb la xarxa de salut mental quan el cas ho requereix.

Això exigeix construir una estratègia formativa conjunta entre la xarxa de salut mental i l'atenció primària, que cobreixi dos plans complementaris. El primer, la rotació dels residents de medicina familiar i comunitària i d'infermeria familiar i comunitària pels dispositius de salut mental, que s'hauria de dissenyar i dotar en conseqüència, amb tutors assignats, objectius clars, temps de supervisió i un pes curricular d'acord amb la centralitat que la salut mental té en la consulta de primària. El segon, la formació continuada específica dels professionals de primària ja en exercici, orientada a les eines que el seu nivell assistencial requereix: tècniques estructurades d'exploració breu, criteris clars i compartits de derivació i interconsulta, i eines que facilitin el treball conjunt amb els dispositius de salut mental.

Formació dels residents

La residència és un període de formació, no un mecanisme de cobertura assistencial. Aquesta distinció, evident sobre el paper, es difumina sovint en la pràctica quotidiana: quan falten adjunts, quan s'acumulen llistes o quan un dispositiu opera per sota de la seva plantilla, una part de la càrrega tendeix a desplaçar-se cap als residents, que assumeixen funcions que excedeixen el que el seu moment formatiu permet. Sostenir el caràcter formatiu de la residència exigeix dimensionar les plantilles d'adjunts de manera que el funcionament ordinari no depengui del treball dels residents, i protegir el seu temps de formació davant de les necessitats conjunturals dels dispositius.

Sobre aquesta base, les condicions que la residència necessita per complir la seva funció són tres. Primera, supervisió clínica regular amb temps específicament protegit, tant del resident com del tutor. Segona, una formació coherent amb els valors i criteris que el mateix sistema declara: la comprensió integral del cas clínic més enllà de la categoria diagnòstica, la perspectiva dels drets humans com a marc transversal, la relació terapèutica com a instrument de treball, l'abordatge del patiment d'origen contextual o social, i el treball en equip. Tercera, mecanismes efectius de participació dels residents en el disseny i l'avaluació del seu propi itinerari formatiu.

En aquest marc, el programa de formació transversal que Catalunya ofereix als residents de les tres especialitats de salut mental —psicologia clínica, psiquiatria i infermeria de salut mental— constitueix una oportunitat d'intervenció directa sobre els estàndards clínics del sistema, però perquè compleixi aquesta funció s'ha de dissenyar partint d'un diagnòstic de les competències que s'identifiquen com a insuficients en la pràctica. El disseny ha de combinar un pla transversal de continguts compartits amb un pla específic que respecti les fortaleeses pròpies de cada disciplina —psicoteràpia, coneixement farmacològic, cures de salut mental, acompanyament longitudinal— sense que el nivell del conjunt s'ajusti a un mínim comú denominador que empobreix l'oferta per a tothom.

Supervisió clínica

Establir la supervisió clínica com a part reconeguda i finançada de l'exercici professional en la xarxa de salut mental, tant per als residents en formació com per als professionals adjunts. La supervisió no és una activitat complementària: és una condició de la qualitat de l'atenció i un mecanisme de prevenció del desgast pro-

fessional. Les dades de l'enquesta situen en el 69,7% la proporció de professionals que no disposa d'accés a supervisió externa en el seu dispositiu.

Independència de la formació respecte a la indústria farmacèutica

Garantir que la formació en psicofarmacologia adreçada a residents de psiquiatria i de medicina familiar, així com als metges adjunts de la xarxa, estigui finançada de

manera pública i independent, sense participació directa ni indirecta de la indústria farmacèutica. L'objectiu és que aquests professionals puguin accedir a una formació crítica, analítica i basada en evidència sobre l'ús de medicació —que inclogui amb igual rigor els seus beneficis, els seus límits i les seves alternatives— sense que els continguts quedin condicionats per interessos comercials.

6.4. Sobre l'organització de la xarxa

Disposar d'un mapa actualitzat i accessible de tots els programes i dispositius existents en salut mental a Catalunya, que reculli, per a cadascun: els seus objectius assistencials, la població que atén, el seu cost econòmic, els professionals implicats, els criteris d'accés i de derivació, l'entitat proveïdora responsable i la zona territorial coberta. Aquest mapa ha de permetre identificar quines unitats suprasectorials existeixen i quins territoris cobreixen, on se solapen dispositius amb poblacions diana similars, i quins circuits de derivació operen entre nivells. La utilitat d'aquest instrument no és merament descriptiva: és la base per detectar duplicitats, llacunes territorials i descoordinacions, i per planificar la reorganització de la xarxa amb coneixement real de l'estat del sistema.

Garantir que els criteris de derivació i interconsulta de cada dispositiu siguin explícits i estiguin articulats entre els dispositius d'un mateix territori, amb independència de l'entitat proveïdora d'origen i de destinació. No es tracta d'homogeneïtzar els criteris a tota Catalunya, sinó que, dins de cada zona, els criteris d'accés i derivació de cada dispositiu siguin clars i encaixin entre si: que no se solapin poblacions diana ni circuits sobre un mateix territori i que no quedin, en l'espai entre dispositius, persones sense un destí definit. Aquests criteris s'han d'acompanyar d'eines adequades: convé revisar els canals pels quals actualment circula la informació clínica entre dispositius, ja que les derivacions que es gestionen per correu electrònic o missatgeria no segura introdueixen riscos de privadesa evitables. El sistema ha d'oferir canals segurs, àgils i comuns a totes les entitats per a la comunicació clínica entre dispositius.

Garantir la transparència en l'assignació de recursos: quin finançament públic es destina a cada dispositiu, programa o entitat, amb quins criteris i amb quins objectius. Reforçar el paper de l'administració sanitària com a instància ordenadora del sistema, evitant que

l'atenció s'organitzi a partir de dinàmiques competitives entre entitats.

Prioritzar el reforç estructural dels dispositius clau del model —atenció primària, CSMA i CSMIJ— com a via principal per millorar la capacitat de resposta del sistema. Reforçar aquests dispositius no significa afegir-los programes addicionals, sinó dotar-los dels mitjans necessaris —plantilles suficients, temps de consulta raonable, espais adequats, suport administratiu— perquè puguin desenvolupar la seva funció amb uns mínims que en l'actualitat no estan garantits. La creació de programes paral·lels no s'ha d'excloure per principi, però sí supeditar-se a una valoració prèvia: quina és la seva aportació específica respecte al que ja existeix, quin impacte tindrà sobre els dispositius troncats, i com s'integra amb la resta de la xarxa.

Al costat d'aquestes mesures de caràcter general, convé revisar de manera explícita aquells programes la implementació efectiva dels quals s'allunya del seu disseny formal.

Un exemple és el Codi Risc Suïcidi (CRS). Com s'ha assenyalat en el capítol de mecanismes, aquest protocol opera en alguns territoris també com a via administrativa d'accés a una primera visita preferent, una desviació respecte del seu disseny que justifica revisar-ne el funcionament. La revisió s'hauria d'abordar en diversos plans. En primer lloc, avaluar el funcionament de l'aplicatiu informàtic que sosté el circuit: en la seva configuració actual resulta feixuc d'emplenar i consumeix temps assistencial que hauria d'estar dedicat a la valoració clínica. En segon lloc, avaluar l'eficàcia real del programa en termes del seu objectiu declarat —la prevenció del suïcidi— i no únicament en termes del seu nivell d'activació, partint dels suïcidis consumats registrats pel sistema i analitzant retrospectivament quina proporció d'aquestes persones estava inclosa en el circuit. En tercer lloc, considerar l'impacte dels falsos positius: quan el protocol s'activa sobre persones que

no presenten un risc elevat, aquestes activacions consumeixen primeres visites prioritàries i temps de seguiment intensiu que poden estar traient-se de persones amb risc suïcida efectiu. I, en quart lloc, reforçar la formació dels professionals en intervenció clínica davant de situacions de crisi i de risc suïcida.

Un altre programa que requeriria revisió seria el programa de Referents de Benestar Emocional Comunitari (RBEC). Si l'activitat efectivament desplegada en aquests llocs s'ajusta al pla funcional —promoció i prevenció comunitària, intervencions grupals no clíniques—, la resposta ha de ser garantir que la contractació s'obre realment a la pluralitat de perfils previstos i reorientar l'activitat cap a l'àmbit comunitari, no cap a l'atenció clínica individual. Si, per contra, les funcions efectives tenen caràcter clínic, les contractacions s'han d'ajustar al marc normatiu aplicable i el desplegament

del programa articular-se amb el Programa de Col·laboració amb l'Atenció Primària (PCP) per evitar circuits paral·lels en el mateix dispositiu.

Finalment, convé revisar el model de contractació per activitat descrit en el capítol 3. Quan una part significativa del finançament dels dispositius depèn del volum d'activitat quantificable —i, en particular, de les primeres visites— i no del procés terapèutic sostingut, els incentius econòmics del sistema s'alineen amb mètriques que no reflecteixen la qualitat de l'atenció. Avançar cap a un model en què el finançament reconegui també la freqüència de seguiment, la continuïtat del referent clínic, la complexitat dels casos atesos i les activitats de coordinació és una condició perquè l'organització del treball s'ajusti a les necessitats clíniques i no al càlcul agregat de l'activitat facturable.

■ 6.5. Sobre els indicadors i els sistemes d'informació

Les dinàmiques descrites en el capítol de funcionament del sistema —la categorització diagnòstica com a condició de visibilitat, la priorització de l'activitat sobre el procés, la interacció no avaluada entre indicadors i la càrrega administrativa que el seu manteniment trasllada al temps clínic— configuren un sistema d'informació orientat al control de l'activitat més que al sosteniment de l'atenció. Les propostes que segueixen s'adrecen a modificar aquesta orientació.

La primera condició és reorientar el sistema d'indicadors cap al procés assistencial i la trajectòria de la persona atesa, i deixar enrere un model d'avaluació centrat en categories diagnòstiques i volums d'activitat. Avançar en aquesta direcció requereix reconèixer en els sistemes de registre altres criteris —la formulació clínica del cas, la continuïtat terapèutica, la trajectòria assistencial, els factors contextuais rellevants— i dotar-los del mateix estatut institucional que avui té la categoria diagnòstica.

La segona condició és de mètode: qualsevol indicador nou que s'incorpori al sistema d'avaluació hauria d'anar acompanyat d'una previsió explícita de quina activitat desplaçarà i d'una valoració sobre si aquest desplaçament resulta clínicament acceptable. En un sistema

amb recursos finits, cada indicador prioritza un tipus d'activitat i reassigna temps professional prèviament compromès amb una altra. Fer visible aquesta reassignació —abans d'introduir l'indicador, no després de constatar-ne els efectes— és una condició de la planificació.

En aquesta direcció, l'AQuAS va publicar el 2024 un document de consens sobre indicadors per a l'avaluació de l'atenció integrada en salut mental i addiccions, elaborat mitjançant un procés Delphi amb 215 professionals del sistema. La llista prioritzada de 27 indicadors s'orienta cap al procés assistencial i la trajectòria de la persona atesa, i inclou dimensions com la coordinació amb serveis socials, la disponibilitat de recursos comunitaris, la detecció precoç, la continuïtat en les transicions entre dispositius, el pla individual d'atenció compartit, la figura del professional referent i els sistemes d'informació integrats. Alguns indicadors per captar les dinàmiques descrites en aquest informe —la periodicitat del seguiment, la proporció entre primeres visites i seguiments, la rotació de professionals— van ser valorats com a rellevants però no han arribat a incorporar-se a la pràctica.

PROPOSTA D'INDICADORS BÀSICS PER A LA XARXA DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS

Relació entre primeres visites i visites de seguiment. Proporció de visites de seguiment sobre el total i proporció de persones que mantenen seguiment estable. Permet valorar si el sistema prioritza l'obertura de nous casos sobre la continuïtat.

Qualitat de vida relacionada amb la salut. Valoració subjectiva del funcionament social, físic, cognitiu i del benestar emocional, mitjançant instruments estandarditzats.

Experiència de l'atenció rebuda. Valoració per la mateixa persona atesa dels processos assistencials.

Funcionalitat o capacitat funcional. Grau d'autonomia per a les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària.

Inclusió social, laboral i acadèmica. Grau en què les persones ateses mantenen o recuperen la seva activitat social, laboral o acadèmica.

Professionals per perfil. Equivalents a temps complet per perfil —psiquiatria, psicologia clínica, infermeria, treball social, teràpia ocupacional, educació social— en relació amb la població.

Qualitat de vida professional. Satisfacció dels professionals amb la seva situació laboral, mitjançant instruments estandarditzats.

Rotació de professionals. Proporció d'altres i baixes en relació amb el nombre de professionals de l'equip en un període determinat.

Supervisió clínica. Percentatge de professionals amb accés regular a supervisió clínica i freqüència efectiva.

Formació continuada interna. Hores anuals de sessions clíniques, formació interna i participació en programes formatius per professional i dispositiu.

Tots els indicadors d'activitat que es poden compondre d'aportacions de diferents perfils professionals s'han de publicar desagregats per perfil. La dada agregada de visites en un CSMA no permet distingir si una persona ha rebut al llarg de l'any tres visites amb psiquiatria, quatre amb psicologia clínica i set amb infermeria, i la composició efectiva és decisiva per avaluar el tipus d'atenció prestada. Sense aquesta desagregació, el sistema d'informació pot mostrar volums elevats d'activitat agregada que oculten asimetries rellevants en l'accés a cada perfil professional.

La incorporació d'indicadors sobre l'activitat de l'equip —supervisió, coordinació interna i externa, formació continuada— no és un afegit secundari. En salut mental, l'equip és la unitat efectiva de treball. Les dimensions del treball en equip que el capítol d'efectes descriu com a progressivament desplaçades —supervisió, discussió de casos, coordinació amb altres dispositius, formació interna— són precisament les que el sistema actual no reconeix com a activitat. El que no es registra deixa d'existir des del punt de vista institucional: els indicadors proposats fan visible aquesta dimensió i permeten avaluar si els dispositius disposen efectivament del temps necessari per sostenir-la.

És necessari, a més, establir mecanismes per conèixer l'estat clínic de les persones que es troben en llista d'espera per a una primera visita. Com s'ha descrit en el

capítol d'efectes, les llistes d'espera constitueixen un punt cec del sistema: aquest no disposa d'informació sobre com evolucionen les persones durant el període d'espera. Incorporar mecanismes senzills de seguiment durant l'espera —un contacte telefònic o una valoració breu a intervals definits— permet ajustar la resposta a l'evolució real de cada situació i redueix el risc de cronificació o d'abandonament.

L'avaluació interna del funcionament dels serveis s'ha de completar amb indicadors sobre les condicions de treball dels equips. La qualitat de l'atenció depèn de manera directa de les condicions en què treballen els qui la presten, i sense informació sistemàtica sobre aquestes condicions la planificació opera amb un altre punt cec rellevant: detecta caigudes en el volum d'activitat o augments en els temps d'espera, però no els processos que els precedeixen i que s'haurien pogut corregir abans. Aquests indicadors haurien de contemplar almenys les taxes d'absentisme per tipus i durada, desagregades per dispositiu i perfil professional; la càrrega assistencial mitjana i màxima per professional i tipus de dispositiu; els resultats de les avaluacions de risc psico-social realitzades en compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals; i el grau de participació efectiva dels equips en les decisions sobre organització del treball.

La possibilitat d'incorporar indicadors com els propostats depèn de l'estat dels sistemes informàtics de registre. Com s'ha descrit en el capítol de mecanismes, els aplicatius actuals estan dissenyats principalment per extreure informació útil al control institucional de l'activitat i molt menys per facilitar el treball clínic quotidià. La seva revisió hauria de partir d'una premissa inversa: el sistema informàtic ha de servir els professionals que l'utilitzen, no els qui des de fora tracten de controlar l'activitat del sistema. Això implica simplificar l'entrada de dades, eliminar duplicacions, permetre registres narratius que recullin la complexitat del treball clínic i integrar la informació dels diferents dispositius pels quals passa una persona atesa.

Redissenyar els aplicatius en aquesta direcció permet a més abordar la càrrega de treball que el sistema actual d'indicadors ha desplaçat sobre els professionals assistencials. La incorporació de nous indicadors no s'hauria de sumar a aquesta càrrega: els recursos tècnics disponibles permeten automatitzar bona part de la recollida d'informació —qüestionaris breus enviats al telèfon mòbil, contactes automatitzats de seguiment, valoracions posteriors a una alta, integració directa de les respostes en la història clínica—. El treball d'avaluació

correspon als sistemes d'informació, no al temps clínic dels professionals.

Les dades produïdes pel sistema d'informació s'han de publicar de manera transparent i amb accés públic real. Això exigeix tres condicions: publicació sistemàtica i periòdica del conjunt d'indicadors recollits, amb desagregació territorial, per dispositiu, per entitat proveïdora i per perfil professional; accessibilitat efectiva per a la ciutadania, els professionals i les organitzacions del sector, en formats oberts i comparables; i publicació del catàleg complet dels indicadors que el sistema recull, amb la seva definició operativa. El que un sistema mesura defineix com s'organitza; tenir accés públic a aquesta llista permet el debat informat sobre l'orientació del sistema.

El disseny dels sistemes d'informació i la selecció d'indicadors no són qüestions purament tècniques. Convé establir mecanismes estables perquè professionals i persones ateses participin en l'avaluació de l'atenció i de les polítiques implementades. La qualitat dels indicadors depèn també de qui els defineix i de qui els interpreta: incorporar la mirada dels qui reben l'atenció i dels qui la presten permet identificar dimensions de qualitat que no són visibles des del registre administratiu.

■ 6.6. Sobre la recerca clínica

Els apartats anteriors han abordat quina activitat es realitza i com es mesura. Queda fora del sistema d'informació actual una pregunta diferent i complementària: si el que es fa funciona, per a qui, en quines condicions i amb quins resultats. El sistema català de salut mental disposa d'informació detallada sobre el volum d'activitat però manca de mecanismes sistemàtics per avaluar l'efectivitat real de les intervencions en la pràctica habitual. La mateixa capacitat d'un sistema per preguntar-se sistemàticament si el que fa produeix els resultats que declara és, per si mateixa, un indicador de qualitat.

La distància entre l'evidència generada en condicions experimentals i la pràctica clínica quotidiana és una limitació reconeguda internacionalment. Els assajos clínics controlats aporten informació sobre l'eficàcia de les intervencions en condicions controlades, però diuen poc sobre el seu funcionament en les condicions reals del sistema. Les xarxes de recerca basada en la pràctica s'han desenvolupat en les últimes dues dècades per produir coneixement sobre el que passa en l'atenció real (McMillen et al., 2009; Castonguay et al., 2013), mitjan-

çant la col·laboració estructurada entre dispositius assistencials i equips de recerca (Tansella i Thornicroft, 2009).

Aplicat al context català, aquest enfocament permetria abordar preguntes que avui queden sense resposta. Quina intensitat i freqüència de seguiment s'associen a millor evolució clínica per als problemes més prevalents. Quins resultats produeix l'activitat dels diferents recursos o programes —CSMA, CSMIJ, PAE-TPI, CRS, PCP, RBEC, Equips Guia, hospitalització domiciliària, equips de crisi— en termes de l'objectiu que declara cadascun. Quines intervencions —individuals, grupals, familiars i multifamiliars, farmacològiques, de rehabilitació psicosocial, de gestió de casos, d'atenció a la crisi— obtenen millors resultats, per a quins perfils i en quines condicions. Quin paper exerceixen els determinants socials en l'evolució dels processos atesos.

A aquestes preguntes s'hi afegeix una de diferent: no ja quines intervencions funcionen, sinó com es duen a terme. Que una intervenció disposi d'eficàcia demostrada en condicions controlades no garanteix que conservi aquest efecte en la forma en què el sistema pot oferir-la.

Estudiar-ho de manera sistemàtica permetria identificar quines intervencions mantenen un efecte apreciable en contextos no ideals i quines són les condicions mínimes per sota de les quals una intervenció deixa de ser, en rigor, aquesta intervenció. La psicoteràpia ofereix un exemple clar: la pregunta útil per a la planificació no és només si funciona, sinó fins a quin punt es pot espaiar la freqüència o acurtar la durada de les sessions conservant un efecte raonable, i a partir de quin llindar el que s'ofereix deixa de poder considerar-se psicoteràpia.

És important també atendre la dimensió territorial. La realitat assistencial d'una zona rural de baixa densitat, on la xarxa de suport informal pot tenir més pes i l'accés a recursos especialitzats és més limitat, no és la mateixa que la d'un dispositiu metropolità amb alta rotació i més fragmentació entre entitats. El que funciona en un context pot no funcionar —o funcionar de manera diferent— en un altre. Una recerca organitzada en la xarxa permet identificar aquestes diferències i orientar la planificació en funció del territori, en lloc d'aplicar models uniformes a realitats diferents.

Perquè aquest tipus de recerca se sostingui en el temps, ha de complir tres condicions. La primera és el reconeixement del temps dedicat: la participació dels professionals no pot ser una sobrecàrrega afegida, sinó temps reconegut i planificat dins de la jornada. La segona és el suport metodològic: vincular els dispositius assistencials amb grups de recerca universitaris i amb l'estructura

tècnica del mateix sistema. La tercera és la integració amb els sistemes d'informació: les dades necessàries per avaluar resultats s'han de poder obtenir, en la mesura del possible, a partir dels registres ja existents i no mitjançant formularis addicionals que recaiguin sobre el temps clínic.

La incorporació de la veu de les persones ateses i del seu entorn és una condició de qualitat del disseny mateix de la recerca. El que compta com un bon resultat en salut mental no s'esgota en la reducció simptomàtica: inclou dimensions com la capacitat de reprendre la vida quotidiana, la qualitat del vincle terapèutic o l'experiència de l'atenció rebuda. Definir les preguntes de recerca i els criteris de resultat comptant amb les persones ateses, els seus familiars i els professionals —i no únicament amb l'administració i l'àmbit acadèmic— produeix coneixement més rellevant (Wallcraft i Bryant, 2003; INVOLVE, 2012; Hayes et al., 2023).

La recerca així entesa no és una activitat complementària de l'assistència ni un terreny reservat a unitats específiques: és un component del mateix sistema assistencial, la manera en què el sistema s'observa a si mateix, identifica què funciona, què no funciona i on orientar el creixement. En la seva absència, el sistema queda sense més criteri per decidir la seva evolució que la inèrcia organitzativa, la pressió política conjuntural o la valoració subjectiva dels qui el gestionen.

■ 6.7. Sobre el model assistencial, la xarxa comunitària i l'articulació intersectorial

Assumir que no tots els problemes que arriben a salut mental tenen solució clínica individual, i reforçar la coordinació intersectorial amb habitatge, treball, serveis socials, educació i l'àmbit legal. Dotar l'atenció primària de recursos, temps i suport d'acord amb el seu paper central en salut mental. L'atenció primària és, en els sistemes sanitaris que funcionen, l'eix que garanteix longitudinalitat, accessibilitat i integralitat (Starfield et al., 2005); reforçar la seva orientació comunitària —en la línia de l'atenció primària orientada a la comunitat (Kark, 1981)— permet que part del malestar s'abordi fora del circuit clínic quan el seu origen és fora d'ell. Simplificar els circuits assistencials, reduint la fragmentació i la proliferació de programes parcials que dificulten la continuïtat. Reconèixer i valorar el treball comunitari com a activitat assistencial, incloent-lo en els sistemes de registre i en els indicadors, de manera

que els professionals no hagin de triar entre el treball amb la comunitat i el compliment d'indicadors.

Comunicació honesta amb la població

Comunicar a la població, amb claredat i sense paternalisme, què pot i què no pot oferir el sistema públic de salut mental amb els recursos de què disposa. La ciutadania és perfectament capaç d'entendre que un sistema amb plantilles limitades i agendes saturades no pot oferir una psicoteràpia de freqüència setmanal a qualsevol persona que la sol·liciti, ni pot absorbir tot el malestar contextual que es canalitza cap als serveis sanitaris. Aquesta comunicació honesta té una conseqüència política important: si es vol ampliar la cartera de serveis efectivament accessible, això requereix decisions d'inversió i de contractació, no campanyes de visibilització que prometen el que el sistema no pot donar. Anunciar a la població el que no és possible oferir en condicions reals augmenta la demanda cap a un sistema

que no pot absorbir-la, i trasllada als professionals la responsabilitat de negar, en cada consulta, el que la institució ha promès en l'espai públic.

Funció certificadora del sistema sanitari

Reordenar la funció certificadora del sistema sanitari en salut mental. L'accés a determinades prestacions —incapacitat temporal i permanent, grau de discapacitat, ajudes, exempcions, reconeixements administratius— requereix informes mèdics o psicològics l'elaboració dels quals consumeix una part significativa del temps assistencial. Convé revisar quines prestacions requereixen efectivament un informe de l'àmbit sanitari i quines es podrien acreditar per altres vies, i dotar els professionals de circuits específics per a l'elaboració dels informes que continuïn sent necessaris.

En el terreny específic de l'avaluació d'incapacitats i discapacitats, les valoracions de l'ICAM, les propostes d'alta de les mútues, les resolucions de l'INSS i els dictàmens del CAD haurien de recolzar-se en criteris objectius, clars i públics, aplicats de manera uniforme. La qualitat de l'avaluació es veuria reforçada amb mecanismes dissenyats per reduir biaixos: avaluacions independents per més d'un professional, amb incentius al compliment de criteris compartits i on l'indicador d'èxit sigui el rigor tècnic de cada valoració, no el volum de reconeixements denegats. Perquè això sigui operativament possible, els organismes avaluadors han de disposar de plantilles suficients i de temps raonable per a cada valoració. Les persones avaluades no poden quedar en una situació prolongada d'incertesa, esperant mesos sense saber quina resolució recaurà sobre el seu cas.

Convé a més clarificar la relació entre les valoracions del circuit avaluador i els informes que emeten els professionals clínics que atenen la persona. Aquests informes descriuen, des de la posició assistencial, la situació de la persona; no són informes pericials i no s'haurien de tractar com a tals. Quan la informació clínica disponible es considera insuficient per resoldre la valoració, correspondria al mateix organisme avaluador aprofundir en l'avaluació amb els seus propis mitjans, no retornar a la persona o al sistema assistencial la càrrega d'aportar proves addicionals. Una lògica anàloga s'aplica al sistema judicial i a altres àmbits que es relacionen amb la salut mental.

Ús clínicament fonamentat dels psicofàrmacs

Promoure un ús clínicament fonamentat dels psicofàrmacs. Les taxes de consum d'antidepressius i ansiolítics a Catalunya se situen en valors elevats, atribuïbles en part a respostes farmacològiques a malestars l'origen dels quals és contextual, social o vital. Reduir aquesta tendència no s'aconsegueix principalment mitjançant campanyes adreçades a la població general, sinó dotant els professionals d'atenció primària i de la xarxa especialitzada de les condicions de temps, formació i suport necessàries per oferir alternatives no farmacològiques quan aquestes són les indicades, i articulant amb serveis socials, habitatge i ocupació les respostes que el sistema sanitari no pot oferir per si sol.

La salut mental no es determina només en el sistema sanitari

El conjunt de propostes d'aquest capítol es tanca amb una constatació que travessa tot l'informe i que convé formular de manera explícita: la major part d'allò que determina la salut mental de la població no és dins del sistema sanitari de salut mental. És en els valors i les formes culturals amb què cada societat reconeix, expressa i acull el malestar. És en la qualitat dels vincles comunitaris, en els espais públics on s'elabora col·lectivament el patiment, en el teixit associatiu, en les xarxes familiars i d'amistat. És en les condicions materials de vida —habitatge, ocupació, ingressos— i en la fortalesa de les xarxes públiques que les garanteixen. És en el sistema educatiu, en el sistema judicial, en els serveis socials, en les polítiques culturals.

La major part d'allò que determina la salut mental de la població no és dins del sistema sanitari.

El sistema sanitari de salut mental pot atendre bé o atendre malament els qui arribin a les seves portes, i això és una responsabilitat que no es pot eludir; però no pot substituir tota la resta. Millorar la salut mental a Catalunya és, en última instància, una tasca de la societat en el seu conjunt, i exigeix decisions polítiques que van molt més enllà de l'àmbit sanitari. Reconèixer aquest horitzó ampli no dilueix les responsabilitats pròpies del sistema, però les situa al seu lloc.

7. Tancament

Bona part del que aquí s'ha descrit forma part de l'experiència quotidiana de qui treballa a la xarxa i de les persones que la utilitzen. Són aspectes dels quals existeix consciència, però que tendeixen a assumir-se com a condicions donades, com a trets inevitables del funcionament del sistema, i precisament per això rarament s'expliciten o es sotmeten a examen. Arriben poc als informes, les jornades tècniques o els espais on s'analitza el sistema i es prenen les decisions. El que aquest document ha volgut és fer-los explícits: allò que passa entre els recursos que s'hi destinen i l'atenció que finalment rep una persona.

No es tracta d'assenyalar voluntats, sinó de descriure una lògica: com funciona el sistema i els efectes que aquest funcionament produeix, amb independència de les intencions de qui el sosté. Fer visible aquesta lògica és el que permet sotmetre-la a anàlisi, en lloc d'assumir-la com una premissa no qüestionada.

Aquest informe no aspira a ser exhaustiu. S'ha centrat en un conjunt de qüestions d'ordre estructural i ha deixat fora, de manera deliberada, altres d'igualment rellevants. No entra en els debats tècnics sobre els models d'intervenció i els enfocaments terapèutics, ni en les eines i recursos concrets del treball clínic, ni en les diferents maneres d'entendre i abordar el patiment psíquic. Tampoc no aborda els drets de les persones

ateses, que mereixerien un desenvolupament propi, ni altres aspectes igualment importants que queden més enllà del seu abast. I, al costat de les qüestions que tracta, no hem recollit la mirada de tots els professionals i actors que intervenen a la xarxa, l'experiència i la perspectiva dels quals són imprescindibles per completar el quadre. No era el nostre propòsit —ni estava al nostre abast— abordar-ho tot, sinó aturar-nos en alguns aspectes que considerem especialment rellevants i dels quals, tanmateix, gairebé no es parla.

En aquesta mateixa línia, hem procurat que les propostes formulades siguin realistes i atentes a les condicions reals de la xarxa. Convé subratllar que diverses d'elles no requereixen un augment de la despesa: es poden posar en marxa amb decisions organitzatives i amb voluntat política.

Esperem que aquest document resulti útil i serveixi com a punt de partida des del qual continuar treballant. No pretén tenir l'última paraula, sinó obrir un debat sobre aquestes qüestions —un que pugui ser matisat, corregit i enriquit per altres actors de la xarxa, per l'administració i per les persones ateses. Com més veus se sumin a aquesta conversa, més completa serà la comprensió que compartim, i més afinades seran tant les preguntes que ens fem com les respostes a les quals arribem.

Referències bibliogràfiques

- AIFiCC. (2022, 12 d'abril). La infermeria familiar i comunitària, clau per enfortir l'atenció primària. <https://www.aificc.cat/2022/04/12/infermeria-familiar-comunitaria-clau-enfortir-atencio-primaria/>
- AIFiCC. (2026, 7 de maig). Posicionament del XVII Congrés. Inversió en atenció primària i reconeixement de la infermeria familiar i comunitària. <https://www.aificc.cat/2026/05/07/mes-de-600-infermeres-es-reuneixen-a-tarragona/>
- Ara. (2023). Epidèmia de salut mental: els CAP no poden atendre tothom. https://es.ara.cat/ciencia-tecnologia/neurociencia/epidemia-salud-mental-cap-no-atender_130_5440030.html
- Benavides, F. G., Torá, I., Martínez, J. M., Jardí, J., Manzanera, R., Alberti, C., & Delclós, J. (2010). Evaluación de la gestión de los casos de incapacidad temporal por contingencia común de más de 15 días en Cataluña. *Gaceta Sanitaria*, 24(3), 215–219. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112010000300007
- Bentall, R. P. (2009). *Doctoring the mind: Why psychiatric treatments fail*. Penguin Books.
- Bernardo, Á., & Álvarez del Vayo, M. (2021, 9 de març). Pagar o esperar: cómo Europa —y España— tratan la ansiedad y la depresión. *Civio*. <https://civio.es/sanidad/2021/03/09/acceso-a-la-salud-mental-en-europa-espana/>
- Bourdieu, P., i Wacquant, L. (2005). Una invitación a la sociología reflexiva. Siglo XXI. (Obra original publicada el 1992)
- Borges, M. (2025). El efecto Matrioska: Trabajo social y reducción de daños, la arquitectura de un modelo de intervención de personas para personas. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/393792911>
- Branley, A., & Byrne, M. (2012). How many psychologists do we need? *The Irish Psychologist*, 38, 136–138.
- British Psychological Society. (2004). Estimating the applied psychology demand in adult mental health. Division of Clinical Psychology.
- CAMFiC. (2018). Nota de prensa: el número de plazas MIR en MFyC ha bajado un 18% en los últimos años [Nota de premsa]. <https://www.camfic.cat/Actualitat.aspx?id=3565>
- Carnicé, A. (2023, 9 d'abril). Barcelona carece de psicólogos públicos: 900 para más de tres millones de habitantes. *Metrópoli Abierta*. https://metropoliabierta.elespanol.com/el-pulso-de-la-ciudad/20230409/barcelona-carece-de-psicologos-publicos-para-mas-tres-millones-habitantes/754924596_0.html
- Casamitjana i Aguilà, M. (2023a). Informe de les estratègies del PNSM entregat a la Taula el 15 desembre 2023. Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya.
- Casamitjana i Aguilà, M. (2023b). Informe I: Proposta de les estratègies del Pacte Nacional de Salut Mental i Benestar Emocional de Catalunya 2024-2030. Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència.
- Castelló, M., Fernández de Sanmamed, M. J., García, J., Mazo, M. V., Mendive, J. M., Rico, M., Rovira, A., Serrano, E., & Zapater, F. (2016). Atención a las personas con malestar emocional relacionado con condicionantes sociales en Atención Primaria de Salud. *Fòrum Català d'Atenció Primària*. <https://consaludmental.org/publicaciones/Atencion-personas-malestar-emocional.pdf>
- Castonguay, L. G., Barkham, M., Lutz, W., & McAleavey, A. A. (2013). Practice-oriented research: Approaches and applications. A M. J. Lambert (Ed.), *Bergin and Garfield's handbook of psychotherapy and behavior change* (6a ed., pp. 85–133). Wiley.
- Centre d'Investigacions Sociològiques. (2023). Baròmetre sanitari 2023: Tercera oleada (Estudi núm. 3426). Ministeri de Sanitat. <https://www.cis.es/es/estudios/barometro-sanitario-2023-tercera-oleada->
- Cofares. (2025, 10 d'octubre). La demanda de antidepressivos en las farmacias crece un 24% en el último año [Nota de premsa]. <https://www.cofares.es/-/crece-demanda-antidepressivos-farmacias>
- Conseil Supérieur de la Santé. (2019). DSM (5): The use and status of diagnosis and classification of mental health problems (Avis n° 9360).
- Consorci Sanitari del Maresme. (2023, 12 d'octubre). La nova figura del referent de benestar emocional a l'atenció primària, clau en la prevenció de problemes de salut mental [Notícia institucional]. <https://www.csdm.cat/ca/actualitat/noticies/2081/la-nova-figura-del-referent-de-benestar-emocional-a-l-atencio-primaria-clau-en-la-prevencio-de-problemes-de-salut-mental>
- Davies, J. (2022). Sedados: Cómo el capitalismo moderno creó la crisis de salud mental (M. Bofill Abelló, trad.). Capitán Swing.
- Defensor del Poble. (2019). Resolución: Demora de la eficacia de la resolución denegatoria del reconocimiento de incapacidad permanente hasta la fecha de su notificación a los interesados. <https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-de-la-eficacia-de-la-resolucion-denegatoria-del-reconocimiento-de-incapacidad-permanente-hasta-la-fecha-de-su-notificacion-a-los-interesados/>
- Departament de Salut. (2008). Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya: Volum 1. Els serveis per a la salut: Mirant cap al futur. Generalitat de Catalunya.
- Departament de Salut. (2020). Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. Memòria del Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. https://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/AppPHP/2020/pdf/VOL_P_MEM.pdf

- Departament de Salut. (2021a, agost). Programa PAICSAMA-EC. Equips GUIA: Equip Comunitari d'Atenció Intensiva a la Complexitat. Generalitat de Catalunya.
- Departament de Salut. (2021b, 8 d'octubre). Salut posa en marxa un programa per a l'abordatge comunitari del benestar emocional a través dels equips d'atenció primària [Nota de premsa]. Generalitat de Catalunya. <https://govern.cat/salaprensa/notes-premsa/414333/salut-posa-marxa-programa-la-bordatge-comunitari-del-benestar-emocional-traves-dels-equips-datencio-primaria>
- Departament de Salut. (2022). Pla director de salut mental i addiccions: actualització del marc estratègic i full de ruta 2022-2024. Generalitat de Catalunya. <https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/14092>
- Departament de Salut. (2023a). Pla funcional del Programa de Benestar Emocional i Salut Comunitària a l'Atenció Primària. Generalitat de Catalunya. <https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/10013>
- Departament de Salut. (2023b, 6 de febrer). Pressupost del Departament de Salut per a l'any 2023. Projecte. Generalitat de Catalunya. <https://govern.cat/govern/docs/2023/02/06/19/50/fe7ca356-0129-4b4f-a19b-d24d2671fb37.pdf>
- Departament de Salut. (2025). Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026. Memòria del Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. https://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/AppPHP/2026/pdf/VOL_P_MEM.pdf
- Division of Clinical Psychology. (2011). Good practice guidelines on the use of psychological formulation. The British Psychological Society. <https://doi.org/10.53841/bpsrep.2011.rep100>
- Duro Martínez, J. C. (2021). ¿Sabemos cuántos profesionales especialistas en psicología clínica trabajan en el Sistema Nacional de Salud Español? Papeles del Psicólogo, 42(2), 81–93. <https://doi.org/10.23923/pap.psicol.2955>
- Fernández-García, X. (2021). Situación de la psicología clínica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y perspectivas de crecimiento. Ansiedad y Estrés, 27, 31–40. <https://doi.org/10.5093/anyes2021a5>
- Generalitat de Catalunya. (2021, 9 de novembre). El Govern crea el Programa per a l'elaboració del Pacte Nacional de Salut Mental [Nota de premsa]. <https://govern.cat/salaprensa/notes-premsa/415391/el-govern-crea-el-programa-per-a-l-elaboracio-del-pacte-nacional-de-salut-mental>
- Giménez-Salinas i Colomer, E. (2026). Informe al Parlament 2025. Recull anual de totes les actuacions de la institució del Síndic de Greuges (2 vols.). Síndic de Greuges de Catalunya.
- Govern de la Generalitat de Catalunya. (2022, 26 de setembre). La I Jornada de treball de referents de benestar emocional exposa la importància de la vinculació d'aquests professionals amb la comunitat [Nota de premsa].
- Govern de la Generalitat de Catalunya. (2024, 10 d'octubre). President Illa: «El Pacte Nacional de Salut Mental és la primera estratègia d'Europa que inclou tots els departaments, entitats, municipis i societat civil» [Nota de premsa]. <https://govern.cat/salaprensa/notes-premsa/645442/president-illa-el-pacte-nacional-salut-mental-primera-estrategia-deuropa-que-inclou-tots-departaments-entitats-municipis-societat-civil>
- Govern de la Generalitat de Catalunya. (2025a, 9 de maig). Olga Pané: «El nostre sistema de salut afronta reptes que necessiten recursos però també reformes» [Nota de premsa]. <https://govern.cat/gov/notes-premsa/705982/olga-pane-el-nostre-sistema-de-salut-afronta-reptes-que-necessiten-recursos-pero-tambe-reformes>
- Govern de la Generalitat de Catalunya. (2025b, 10 d'octubre). La salut mental ens interpel·la a tots, ens toca continuar treballant units per millorar-la [Nota de premsa]. <https://govern.cat/gov/notes-premsa/752092/president-illa-la-salut-mental-ens-interpella-a-tots-ens-toca-continuar-treballant-units-per-millorar-la>
- Hilarión, P., & Espallargues, M. (2024). Consens d'indicadors per a l'avaluació de l'atenció integrada en salut mental i addiccions. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/11950/consens_indicadors_atencio_integrada_salut_mental_addiccions_2024.pdf
- Institut Català de la Salut. (s. d.). Programa de Benestar Emocional i Salut Comunitària a l'Atenció Primària. <https://ics.gencat.cat/>
- Institut d'Estadística de Catalunya. (2024). Defuncions per suïcidi. Sèries històriques 2015–2023. Generalitat de Catalunya. <https://www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15594&t=202200&col=5>
- Institut Nacional d'Estadística. (2025). Defunciones según la causa de muerte. Año 2024 (datos provisionales). <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/pEDCM2024.htm>
- INVOLVE. (2012). Briefing notes for researchers: Public involvement in NHS, public health and social care research. National Institute for Health Research. <https://www.invo.org.uk/>
- Prefectura de l'Estat. (2003, 22 de novembre). Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries. Boletín Oficial del Estado, 280, 41442–41458. <https://www.boe.es/eli/es/l/2003/11/21/44>
- Prefectura de l'Estat. (2011, 5 d'octubre). Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública. Boletín Oficial del Estado, 240, 104593–104626. <https://www.boe.es/eli/es/l/2011/10/04/33>
- Johnstone, L., & Boyle, M. (2018). The Power Threat Meaning Framework: An alternative nondiagnostic conceptual system. Journal of Humanistic Psychology. <https://doi.org/10.1177/0022167818793289>
- Jones, N., Callejas, L., Brown, M., Colder Carras, M., Croft, B., Pagdon, S., Sheehan, L., Oluwoye, O., & Zisman-Ilani, Y. (2023). Barriers to meaningful participatory mental health

- services research and priority next steps: Findings from a national survey. *Psychiatric Services*, 74(9), 902–910. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.20220514>
- Kark, S. L. (1981). *The practice of community-oriented primary health care*. Appleton-Century-Crofts.
- Kirkbride, J. B., Anglin, D. M., Colman, I., Dykxhoorn, J., Jones, P. B., Patalay, P., Pitman, A., Sonesson, E., Steare, T., Wright, T., & Griffiths, S. L. (2024). The social determinants of mental health and disorder: evidence, prevention and recommendations. *World Psychiatry*, 23(1), 58–90. <https://doi.org/10.1002/wps.21160>
- McKinsey Health Institute. (2022). *Investing in the future: How better mental health benefits everyone*. McKinsey & Company.
- McMillen, J. C., Lenze, S. L., Hawley, K. M., & Osborne, V. A. (2009). Revisiting practice-based research networks as a platform for mental health services research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 36(5), 308–321. <https://doi.org/10.1007/s10488-009-0222-2>
- Metges de Catalunya. (2021, 16 d'agost). MC insta Salut a complir la LOPS i a evitar la incorporació de psicòlegs sense especialitat clínica a l'atenció primària [Comunicat]. <https://metgesdecatalunya.cat/ca/actualitat/noticies/mc-insta-a-salut-a-cumplir-la-lops-y-a-evitar-la-incorporacion-de-psicologos-sin-especialidad-clinica-en-la-atencion-primaria>
- Ministeri de la Presidència. (2008, 21 de febrer). Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut. *Boletín Oficial del Estado*, 45, 10020–10035.
- Ministeri de la Presidència. (2013, 16 de maig). Ordre PRE/861/2013, de 9 de maig, per la qual s'estableixen els requisits d'acreditació de les unitats docents multiprofessionals per a la formació d'especialistes en infermeria familiar i comunitària i en medicina familiar i comunitària. *Boletín Oficial del Estado*, 117, 36728–36755. <https://www.boe.es/eli/o/2013/05/09/pre861>
- Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica. (2023, 4 de març). Ordre PCM/205/2023, de 2 de març, per la qual s'aproven i publiquen els programes formatius de les especialitats de Psiquiatria i Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència, els criteris d'avaluació dels especialistes en formació i els requisits d'acreditació de les Unitats Docents Multiprofessionals de salut mental. *Boletín Oficial del Estado*, 54, 32231–32291. <https://www.boe.es/eli/es/o/2023/03/02/pcm205>
- Ministeri de Sanitat. (2023). Informe anual del Sistema Nacional de Salut 2023. <https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnSNS.htm>
- Ministeri de Sanitat. (2024). Informe de evaluación sobre el impacto de la Primera Reforma del Componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el Sistema Nacional de Salud. Govern d'Espanya. <https://www.sanidad.gob.es/areas/atencionPrimaria/campanaImpulso/laPrimariaEnDatos/>
- Ministeri de Sanitat i Consum. (1998, 17 de desembre). Reial decret 2490/1998, de 20 de novembre, pel qual es regula la creació i l'exercici del títol oficial de Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica. *Boletín Oficial del Estado*, 288, 41135–41138. <https://www.boe.es/eli/es/rd/1998/11/20/2490>
- Ministeri de Sanitat i Consum. (2007). *Estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud*, 2006.
- Mofokeng, T. (2025a, 17 de juliol). El personal de salud y asistencial y su juramento y defensa del derecho a la salud (A/80/184). Naciones Unidas, Asamblea General.
- Mofokeng, T. (2025b). Los trabajadores sanitarios y asistenciales como defensores del derecho a la salud (Informe A/HRC/59/48). Consell de Drets Humans, Naciones Unidas. https://digitallibrary.un.org/record/4083705/files/A_HRC_59_48-ES.pdf
- Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. (2023). *Health at a Glance 2023: OECD Indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/7a7afb35-en>
- Parlament de Catalunya. (2026, 8 d'abril). Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, XV legislatura, cinquè període, núm. 457. <https://www.parlament.cat/document/bopcf/445063571.pdf>
- Prado-Abril, J., Fernández-García, X., Barber, P., de la Vega, I., Vilagrà, R., & Fernández-Jiménez, E. (2025). How many specialists and residents in Clinical Psychology are required in the Spanish National Health System? A needs-based study. *Human Resources for Health*, 23(46). <https://doi.org/10.1186/s12960-025-01017-z>
- Presidència del Govern. (2021, 5 d'octubre). President Aragonès: «Estem plenament compromesos amb la salut mental» [Nota de premsa]. <https://govern.cat/gov/notes-premsa/414266/president-aragones-estem-plenament-compromesos-with-la-salut-mental>
- Pūras, D. (2017). Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health (A/HRC/35/21). Consell de Drets Humans de Naciones Unidas.
- Rutter, M., Kim-Cohen, J., & Maughan, B. (2006). Continuities and discontinuities in psychopathology between childhood and adult life. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 47(3–4), 276–295. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01614.x>
- semFYC. (2023). No hacer en salud mental (Document 47). http://www.semfyec.es/publicaciones/download_free_publication/126
- semFYC. (2025, 25 de juliol). ¿Qué papel tienen las y los médicos de familia en el abordaje de los problemas de salud mental? [Document de posicionament]. <https://www.semfyec.es/actualidad/que-papel-tienen-las-y-los-medicos-de-familia-en-el-abordaje-de-los-problemas-de-salud-mental->

- Servei Català de la Salut. (2024, 15 de març). Resposta a consulta al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya sobre la dotació de psicòlegs als CSMA i CSMIJ [Comunicació interna de l'associació].
- Servei Català de la Salut. (s. d.). Buscador de centres sanitaris: Atenció en salut mental [Base de dades]. Generalitat de Catalunya. Recuperat el 24 de maig de 2026, de https://catsalut.gencat.cat/ca/centres-sanitaris/cercador/?P_CER-CA=T&P_TIPUS_CENTRE=SMD
- Smit, E. H. (2023). The complexity of mental healthcare and its consequences for doing good [Tesi doctoral, Utrecht University]. UMC Repository. <https://doi.org/10.33540/19071468-0009.2005.00409.x>
- Starfield, B., Shi, L., i Macinko, J. (2005). Contribution of primary care to health systems and health. *The Milbank Quarterly*, 83(3), 457–502. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00409.x>
- Tansella, M., & Thornicroft, G. (2009). Implementation science: Understanding the translation of evidence into practice. *The British Journal of Psychiatry*, 195(4), 283–285. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.109.065565>
- Timimi, S. (2026). Qué es ser normal: Salud mental, sufrimiento psicológico y neurodiversidad (P. Alba Navarro, Trad.). Debate.
- Tristany, J. (2024, 5 de novembre). Modelo de atención a la salud mental en Catalunya [Seminari web]. Seminario Web RECS'24: Salud mental en la esfera local, Generalitat de Catalunya, Departament de Salut.
- Tudor Hart, J. (1971). The inverse care law. *The Lancet*, 297(7696), 405–412. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(71\)92410-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(71)92410-X)
- Vázquez Canales, L. de M. (Coord.). (2023). No hacer en salud mental. Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC). <https://www.semfyc.es/publicaciones/doc-47-no-hacer-en-salud-mental>
- Wallcraft, J., & Bryant, M. (2003). The mental health service user movement in England (Policy Paper 2). The Sainsbury Centre for Mental Health.

ANNEX

Nota metodològica sobre l'enquesta

Aquest annex presenta una nota metodològica breu sobre l'enquesta a professionals utilitzada com una de les tres fonts de l'informe (juntament amb el grup de treball i la revisió documental). L'anàlisi completa de l'enquesta —descriptius per bloc temàtic, anàlisi per subgrups demogràfics, anàlisi qualitativa de les respostes obertes i repositori de cites verbatim— es publica en el document tècnic complementari citat a la pàgina de crèdits.

Fitxa tècnica

Concepte	Detall
Títol del qüestionari	Percepció professional sobre el funcionament de la xarxa pública de salut mental a Catalunya
Període de recollida	Març – abril de 2026
Univers	Especialistes en Psicologia Clínica (PEPC) i residents PIR de Catalunya
Tipus de mostreig	Mostra de conveniència distribuïda per canals associatius (SCPC-ACAPIR)
N de respostes vàlides	146
Composició de la mostra	80,8% psicòlegs clínics adjunts (PEPC); 17,8% residents PIR; 1,4% altres
Cobertura territorial	Totes les regions sanitàries de Catalunya. Predominen: Barcelona Ciutat (29,5%), Metropolitana Nord (24,7%), Metropolitana Sud (18,5%), Girona (14,4%)
Distribució per experiència	<5 anys: 27,4%; 5–10 anys: 22,6%; 10–20 anys: 31,5%; 20–30 anys: 14,4%; >30 anys: 4,1%
Distribució contractual	Indefinit: 75,3%
Instrument	Qüestionari Google Forms amb 54 ítems: 31 Likert 1–5, 2 categòrics, 6 quantitatius, 8 oberts. Temps estimat d'emplenament: 15–20 min

Tractament de les dades

L'anàlisi quantitativa s'ha realitzat en Python amb la llibreria pandas. Per a cada ítem Likert s'ha definit una polaritat analítica que permet calcular un percentatge unificat de «suport a l'argument» de l'informe, directament comparable entre ítems. Les dades quantitatives sobre temps i freqüències s'han depurat de valors anòmals per confusió d'unitats (p. ex. minuts vs. segons); s'han retallat els temps superiors a 300 minuts i eliminat valors inferiors a 10 minuts per a primera visita o 5 minuts per a successives. L'anàlisi qualitativa de les 583 respostes obertes s'ha realitzat mitjançant codificació temàtica mixta (automatitzada amb expressions regulars i revisió manual posterior).

Decisions analítiques que convé conèixer

Xarxa ambulatoria troncal. Quan l'informe es refereix a la freqüència de seguiment en la «xarxa ambulatoria troncal» (capítols 4 i 5), l'anàlisi es restringeix a professionals que treballen exclusivament en CSMA o CSMIJ, sense combinacions amb altres dispositius (N=70 de 146). Aquest filtre aïlla el context del tractament psicològic de continuïtat i evita que les medianes es desplacin per perfils diferents (hospitalització, hospital de dia, urgències).

Subgrup CSMIJ. Quan es reporta la dada del 39% amb seguiments superiors a 60 dies en CSMIJ, el subgrup es restringeix als especialistes en Psicologia Clínica (PEPC) que treballen en CSMIJ, després d'excloure les respostes inferiors a 5 dies per probable interpretació diferent de la pregunta (N=28). L'objectiu és caracteritzar la realitat de la xarxa infantojuvenil amb dades depurades.

Àmbit comunitari vs. hospitalari+enllaç. La comparació entre professionals que treballen exclusivament en l'àmbit comunitari (CSMA, CSMIJ, atenció primària; N=80) i professionals que treballen exclusivament en l'àmbit hospitalari o d'enllaç (hospitalització/aguts, hospital de dia, interconsulta; N=37) integra la interconsulta dins del bloc hospitalari per la seva afinitat funcional. La diferència de propòsit clínic entre tots dos àmbits explica part de les divergències; les dades permeten identificar on es concentren les dinàmiques crítiques descrites.

■ Limitacions

Convé declarar les limitacions de l'enquesta de manera explícita perquè el lector pugui calibrar el pes de cada afirmació:

Mostreig. La mostra és de conveniència, distribuïda per canals associatius. Les respostes poden estar influïdes per biaixos propis de l'autoinforme, incloent-hi la interpretació subjectiva dels ítems, la variabilitat en el record o la disposició individual a respondre. Les dades no substitueixen les xifres administratives oficials: són percepcions professionals que aporten informació sobre l'experiència quotidiana de la xarxa, complementària a altres fonts.

N de subgrups. El N total (146) permet anàlisis robustes del conjunt, però alguns subgrups són reduïts i s'han d'interpretar amb cautela: residents PIR (N=26), contractes precaris/temporals (N=14), àmbit hospitalari+enllaç exclusiu (N=37), zones de baixa densitat/perifèriques (N=19) i professionals amb més de 20 anys d'experiència (N=27). En el cos de l'informe aquestes comparacions s'acompanyen del N corresponent.

Autoadministració. Totes les mesures són percepcions autoadministrades. La traducció de la percepció a evidència administrativa requereix triangulació amb dades oficials del Departament de Salut, CatSalut i AQUAS.

Convergència amb el document. El qüestionari presenta una elevada coincidència conceptual amb les hipòtesis de l'informe, la qual cosa és coherent amb el seu objectiu (verificar empíricament aquestes hipòtesis) però no permet considerar-lo una validació independent. El que és rellevant de les dades és la magnitud i la consistència de les respostes, no la seva mera convergència amb el diagnòstic.

■ Com s'incorpora l'enquesta a aquest informe

Les dades de l'enquesta s'incorporen a l'informe principal en requadres temàtics identificats amb la marca «Enquesta a professionals», intercalats amb el text descriptiu del capítol corresponent. Cada requadre recull únicament les xifres amb rellevància directa per a l'argumentació de la secció en què apareix. L'anàlisi quantitativa i qualitativa completa —incloent-hi les dades per subgrups, el repositori íntegre de cites verbatim i els descriptius dels 31 ítems Likert— està disponible en el document tècnic complementari, que es publicarà simultàniament amb aquest informe.

